

Bunga Rampai **PERAN PERAWAT KOMUNITAS**

Dalam Pencegahan Hipertensi Melalui Posbindu

Sukmah Fitriani • Maulina • Supriadi • Ardila Lailatul Barik
Antok Nurwidi Antara • Yourisna Pasambo • Hartin Suidah

Editor: Firmina Theresia Kora



BUNGA RAMPAI: PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI MELALUI POSBINDU

Penulis:

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Ns. Maulina, M.Kep., Sp.Kep.Kom

Ns. Supriadi, S.Kep., M.KM.

Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep

Antok Nurwidi Antara, S.Kep.Ns., M.Kep..

Yourisna Pasambo, Ners, M.Kes

Hartin Suidah, S.Kep., Ns., M.Kes

Editor:

Firmina Theresia Kora., S.Kep.Ns., M.P.H.



Bunga Rampai: Peran Perawat Komunitas Dalam Pencegahan Hipertensi Melalui Posbindu

Penulis:

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Ns. Maulina, M.Kep., Sp.Kep.Kom
Ns. Supriadi, S.Kep., M.KM.
Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep
Antok Nurwidi Antara, S.Kep.Ns., M.Kep..
Yourisna Pasambo, Ners, M.Kes
Hartin Suidah, S.Kep., Ns., M.Kes

Editor:

Firmina Theresia Kora., S.Kep.Ns., M.P.H.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-57-2

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, bunga rampai berjudul “Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi melalui Posbindu” ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran perawat komunitas pada upaya promotif dan preventif, khususnya dalam pencegahan hipertensi sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang sering berkembang tanpa gejala, namun dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak terdeteksi dan tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta tindak lanjut kasus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular atau Posbindu memiliki peran strategis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pemantauan faktor risiko, skrining tekanan darah, serta pembinaan perilaku hidup sehat secara berkesinambungan.

Bunga rampai ini membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pencegahan hipertensi melalui pendekatan keperawatan komunitas. Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan komunitas dan masalah hipertensi, dilanjutkan dengan peran perawat komunitas dalam pencegahan hipertensi melalui Posbindu. Selain itu, buku ini juga menguraikan pengkajian komunitas dan skrining tekanan darah, edukasi kesehatan tentang pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehat, serta pemberdayaan kader dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pencegahan hipertensi.

Lebih lanjut, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara perawat komunitas, Puskesmas, keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat dalam melakukan tindak lanjut terhadap kasus hipertensi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi tidak hanya berhenti pada kegiatan skrining, tetapi berlanjut pada perubahan perilaku, kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas juga menjadi bagian penting yang dibahas untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, kader

Posbindu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan program kesehatan masyarakat. Buku ini juga diharapkan mampu memperkaya wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran perawat komunitas dalam pencegahan hipertensi melalui pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN MASALAH HIPERTENSIS..... 1

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas.....	2
C. Masalah Hipertensi.....	9
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Komunitas Masalah hipertensi	12
E. Referensi	13
F. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSIS MELALUI POSINDU 16

Ns. Maulina, M.Kep., Sp.Kep.Kom.....	16
A. Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat	16
B. Simpulan	22
C. Referensi	22
D. Glosarium.....	24

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KOMUNITAS DAN SKRENING TEKANAN DARAH MELALUI POSBINDU.....25

Ns. Supriadi, S.Kep., M.KM.	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Konsep Dasar Pengkajian Komunitas	26
C. Pengertian Skrining Hipertensi	27
D. Dasar Kebijakan dan Pedoman Resmi.....	28
E. Sasaran Skrining Hipertensi	29
F. Tempat Pelaksanaan Skrining	29
G. Alat Dan Bahan Skrining Hipertensi.....	30
H. Data Yang Dikaji Dalam Skrining Hipertensi.....	31
I. Prosedur Teknik Pengukuran Tekanan Darah	32
J. Interpretasi Hasil Skrining	32
K. Tindak Lanjut Hasil Skrining.....	33

L. Evaluasi Program Skrining Hipertensi	34
M. Alur Pelayanan Skrining Hipertensi di Posbindu / Posyandu PMT	35
N. Peran Kader, Perawat, dan Puskesmas	36
O. Contoh SOP Singkat Skrining Hipertensi di Posbindu / Posyandu PMT	37
P. Contoh Format Pengkajian Skrining Hipertensi	38
Q. Contoh Indikator Evaluasi Program	38
R. Simpulan	39
S. Referensi	39
T. Glosarium	41

CHAPTER 4 EDUKASI KESEHATAN TENTANG POLA MAKAN, AKTIVITAS FISIK DAN GAYA HIDUP SEHAT 42

Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep.	42
A. Pendahuluan	42
B. Konsep Posbindu	43
C. Konsep dan Pencegahan Hipertensi	45
D. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Pola Makan Untuk Pencegahan Hipertensi	46
E. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Aktivitas Fisik Untuk Pencegahan Hipertensi	48
F. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Gaya Hidup Sehat Untuk Pencegahan Hipertensi	50
G. Referensi	52
H. Glosarium	55

CHAPTER 5 PEMBERDAYAAN KADER DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI 56

Antok Nurwidi Antara, S.Kep.Ns., M.Kep.	Error! Bookmark not defined.
A. Pendahuluan	56
B. Konsep Pemberdayaan Kader Kesehatan	56
C. Peran Kader dalam Pencegahan Hipertensi	62
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Hipertensi	65
E. Strategi Pemberdayaan Kader dan Masyarakat	65
F. Dampak Pemberdayaan Kader	66
G. Tantangan dan Solusi Pemberdayaan Kader	67
H. Simpulan	69
I. Referensi	69
J. Glosarium	71

CHAPTER 6 KOLABORASI PERAWAT KOMUNITAS PUSKESMAS DAN KELUARGA DALAM TINDAK LANJUT KASUS 72

Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes	72
A. Pendahuluan.....	72
B. Konsep Tindak Lanjut Kasus Hipertensi.....	73
C. Peran Perawat Komunitas dalam Tindak Lanjut Kasus Hipertensi	76
D. Peran Puskesmas dalam Pengendalian Hipertensi Berbasis Komunitas.....	77
E. Peran Keluarga dalam Tindak Lanjut Kasus Hipertensi.....	78
F. Model Kolaborasi Perawat Komunitas, Puskesmas, dan Keluarga.....	80
G. Penutup	84
H. Referensi	85

CHAPTER 7 EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN HIPERTENSI BERBASIS KOMUNITAS 89

Hartin Suidah, S.Kep., Ns., M.Kep.....	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Keperawatan Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi	91
C. Program Pencegahan Hipertensi Berbasis Komunitas	92
D. Evaluasi Program Pencegahan Hipertensi Berbasis Komunitas	94
E. Inovasi Dan Pengembangan Program	97
F. Instrument evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas.....	99
G. Kesimpulan.....	102
H. Referensi	103

PROFIL PENULIS 106

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN MASALAH HIPERTENSIS

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom

A. Pendahuluan

Sejarah perkembangan keperawatan kesehatan komunitas dimulai pada Tahun 1877 di Amerika Serikat. Francis Root melakukan kunjungan rumah kepada orang yang sakit dan pada Tahun 1885 dibentuklah Asosiasi Perawatan Kunjungan Rumah, perawat terlatih merawat orang miskin yang sakit dan memberikan instruksi pentingnya peningkatan sanitas rumah. Tahun 1893, Lilian Wald dan Wald dan Mary Brewster mendirikan layanan keperawatan kota Henry Street Settlement di Lower East Side, New York, dan menciptakan istilah perawat kesehatan masyarakat (Savage et al., 2023). Keperawatan kesehatan masyarakat berkembang pada abad ke 20 terjadinya perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari pelayanan perawatan individu di rumah sakit ke pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tokoh keperawatan yang berperan penting Florence Nightingale terhadap pengembangan keperawatan komunitas bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya perawatan pada satu individu namun ada faktor lingkungan seperti sanitas, kebersihan dan pola hidup sehat (Arna et al., 2024). Maka dari perkembangan tersebut perlunya keperawatan kesehatan komunitas dalam meningkatkan status kesehatan bukan hanya pada individu itu sendiri.

Keperawatan kesehatan komunitas adalah perpaduan antara praktik keperawatan dan praktik kesehatan publik dengan menggunakan ilmu keperawatan, sosial dan kesehatan masyarakat Nies, M.A., McEwen, M. (2019). Tujuan utama keperawatan kesehatan komunitas yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat secara luas dengan sasaran individu, keluarga, kelompok di dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan secara terpadu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi. Pelayanan kesehatan komunitas pada prinsipnya lebih menitikberatkan pada upaya kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah lebih baik dan pelayanan preventif dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak sakit atau terhindar dari penyakit. Di Indonesia, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan melalui di Puskesmas dan jaringannya serta didukung oleh fasilitas berbasis komunitas dan partisipasi

masyarakat seperti Poskesdes dan Posyandu yang tersebar di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun desa.

B. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keperawatan, keperawatan merupakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Pelayanan keperawatan juga dipahami sebagai bagian dari layanan kesehatan yang bersifat profesional dan terintegrasi, yang dilandasi oleh ilmu dan praktik keperawatan, serta ditujukan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keperawatan merupakan profesi kesehatan yang berfokus pada upaya membantu individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai serta mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup secara optimal (Ulutaşdemir, N. 2018; Almetari, A. 2024).

Definisi komunitas atau *community* dalam literatur keperawatan yaitu sekelompok orang yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki kesamaan kepentingan atau karakteristik tertentu, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, kesatuan, dan kepemilikan di antara anggotanya (Nies, M,A., McEwen, M., 2019). Komunitas adalah sekumpulan individu yang hidup dalam suatu kelompok sosial dan memiliki persamaan karakteristik, nilai, serta tujuan tertentu. Komunitas terdiri dari dua tipe utama yaitu komunitas geopolitik dan komunitas fenomenologi. Komunitas geopolitik merupakan bentuk komunitas yang paling umum dikenal dalam masyarakat. Jenis komunitas ini terbentuk berdasarkan wilayah geografis atau batas administratif, baik yang bersifat alami maupun buatan, seperti desa, kota, provinsi, hingga negara. Selain itu, wilayah seperti kecamatan, kode pos, jalur sensus, dan rukun tetangga juga termasuk dalam komunitas geopolitik. Sementara itu, komunitas fenomenologi lebih menitikberatkan pada hubungan sosial antaranggota yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam komunitas ini, keberadaan wilayah fisik tidak terlalu penting karena hubungan yang terjalin didasarkan pada persamaan budaya, nilai, sejarah, minat, maupun tujuan bersama. Contoh komunitas fenomenologi antara lain sekolah, politeknik, universitas, tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan kuil, serta berbagai organisasi dan kelompok sosial termasuk jaringan sosial Komunitas (Maurer dan Smith, 2013). Komunitas dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu. Kesamaan tersebut bisa berdasarkan lokasi tempat tinggal, ras, etnis, usia, pekerjaan, kesamaan minat dalam memecahkan masalah, tujuan yang sama, atau bentuk ikatan lainnya (Safitri, A., et all, 2024).

Keperawatan komunitas merupakan suatu bentuk praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang bersifat terpadu dan unik, yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kemampuan kesehatan individu maupun kelompok. Sasaran pelayanan ini mencakup perorangan, keluarga, kelompok khusus, hingga masyarakat secara luas, dengan cakupan layanan yang meliputi seluruh spektrum pelayanan kesehatan di komunitas (Arna et al, 2024). Keperawatan komunitas adalah praktik keperawatan yang diterapkan pada kelompok populasi, tidak terbatas umur, melalui promosi, pencegahan, pemeliharaan, pendidikan, manajemen, koordinasi, dan pelayanan berkelanjutan, dengan menggunakan proses asuhan keperawatan komunitas. Fokus tidak hanya pada individu yang sakit, tetapi juga lingkungan, komunitas, agregat, dan keluarga sebagai bagian dari komunitas (Safitri, A., et al, 2024). Konsep keperawatan komunitas menempatkan masyarakat sebagai mitra, dengan perawat berperan sebagai pendidik, koordinator, dan pemberdaya. Fokusnya adalah promotif–preventif, berbasis keluarga dan komunitas, sensitif budaya, dan berorientasi pada keadilan sosial untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian populasi. Menurut Savage et al. (2023) , Prinsip keperawatan komunitas yaitu:

1. Klien atau Sasaran pelayanan kesehatan adalah masyarakat.
2. Tanggung jawab utama yaitu mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara menyeluruh.
3. Proses dalam keperawatan komunitas melibatkan kerjasama antar perawat dengan klien sebagai mitra yang setara.
4. Pencegahan primer menjadi prioritas dalam merancang intervensi dan implementasi yang tepat.
5. Keperawatan komunitas berorientasi pada penerapan strategi yang mampu menciptakan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sehat, sehingga masyarakat dapat berkembang secara optimal.
6. Perawat komunitas berkewajiban secara aktif mengidentifikasi dan menjangkau semua orang yang mendapat manfaat dari aktivitas atau layanan tertentu.
7. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia harus dilakukan secara optimal untuk memastikan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
8. Kerja sama dengan berbagai profesi, masyarakat, organisasi, serta lintas sektor merupakan pendekatan yang efektif dalam upaya meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Ciri-ciri pelayanan keperawatan komunitas menurut Hithcock, Scubert & Thomas (1999); Allender, Rector & Warner, (2014); Stanhope & Lancaster (2016) adalah :

1. Pelayanan keperawatan komunitas merupakan integrasi antara pelayanan keperawatan dan kesehatan masyarakat.
2. Terdapat kesinambungan pelayanan kesehatan (*contibuity of care*)
3. Fokus intervensi mencakup upaya pencegahan pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
4. Terjadi kemitraan perawat dengan klien dalam upaya kemandirian klien.
5. Terjadi proses alih peran dari perawat kepada klien (individu, keluarga, kelompok, masyarakat) sehingga terjadi kemandirian.

Sasaran dalam keperawatan kesehatan komunitas meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kurangnya pengetahuan, rendahnya kemauan, serta keterbatasan kemampuan dalam menangani masalah kesehatannya. Ketidaktahuan terjadi ketika masyarakat belum memiliki informasi yang cukup tentang kesehatan. Ketidakmauan berkaitan dengan kurangnya kesadaran atau sikap positif untuk melakukan tindakan yang mendukung kesehatan. Sementara itu, ketidakmampuan terjadi ketika masyarakat sudah tahu dan mau, tetapi tidak dapat melakukan tindakan kesehatan karena keterbatasan sarana atau biaya (Nies, M,A., McEwen, M., 2019).

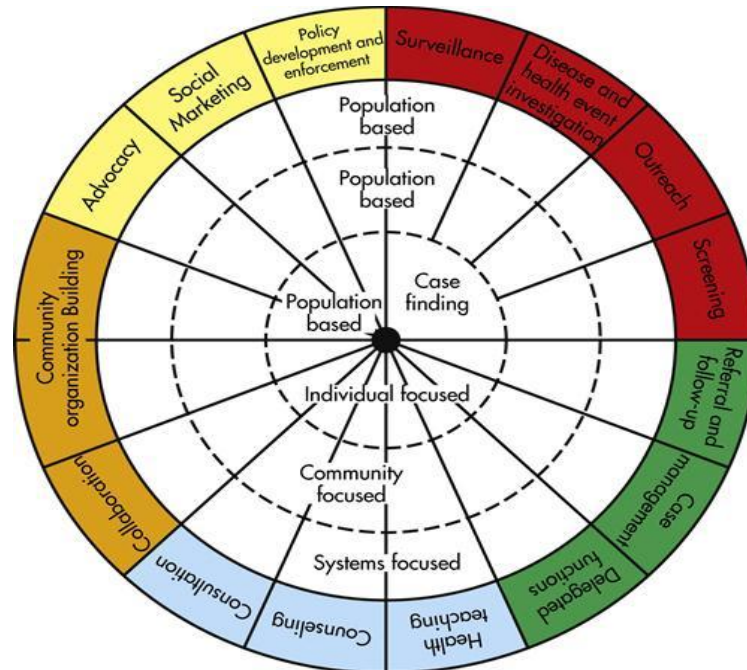
Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) adalah bentuk keperawatan komunitas di puskesmas yang menggabungkan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan komunitas, terutama secara promotif-preventif. Perkesmas merupakan upaya untuk memperluas akses serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tetap menjaga mutu layanan yang baik dan dilakukan secara berkesinambungan, terutama keluarga miskin/rawan kesehatan/risiko tinggi. Kegiatan dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung puskesmas: kunjungan rumah keluarga rawan, asuhan individu yang datang ke puskesmas, asuhan keluarga, dan kelompok khusus. Perkesmas mencakup upaya promotif dan preventif berkesinambungan, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif, menysasar individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat sebagai satu kesatuan proses asuhan keperawatan.

Roda intervensi kesehatan komunitas

Roda intervensi kesehatan komunitas merupakan ilustrasi grafis tentang praktik kesehatan komunitas berbasis populasi yang dikenal dengan "Model Minnesota" roda tersebut berasal perawat kesehatan komunitas pada *Minnnesota*

Departement of Health pada pertengahan tahun 1990-an untuk mendukung kontribusi keperawatan kesehatan masyarakat terhadap peningkatan praktik terhadap peningkatan kesehatan tingkat masyarakat.

Roda Intervensi Kesehatan Komunitas



Gambar 1.1

Roda intervensi kesehatan komunitas (Dimodifikasi dari Section of Public Health Nursing : Minnesota Departement of Health)

Roda intervensi keperawatan kesehatan komunitas mengintegrasikan 3 elemen yaitu :

1. berbasis populasi intervensi kesehatan masyarakat
2. Tiga level praktik kesehatan masyarakat :
 - a. Individu/ keluarga
 - b. Komunitas
 - c. Sistem
3. Tujuh belas intervensi kesehatan komunitas
 - a. *Surveillance*/pengawasan

Kegiatan ini merupakan pemantauan kejadian kesehatan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi kesehatan komunitas agar dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

- b. *Disease and health event investigation* / Penyelidikan penyakit dan kejadian terkait kesehatan.
Kegiatan mencari, mengumpulkan serta menganalisis data secara terstruktur mengenai ancaman kesehatan masyarakat untuk mengetahui sumber masalah, mengidentifikasi individu atau kelompok yang berisiko, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat.
- c. *Outreach* / populasi terbelakang
Kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan akses pelayanan kesehatan, sehingga yang membutuhkan perhatian khusus kemudian memberikan informasi mengenai masalah kesehatan, cara penanganannya, serta akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. *Screening* / pemeriksaan
Pemeriksaan atau penilaian untuk mengidentifikasi individu dengan faktor risiko, atau masalah kesehatan yang belum dikenali atau kondisi penyakit tanpa gejala.
- e. *Case Finding* / Penemuan kasus
Mengidentifikasi dan Menemukan individu dan keluarga dengan faktor risiko, masalah kesehatan di masyarakat dan menghubungkan ke sumber daya untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan.
- f. *Referral and Follow Up* / Rujukan dan Tindak Lanjut
Proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi dan/ atau masyarakat yang memiliki masalah kesehatan untuk dapat mengakses sumber daya seperti pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan.
- g. *Case Management* / Manajemen Kasus
Mengoptimalkan kemampuan merawat individu dan keluarga serta masyarakat untuk merencanakan, mengkoordinasikan layanan kesehatan.
- h. *Delegated functions* / fungsi delegasi
Melaksanakan tugas-tugas asuhan secara langsung berdasarkan pelipahan wewenang sesuai praktisi kesehatan sesuai hukum yang berlaku.
- i. *Health teaching* / pendidikan kesehatan
- j. Proses ini merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta mendorong perubahan sikap, keyakinan, perilaku, dan praktik kesehatan ke arah yang lebih baik.

k. *Counseling/* Konseling

Membangun hubungan yang baik dengan individu, keluarga, masyarakat, maupun sistem pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat diri sendiri serta menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.

l. *Consultation/* Konsultasi

Mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh individu, keluarga, atau masyarakat kemudian memberikan berbagai alternatif solusi melalui proses pemecahan masalah secara bersama dan interaktif.

m. *Collaboration/* Kolaborasi

Bekerja sama dengan individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama melalui peningkatan kemampuan anggota dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.

n. *Coalition-building/* Pembentukan koalisi

Membangun serta memperkuat kerja sama antarorganisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat.

o. *Community organizing/* Pengorganisasian masyarakat

Membantu masyarakat atau kelompok dalam mengenali masalah dan menetapkan tujuan bersama, kemudian menggerakkan sumber daya serta menyusun dan melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

p. *Advocacy/* Advokasi

Mengajukan atau mewakili kepentingan individu, keluarga, maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka agar mampu memperjuangkan dan mengambil tindakan untuk kepentingannya sendiri secara mandiri.

q. *Social marketing/* Pemasaran sosial

Menggunakan prinsip-prinsip pemasaran komersial dalam mengubah perilaku sehat seperti dipahami dulu siapa sasarannya, apa yang mereka hargai, apa hambatannya, lalu dirancang pesan, saluran, dan "tawaran" yang membuat mereka mau berubah secara sukarela demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat untuk mempengaruhi pengetahuan sikap, nilai, keyakinan dan perilaku dan praktik.

r. *Policy development and enforcement/* Pengembangan dan penegakan kebijakan.

Menempatkan masalah kesehatan sebagai agenda program dalam mengambil keputusan serta memperoleh rencana resolusi dan menentukan sumber daya.

Pendekatan Pencegahan Pada Kesehatan Komunitas

Leavell and Clark Tahun 1958 mengidentifikasi tiga level pencegahan yang sering digunakan dalam praktik keperawatan :



Gambar 1.2
Pendekatan Pencegahan Pada Kesehatan Komunitas

4. Pencegahan primer

Pencegahan sebelum masalah terjadi meningkatkan kesehatan dan melindungi dari ancaman kesehatan. Pencegahan ini diimplementasikan sebagai masalah berkembang: pada dasarnya menargetkan populasi yang sehat. Pencegahan primer meningkatkan ketahanan dan faktor pelindung atau mengurangi kerentanan dan paparan terhadap faktor risiko. Pencegahan primer terdiri dari dua elemen : promosi kesehatan umum dan perlindungan spesifik. Upaya-upaya promosi kesehatan meningkatkan faktor ketahanan dan perlindungan serta mempunyai target populasi yang pada dasarnya baik. Fokus perawatan memodifikasi determinan sosial kesehatan dengan tujuan mencegah penyakit dan kecacatan (Schoon, porta & Schaffer, 2019).

5. Pencegahan sekunder

Deteksi dan intervensi yaitu mendeteksi dan mengobati masalah pada tahap awal. Pencegahan ini diimplementasikan setelah masalah dimulai, tetapi sebelum tanda dan gejala muncul. Pencegahan sekunder mencegah masalah menyebabkan efek serius atau jangka panjang atau memengaruhi orang lain. Pencegahan ini mengidentifikasi risiko atau bahaya dan memodifikasi, menghilangkan, atau mengobatinya sebelum masalah menjadi lebih serius. Pencegahan ini menargetkan populasi yang memiliki faktor risiko yang sama.

6. Pencegahan tersier

Perbaikan dan pencegahan memburuknya kondisi penyakit berupa membatasi dampak negatif lebih lanjut dari suatu masalah. Pencegahan ini diimplementasikan setelah penyakit atau cedera terjadi. Pencegahan tersier mengurangi dampak penyakit dan cedera serta mengembalikan individu ke tingkat fungsi optimal mereka. Pencegahan ini menargetkan populasi yang telah mengalami penyakit atau cedera. Mencegah komplikasi hipertensi seperti kebutaan, gagal ginjal dan stroke.

C. Masalah Hipertensi

Menurut *World Health Organization* (WHO) Tahun 2025, hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia dan sering disebut sebagai "*silent killer*" atau pembunuh diam-diam hal ini disebabkan seringkali tidak memiliki tanda-tanda atau gejala yang khas penyakit yang banyak orang tidak menyadarinya. Penderita tidak menyadari dirinya sakit sehingga sangat sering tidak terdiagnosis dan tidak terkontrol sehingga baru datang saat sudah terjadi komplikasi berat seperti stroke atau serangan jantung dan penyumbang utama kematian serta kecacatan akibat penyakit jantung, stroke dan penyakit kronis lainnya (WHO, 2025; Silan et al, 2022). Hipertensi sebagai isu kesehatan global dan tantangan kesehatan masyarakat yang sangat besar.

Prevalensi hipertensi terus meningkat pada tahun 1990-2019 pada penderita usia 30-79 tahun sebanyak $\pm$ 650 juta dan pada tahun 2019 menjadi $\pm$ 1,28 miliar dan pada tahun 2024 sebanyak $\pm$ 1,4 miliar orang di seluruh dunia. Dua pertiga penderita hipertensi berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah, diperkirakan sekitar 600 juta orang dewasa dengan hipertensi (44%) tidak menyadari tanda dan gejala dari penyakit hipertensi (Nguyen, T., & Chow, C., 2021; WHO, 2025). Secara global hipertensi dialami sekitar 26,4% penduduk dunia atau 972 juta jiwa. Menurut WHO hipertensi diperkirakan menyumbang sekitar seperlima ($\pm$ 11 juta) kematian dunia tahun 2019 (Adeola M. Lateef et al, 2026). Prevalensi sedikit lebih tinggi di negara berpendapatan rendah-menengah, dengan kesenjangan besar dalam kesadaran, pengobatan, dan kontrol. Angka-angka ini menunjukkan hipertensi sebagai beban kesehatan masyarakat yang sangat besar di seluruh dunia.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia mengenai sekitar sepertiga orang dewasa. Penderita hipertensi pada dewasa yaitu pada tahun 2013 $\pm$ 65 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 34,1%. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dan hasil pengukuran pada penduduk umur $\geq$ 15 tahun yaitu sebanyak 598.983 jiwa. Sedangkan yang mendapatkan edukasi

pengobatan dan minum obat hipertensi yaitu 53.668 jiwa, proporsi alasan utama tidak patuh pengobatan 27.908 jiwa, yang diperiksa ulang/ kontrol 53.668 jiwa, proporsi hipertensi terkontrol 51.292 jiwa (Kemenkes, 2023).

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular (PTM)/ *non communicable disease (NCD)* yang menjadi beban utama kesehatan di Indonesia dan dunia. Hipertensi PTM bersifat kronis dan generatif umumnya berjangka panjang yang disebabkan dari pola hidup tidak sehat dan berlangsung lama dan salah satu faktor utama terjadinya penyakit pembuluh darah lain yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan tingginya risiko kematian. Hipertensi yang tidak dapat ditangani dapat menyebabkan kerusakan arteri dalam tubuh hingga organ sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan jantung, stroke, kerusakan ginjal, retinopati dan kebutaan dan bisa menyebabkan kematian.

WHO menggambarkan hipertensi menyebabkan beban ekonomi yang besar terkait biaya bukan hanya obat dan kontrol rutin tetapi juga komplikasi jangka panjang dan hilangnya produktivitas. Biaya pengobatan jangka panjang, perawatan komplikasi, serta hilangnya tenaga kerja membuat hipertensi menjadi masalah kesehatan yang membebani sistem kesehatan dan ekonomi negara secara signifikan. Penderita hipertensi khususnya pada lansia menyebabkan beban pada keluarga yang tinggal bersama anggota keluarga yang masih produktif sehingga memerlukan waktu dan pembiayaan. Hipertensi menjadi beban besar bagi Indonesia karena meningkatkan pembiayaan kesehatan nasional, termasuk pembiayaan BPJS Kesehatan akibat komplikasi yang membutuhkan perawatan mahal dan jangka panjang. Komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung termasuk dalam 10 besar penyebab kematian di Indonesia, yang sebagian besar dipicu oleh hipertensi yang tidak terkontrol. Selain itu, banyak penderita berada pada usia produktif sehingga menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan beban ekonomi keluarga. Kondisi ini membuat hipertensi tidak hanya menjadi masalah kesehatan individu, tetapi juga berdampak signifikan terhadap beban ekonomi dan sistem kesehatan nasional Indonesia.

WHO menerbitkan *Global report on hypertension 2023*, menegaskan hipertensi sebagai prioritas global dan bagian penting untuk mencapai target SDGs pengurangan kematian dini Non Communicable Disease 2030 (Kario et al, 2024). Menurut *American College of Cardiology (ACC) / American Heart Association (AHA)* Tahun 2025, hipertensi didefinisikan bila tekanan darah klinik $\geq 130/80$ mmHg, dengan klasifikasi normal, elevated, stage 1 dan stage 2. Hipertensi dapat dibagi menjadi dua 1) hipertensi esensial yaitu tidak diketahui penyebabnya dan biasanya disebabkan faktor keturunan dan 2) hipertensi yang dikaitkan dengan gaya hidup sehat seperti kurangnya konsumsi sayur, aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol,

kurang istirahat, stress dan lain-lain. Hipertensi sekudner disebabkan oleh penyakit kain seperti penyakit ginjal.

Hipertensi adalah masalah kesehatan besar di Indonesia dengan prevalensi tinggi, sering tidak terdeteksi, dan menimbulkan komplikasi serius pada jantung, otak, dan ginjal. Faktor risiko utamanya adalah pola hidup tidak sehat (garam tinggi, lemak, merokok, kurang aktivitas, stres) serta usia lanjut. Edukasi, skrining rutin, perubahan gaya hidup, senam/olahraga teratur, dan kepatuhan kontrol/obat merupakan kunci untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi di masyarakat. Hipertensi tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar secara global—diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor untuk deteksi dini serta pengendalian efektif demi menekan komplikasi jangka panjangnya.

Klasifikasi hipertensi berdasarkan American College of Cardiology (ACC) / American Heart Association (AHA) dan *European Society of Cardiology (ESC) /European Society of Hypertension (ESH)*

Kategori	Tekanan darah sistolik/mmHg	dan/atau	Tekanan darah diastolik/mmHg
<i>American College of Cardiology (ACC) / American Heart Association (AHA)</i>			
Normal	<120	dan	<80
Tinggi	120–129	dan	<80
Hipertensi tahap 1	130–139	atau	80–89
Hipertensi tahap 2	≥140	atau	≥90
<i>European Society of Cardiology (ESC) /European Society of Hypertension (ESH)</i>			
Optimal	<120	dan	<80
Normal	120–129	dan/atau	80–84
Tinggi normal	130–139	dan/atau	85–89
Hipertensi derajat 1	140–159	dan/atau	90–99
Hipertensi derajat 2	160–179	dan/atau	100–109
Hipertensi derajat 5	≥180	dan/atau	≥110
Hipertensi sistolik terisolasi	≥140	dan	<90

Penatalaksanaan Hipertensi berupa kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan, penapisan (skrining), deteksi dini. Penatalaksanaan hipertensi di masyarakat dapat (Nies, M,A., McEwen, M. 2019); Fitriani et al 2025) :

1. Promosi kesehatan dengan memberikan pemahaman pada individu, keluarga dan masyarakat tentang proses penyakit hipertensi dan pengobatan.
2. Skrining tekanan darah secara rutin
3. Partisipasi individu, keluarga dan masyarakat pada program manajemen hipertensi dan perilaku hidup sehat :
 - a. Mengurangi konsumsi garam (tidak melebihi 200 mg natrium. Sodium perhari)
 - b. Mengurangi lemak hewani mengandung lemak jenuh
 - c. Tidak merokok dan menghindari asap rokok
 - d. Mempertahankan berat badan ideal. Berat badan yang berlebih menyebabkan jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah
 - e. Melakukan olahraga setiap 30 menit perhari 5x dalam seminggu. Kurang olahraga akan menyebabkan risiko penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah.
 - f. Mengurangi minuman bersoda berlebihan dan kandungan kafein yang berlebihan.
 - g. Mengurangi makanan yang mengandung bahan pengawet natrium.
 - h. Mengelola stress dengan baik .
4. Tidak adanya komplikasi hipertensi
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal (nadi dan frekuensi napas)
 - b. Tidak terjadi serangan otak/ stroke
 - c. Tidak ada gangguan penglihatan/ retinopati dan kebutaan
 - d. Tidak adanya kerusakan gagal ginjal
 - e. Tidak melaporkan adanya pusing, telinga berdenging, perdarahan hidung dan jatuh.

D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Komunitas Masalah hipertensi

Hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan komunitas pada kasus hipertensi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu individu, sosial, ekonomi, dan sistem pelayanan kesehatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi, sehingga banyak penderita tidak menyadari kondisinya dan tidak melakukan pemeriksaan rutin. Selain itu, faktor perilaku seperti kurangnya kepatuhan minum obat, rendahnya motivasi untuk kontrol ke fasilitas kesehatan, serta anggapan bahwa

hipertensi tidak berbahaya karena tidak menimbulkan gejala juga menjadi penghambat utama dalam upaya pengendalian penyakit ini di masyarakat.

Hambatan lainnya berasal dari aspek akses pelayanan kesehatan, seperti jarak fasilitas kesehatan yang jauh, keterbatasan transportasi, dan biaya tidak langsung (misalnya biaya perjalanan dan waktu kerja yang hilang). Meskipun sudah ada jaminan kesehatan seperti BPJS, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan secara rutin. Di sisi lain, keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan obat antihipertensi, serta kurang optimalnya program skrining dan kunjungan rumah juga menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan komunitas. Kondisi ini menyebabkan hipertensi sering terlambat terdeteksi dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga meningkatkan risiko komplikasi.

E. Referensi

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community health nursing: Promoting and protecting the public's health* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Almetari, A. (2024). The importance of nursing in healthcare systems. *International journal of health sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v8ns1.15535>.
- Arna, et all. (2024). *Keperawatan Komunitas*. Kendari: PT. Media Pustaka Indo
- Fitriani, S., Wahyuni, D., Zikran. (2025). Hubungan Self Management terhadap Pengontrolan Tekanan Darah di Fasilitas Kesehatan pada Lansia Hipertensi. *Prociding. Seminar Nasional Keperawatan "Tantangan dan Resolusi Layanan Paliatif Serta Perawatan*
- Jangka Panjang di Fasilitas Kesehatan"
- Kario, K., Okura, A., Hoshide, S., & Mogi, M. (2024). The WHO Global report 2023 on hypertension warning the emerging hypertension burden in globe and its treatment strategy. *Hypertension Research*, 47, 1099 - 1102. <https://doi.org/10.1038/s41440-024-01622-w>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kurwiyah, N., Anwar, S., Herlinah, L., Suharsiwi, S., Annantusia, A., & Pangerstu, S. (2023). Dukungan Keluarga terhadap Pengendalian Hipertensi pada Lansia di Wilayah Rw 10 Kelurahan Utan Panjang Jakarta Pusat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9493>.
- Lateef, A., Lateef, O., Hamman, M., Oluwadare, F., & Agbajelola, V. (2026). Silent Pressures: The Public Health Threats of Undiagnosed Hypertension in Nigeria. *Przegląd Epidemiologiczny*. <https://doi.org/10.32394/pe/217068>.

- Maurer, F. A., & Smith, C. M. (2013). *Community/public health nursing practice: Health for families and populations* (5th ed.). Elsevier Saunders.
- Nguyen, T., & Chow, C. (2021). Global and national high blood pressure burden and control.. Lancet. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(21\)01688-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)01688-3).
- Nies, M,A., McEwen, M. (2019). *Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga Edisi Indonesia Pertama*. Elseiver
- Pazzaglia, C., Camedda, C., Ugenti, N., Trentin, A., Scalorbi, S., & Longobucco, Y. (2023). Community Health Assessment Tools Adoptable in Nursing Practice: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031667>.
- Safitri, A., Mugiyanto, M., Hasanah, N., Wahyuni, E., Sariayu, N., Sari, C., Efendi, H., Mensi, S., Rosaria, L., Nurhidayati, D., Trifani, D., Saifudin, M., Irawati, Y., Mahdiah, S., Sabariyah, T., Handayani, R., & Haryati, N. (2024). Laporan Hasil Praktik Profesi Asuhan Keperawatan Komunitas di Kp. Pengasinan Rw.03 Kel. Periuk Jaya Kec. Periuk Kota Tangerang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan. <https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i1.880>.
- Savage, C. L., Gillespie, G. L., & Whitehouse, E. R. (2023). *Public/community health and nursing practice: Caring for populations* (3rd ed.). F.A. Davis Company.
- Schaffer, M., & Strohschein, S. (2019). Public Health Interventions: Applications for Public Health Nursing Practice Second Edition. Minnestosa Departement of Health. *Community health Division*
- Silan, V., Verma, R., Pal, R., & , T. (2022). An unattended silent killer: A facility-based cross-sectional study on undiagnosed hypertension from Haryana, India. Asian Journal of Medical Sciences. <https://doi.org/10.3126/ajms.v13i9.44446>.
- Sines, D., Fanning, A., Potter, K., Aldridge-Bent, S., Wright, J., & Farrelly, P. (2013). *Community and Public Health Nursing*. .
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2016). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (9th ed.). Elsevier.
- Ulutaşdemir, N. (2018). Introductory Chapter: Nursing. Nursing. <https://doi.org/10.5772/intechopen.79519>.
- World Health Organization. (2025). Hypertension. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

F. Glosarium

Asimtomatik = menderita penyakit namun tidak menunjukkan tanda dan gejala klinis

Kuratif = Pengobatan/ penanganan penyakit

NCD = *Non Communicable Disease*

Perkesmas = Perawat Kesehatan Masyarakat

Preventif = Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit sebelum muncul gejala.

Primer = Utama/ pokok

Promotif = Meningkatkan kesehatan individu atau kelompok sebelum timbul masalah kesehatan.

PTM = Penyakit Tidak Menular

Rehabilitatif = Upaya untuk memulihkan fungsi tubuh setelah sakit

Riskesdas = Riset Kesehatan Dasar

Sekunder = Kebutuhan lanjutan tidak mendesak

Silent killer = Pembunuh diam-diam

SKI = Survei Kesehatan Indonesia

Tersier = Pelayanan lanjutan/ rujukan

WHO = *World Health Organization*

CHAPTER 2

PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI MELALUI POSINDU

Ns. Maulina, M.Kep., Sp.Kep.Kom

A. Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan hingga saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang serius. Salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang menyebabkan kematian terbesar dan atau pembiayaan kesehatan terbesar yang banyak dialami masyarakat adalah hipertensi (Kemenkes RI, 2023). Hipertensi masih menjadi ancaman kesehatan karena dikenal sebagai *silent killer*, yaitu penyakit yang sering kali tidak menunjukkan gejala yang khas dan sulit dideteksi tanpa pemeriksaan menggunakan alat khusus. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada organ tubuh apabila tidak ditangani dengan baik (Kalehoff & Oparil, 2020; Mensah, 2019).

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) (2023), terdapat prevalensi hipertensi pada kelompok usia ≥ 15 tahun di Indonesia sebesar 8 % berdasarkan diagnosis dokter dan 29,2 % berdasarkan hasil pengukuran. Orang dengan tekanan darah tinggi mungkin tidak merasakan gejala. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksakan tekanan darahnya (WHO, 2025).. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor risiko hipertensi sangat penting sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Ibnu dan Hidayati (2025), faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi meliputi :

1. Faktor Risiko Yang Tidak Dapat Diubah

a. Usia

Tekanan darah umumnya lebih rendah pada masa remaja dan mulai mengalami peningkatan saat memasuki dewasa awal. Peningkatan tersebut menjadi lebih signifikan pada masa dewasa akhir hingga lanjut usia seiring dengan proses pertumbuhan dan pematangan fisik. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem sirkulasi darah, seperti penyumbatan pada pembuluh darah, penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, serta menurunnya elastisitas pembuluh darah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah (Kabba, 2024).

Kejadian hipertensi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (2023) didapatkan data bahwa usia yang paling tinggi menderita hipertensi adalah ≥ 75 tahun sebesar 26,1 %. Proses penuaan mengakibatkan peningkatan jumlah kolagen, penipisan, serta kalsifikasi serat elastin yang menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku. Perubahan tersebut berdampak pada aorta, yaitu terjadinya pelebaran diameter lumen aorta sebagai kompensasi terhadap kekakuan arteri akibat proses menua. Kondisi ini dapat memicu peningkatan resistensi perifer, gangguan fungsi baroreseptor, serta menurunnya kemampuan tubuh dalam meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital, sehingga risiko terjadinya hipertensi menjadi lebih tinggi (Riyada et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian oleh Nasution, et al (2024) diketahui sebagian besar usia responden yang beresiko hipertensi dengan usia rata-rata 60-74 tahun. Hal ini memperkuat bahwa usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko hipertensi.

b. Jenis Kelamin

Secara umum, laki-laki memiliki risiko lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan perempuan. Namun, pada perempuan yang berusia di atas 45 tahun, risiko hipertensi meningkat terutama saat memasuki masa menopause. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya produksi hormon estrogen yang berpengaruh terhadap sistem kardiovaskular, khususnya menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah (Situmorang & Mulyono, 2024). Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Podungge (2020), yang menjelaskan bahwa perempuan sebelum memasuki masa menopause masih mendapatkan perlindungan dari hormon estrogen. Hormon ini berperan dalam meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL). Tingginya kadar kolesterol HDL dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah terjadinya aterosklerosis.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) (2023), prevalensi hipertensi berdasarkan jenis kelamin didapatkan di Indonesia bahwa perempuan lebih banyak menderita hipertensi sebesar 10,5 % berdasarkan diagnosis dokter dan 32,8 % berdasarkan hasil pengukuran.

Penelitian Riyada et al. (2024) menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kejadian hipertensi pada perempuan dibandingkan laki-laki, seperti obesitas dan aktivitas fisik. Meskipun demikian, kasus hipertensi pada kelompok lansia lebih banyak ditemukan pada perempuan. Hasil tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa hipertensi lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi ini dimungkinkan

karena laki-laki memiliki faktor risiko yang dapat memicu hipertensi, seperti stres, kelelahan, dan pola makan yang kurang terkontrol. Sementara itu, pada perempuan, risiko hipertensi umumnya meningkat setelah memasuki masa menopause, meskipun proporsi kejadian hipertensi pada perempuan tetap lebih tinggi.

c. Genetik

Individu yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi mempunyai risiko sekitar dua kali lebih tinggi mengalami hipertensi dibandingkan individu yang tidak memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga. Faktor keturunan atau genetik merupakan pewarisan sifat dari orang tua kepada anak. Seseorang yang memiliki salah satu orang tua dengan riwayat hipertensi cenderung mempunyai risiko lebih tinggi mengalami hipertensi dibandingkan individu yang kedua orang tuanya tidak menderita hipertensi. Meskipun demikian, riwayat keluarga hipertensi tidak selalu menyebabkan seseorang pasti mengalami hipertensi (Kusmiati & Mardiana, 2024).

Berdasarkan karakteristik riwayat keluarga atau keturunan, jumlah individu yang memiliki riwayat hipertensi keluarga lebih banyak ditemukan pada kelompok kasus dibandingkan kelompok kontrol. Menurut *European Society of Cardiology*, riwayat keluarga merupakan salah satu faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada penderita hipertensi (Williams et al., 2018). Kondisi ini berkaitan dengan faktor genetik yang memiliki hubungan erat dengan peningkatan kadar natrium intraseluler serta rendahnya rasio kalium-natrium (L.O et al., 2020). Risiko hipertensi pada seseorang akan semakin besar apabila kedua orang tuanya memiliki riwayat hipertensi, karena adanya pewarisan sifat melalui faktor genetik. Penelitian Riska (2015) juga menyatakan bahwa faktor genetik terbukti menjadi salah satu faktor risiko hipertensi. Selain itu, seseorang yang memiliki orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai kemungkinan sekitar dua kali lebih tinggi mengalami hipertensi dibandingkan individu tanpa riwayat hipertensi dalam keluarga (Agustina & Raharjo, 2017). Penelitian oleh Nasution, et al (2024) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor genetik dengan hipertensi dengan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$).

2. Faktor Risiko Yang Dapat Diubah

a. Obesitas

Obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh seseorang mencapai nilai ≥ 30 . Kondisi ini disebabkan oleh asupan kalori yang melebihi jumlah energi yang digunakan melalui aktivitas fisik, sehingga kelebihan kalori tersimpan sebagai lemak dalam tubuh. Selain itu, kelebihan berat badan atau obesitas ditandai

dengan adanya penumpukan lemak berlebih dalam tubuh yang diukur menggunakan *Body Mass Index* (BMI), dengan nilai $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ untuk kategori berat badan berlebih.

Obesitas dapat menyebabkan hipertensi karena timbunan lemak mempersempit pembuluh darah sehingga aliran darah tidak mencukupi dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi aliran darah yang mengakibatkan hipertensi.

Penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Penimbung, didapatkan berdasarkan hasil uji chi-square nilai observasi tertinggi ditemukan pada pasien obesitas yang mengalami hipertensi ringan yaitu sebanyak 47 orang dan nilai yang diperoleh sebesar 40,8. Nilai signifikansi atau P value sebesar 0,003 yang lebih kecil dari alpha 0,05 atau ($\alpha=5\%$), sehingga menunjukkan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara faktor obesitas terhadap hipertensi pada responden di wilayah kerja Puskesmas Penimbung (Marthilda, (2022), dalam Riyada et al. (2024)).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) mengenai hubungan antara obesitas dan hipertensi menggunakan data *Indonesian Family Survey V* menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut (p value 0,000; OR 4,348). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa individu yang mengalami obesitas memiliki risiko sekitar 4,348 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan individu yang tidak obesitas.

b. Kebiasaan Merokok

Perilaku merokok merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki nilai positif dalam semua hal terutama pada kesehatan. Merokok merupakan awal yang mendatangkan berbagai jenis penyakit degeneratif yang mematikan, seperti kanker dan penyakit jantung. Nikotin dalam tembakau merupakan penyebab meningkatnya tekanan darah segera setelah hisapan pertama. Seperti zat-zat kimia lain dalam asap rokok, nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat kecil di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah.

Zat seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihirup melalui rokok bereaksi di vaskularisasi dapat merusak lapisan endotel arteri yang menyebabkan aterosklerosis dan hipertensi (Umbas et al, (2019 dalam Sihombing et al (2023)). Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Andriani et al, (2020, dalam Riyada et al. (2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian hipertensi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Simanjuntak, Nasution, dan Utami (2022) menunjukkan bahwa dari 43 responden yang merokok terdapat 41 responden

(95.3%) mengalami kejadian hipertensi dan 2 responden (4.7%) tidak mengalami kejadian hipertensi. Dari 59 responden yang tidak merokok terdapat 6 responden (10.2%) mengalami kejadian hipertensi dan 53 responden (89.8%) tidak mengalami kejadian hipertensi. Berdasarkan analisis statistik Chi Square Test didapat nilai $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan merokok terhadap kejadian hipertensi pada lansia di UPT Puskesmas Sigumpar.

c. Kebiasaan Minum Alkohol

Konsumsi alkohol telah dikaitkan dengan berbagai hasil penyakit kardiovaskular, termasuk kardiomiopati, penyakit arteri koroner, stroke, dan peningkatan tekanan darah (TD) (Lucas et al, 2005). Konsumsi alkohol dapat merangsang pelepasan epinefrin dan adrenalin yang berperan dalam penyempitan arteri, serta menyebabkan retensi cairan dan natrium dalam tubuh. Pada kondisi hipertensi, peningkatan asupan alkohol dalam jangka panjang dapat meningkatkan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas *Renin Angiotensin Aldosterone System* (RAAS), yang berfungsi mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh, menjadi meningkat. Selain itu, konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan volume sel darah merah sehingga darah menjadi lebih kental, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya hipertensi.

Penelitian oleh Ramadhani (2021) menjelaskan bahwa hasil analisis uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi alkohol dengan hipertensi dengan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$), dan mayoritas responden hipertensi yang mengkonsumsi alkohol tinggi sebanyak 36 responden (47,4%). peneliti

d. Diet Tidak Sehat

Menurut *American Dietetic Association* (ADA), penerapan diet yang tepat dapat membantu menurunkan tekanan darah serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Triwibowo, H., Heni. F., & Indah, 2016). Kepatuhan terhadap pola diet yang dianjurkan dapat memperlambat bahkan mencegah terjadinya hipertensi serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Pengaturan diet ini dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam dan alkohol, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, menjaga atau menurunkan berat badan agar tetap ideal, serta menghindari kebiasaan merokok (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2019).

Hipertensi dapat dikendalikan melalui pengaturan pola makan atau diet dengan membatasi konsumsi garam. Penderita hipertensi dianjurkan untuk menjalankan diet hipertensi secara konsisten setiap hari. Tujuan kepatuhan

diet ini adalah untuk menjaga tekanan darah tetap stabil serta mencegah terjadinya komplikasi akibat hipertensi (Purwandari, K. P., 2018). Oleh karena itu, disarankan untuk mengurangi asupan natrium atau sodium yang terdapat dalam garam dapur, sodium karbonat, serta monosodium glutamat (MSG) sebagai penyedap makanan. Konsumsi garam dapur yang mengandung iodium juga dianjurkan tidak melebihi 6 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari (Nurrahmani, 2017). Selain itu, penerapan diet sehat dapat dilakukan secara rutin dengan mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, meningkatkan konsumsi makanan berserat, serta disertai dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur (Bahari, G. P., 2021).

Hasil penelitian oleh Nurazizah & Kurniawati (2022) mengenai tingkat kepatuhan diet dengan tekanan darah pada pasien hipertensi menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan diet terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi dan didapatkan $P\text{-value } 0.000 < \alpha 0,005$ dengan total responden 246. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Anggreaini, Susanita dan Pardede (2024) didapatkan hasil uji chi-square $P\text{-value } 0,019 < \alpha 0,05$ yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan diet dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di Puskesmas Perwira

e. Kurang Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, makan, mencuci, dan aktivitas lainnya. Selain aktivitas tersebut, kegiatan yang perlu dilakukan secara rutin adalah olahraga. Olahraga tidak harus berupa aktivitas yang berat, karena berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah termasuk olahraga ringan yang bermanfaat. Individu yang jarang berolahraga memiliki risiko sekitar 4,7 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga. Hal ini berkaitan dengan tingkat kelenturan pembuluh darah serta fungsi otot jantung.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution, et al (2024) didapatkan hasil pada 44 responden yang memiliki aktifitas fisik berat terdapat 43 responden (97.7%) mengalami kejadian hipertensi dan 1 responden (2.3%) tidak mengalami kejadian hipertensi. Dari 58 responden yang memiliki aktifitas fisik ringan terdapat 4 responden (6.9%) mengalami kejadian hipertensi dan 54 responden (93.1%) tidak mengalami kejadian hipertensi. Berdasarkan analisis statistik Chi Square Test didapat nilai $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan aktifitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada lansia di UPT Puskesmas Sigumpar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Triana et al (2024) terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada Karyawan di Universitas Malahayati Bandar Lampung ($p\text{-value} = 0.021$: OR = 4.24). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah.

B. Simpulan

Hipertensi pada masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang saling berkaitan, baik faktor yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga/genetik, maupun faktor yang dapat diubah seperti obesitas, diet tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol, merokok, serta kurangnya aktivitas fisik. Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, seperti menjaga berat badan ideal, menerapkan pola makan seimbang, rutin beraktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan berisiko.

C. Referensi

- Agustina, R., & Raharjo, B. B. (2017). FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI USIA PRODUKTIF (25-54 TAHUN). 4(4), 146–158.
- Anggreini. N. F.N., Susanita. N., Pardede. L. (2024). Hubungan Kepatuhan Diet Dengan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Perwira Bekasi Utara. JKA (Jurnal Keperawatan Abdurrah) Volume 07 No. 02. ISSN: 2579-8723; P 23-26.
- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Bahari, G. P., S. & B. (2021). Hubungan Kepatuhan Diet Hipertensi Dengan Status Tekanan Darah Pada Lansia Di Desa Singogalih Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. 1–10. <http://repositori.stikesppni.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/418>

- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Ibnu, F., Hidayati. R. N. (2025). Deteksi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dimodifikasi Dalam Upaya Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi. ISBN: 978-634-7139-73-3. Nuansa Fajar Cemerlang; Jakarta
- Kabba, S. W. (2024). Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Padukuhan Jatirejo Wukirsari Imogiri (Vol. 15, Issue 1). STIKES Wira Husada.
- Kalehoff, J. P., & Oparil, S. (2020). The Story of the Silent Killer.
- Kemenkes RI (2023) Survey Kesehatah Indonesia
- Kusmiati, L., & Nova Mardiana, A. (2024). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6 Nomor 5, 2375–2386.
- Lucas DL, Brown RA, Wassef M, Giles TD. (2005) Alcohol and the cardiovascular system: research challenges and opportunities. *J Am Coll Cardiol* ;45:1916–1924. doi: 10.1016/j.jacc.2005.02.075
- Mensah, G. A. (2019). Commentary : Hypertension P henotypes : T he M any F aces of a S ilent K iller. 29(4), 545–548. <https://doi.org/10.18865/ed.29.4.545>
- Nasution, et al (2024). Faktor Risiko Hipertensi pada Usia 50 Sampai 70 Tahun di Wilayah Puskesmas Bahkapul Kota Pematangsiantar. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB. I Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan 66 p-ISSN 2527-9548 Vol. 9, No. 2, pp. 66-88*
- Nugroho. A.S (2018). Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Hipertensi pada Lansia Yang Mengalami Hipertensi di Puskesmas Sidokerto Kabupaten Magetan. *Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Nurazizah, E. P., & Kurniawati, T. (2022). The Relationship between Hypertension Diet Adherence and Blood Pressure in Hypertensive Patients in Surajaya. *Inprosiding University Research Colloquium 2023 Jan 4*, 441–447.
- Nurrahmani, U. (2017). Stop! Hipertensi. *Familia (Group Relasi Inti Media)*.
- Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. (2019). Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi. http://faber.inash.or.id/upload/pdf/article_Udapte_konsensus_201939.pdf
- Purwandari, K. P., & Y. W. . (2018). Hubungan Tingkat Kepatuhan Diet terhadap Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Desa Nambangan. *University Research Colloquium*, 482–486
- Rahmadhani M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hipertensi Pada Masyarakat Di Kampung Bedagai Kota Pinang. *J Kedokt STM (Sains*

dan Teknol Med);4(1):52–62.

- Riyada, F., Amanah Fauziah, S., Liana, N., & Hasni, D. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Resiko Hipertensi pada Lansia. *Scientific Journal*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.56260/sciena.v3i1.137>
- Sihombing. E.P.R, et al. (2023). Faktor Risiko Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Volume 7, Nomor 3. ISSN 2623-1581. 16089-16105.
- Simanjuntak TJ, Nasution Z, Utami TN. Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Upt Puskesmas Sigumpar. *MIRACLE J*. 2022;2(1):162–77
- Situmorang, D. M., Andreas Mulyono, E. (2024). Antecedents Of Accounting Knowledge Behavior Analysis And Recording Behavior , Cultural Behavior Accounting And Revenue In MSMEs. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(02), 334–347.
- Suprayitna Marthilda HZ. Faktor Resiko Terjadinya Perubahan Pada Lansia. *J Ilm Pannmed*. 2022;17(1):82–8.
- Triana. M. A., et al. (2024). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Tekanan Darah Pada Karyawan Di Universitas Malahayati Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan (JIKK)*. Volume 6. No. 6. P : 1252-1260.
- Triwibowo, H., Heni. F., & Indah, R. D. (2016). Hubungan Kepatuhan Diet Hipertensi Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Poli Penyakit Dalam RSUD Prof . Dr . SOEKANDAR MOJOKERTO * Heri Triwibowo , ** Heni Frilasari , *** Indah Rachma Dewi Akper Bina Sehat PPNI Mojokerto. *Jurnal Keperawatan*, 5(1), 1–6.

D. Glosarium

SKI = Survei Kesehatan Indonesia

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KOMUNITAS DAN SKREENING TEKANAN DARAH MELALUI POSBINDU

Ns. Supriadi, S.Kep., M.KM.

A. Pendahuluan

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius karena menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal, dan kematian dini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa hipertensi termasuk faktor risiko penting penyebab kematian dan perlu dikendalikan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta perubahan perilaku masyarakat.

Hipertensi sering disebut sebagai penyakit yang tidak selalu menimbulkan gejala pada tahap awal. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, kegiatan skrining tekanan darah secara berkala di tingkat komunitas menjadi sangat penting agar kasus hipertensi dapat ditemukan lebih awal sebelum terjadi komplikasi. WHO menegaskan bahwa hipertensi yang tidak terkendali berkontribusi terhadap serangan jantung, stroke, kematian dini, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat maupun negara.

Hipertensi masih menjadi salah satu masalah penyakit tidak menular utama di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi hipertensi pada penduduk umur ≥ 18 tahun berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah mencapai 30,8%, sedangkan berdasarkan diagnosis dokter hanya 8,6%. Pada penduduk umur ≥ 15 tahun, prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah sebesar 29,2%, sedangkan berdasarkan diagnosis dokter hanya 8,0%. Perbedaan yang besar antara hasil pengukuran dan diagnosis dokter menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan status hipertensi di masyarakat.

Meskipun prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah menurun dari 34,1% pada Riskesdas 2018 menjadi 30,8% pada SKI 2023, angka tersebut tetap tinggi karena berarti sekitar tiga dari sepuluh orang dewasa mengalami hipertensi berdasarkan hasil pengukuran. Selain itu, hipertensi masih berdampak besar terhadap disabilitas dan kematian. Kemenkes menyebutkan bahwa hipertensi menjadi faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat di Indonesia dengan persentase 10,2%.

Hipertensi juga berkontribusi terhadap disabilitas. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa 59,1% penyebab disabilitas pada penduduk usia ≥ 15 tahun adalah penyakit yang didapat; dari penyakit tersebut, 53,5% merupakan PTM, terutama hipertensi 22,2% dan diabetes 10,5%. Data ini memperlihatkan bahwa hipertensi bukan hanya menyebabkan peningkatan tekanan darah, tetapi juga dapat berdampak pada penurunan fungsi dan kualitas hidup masyarakat.

Data program skrining terbaru tahun 2025 juga memperkuat urgensi deteksi dini hipertensi. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa lebih dari 8,2 juta orang telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis sejak Februari 2025, dan per 12 Juni 2025 ditemukan bahwa 1 dari 5 peserta mengalami hipertensi. Bahkan pada kelompok usia di atas 40 tahun, 1 dari 3 orang mengalami hipertensi. Temuan ini menunjukkan bahwa skrining tekanan darah di fasilitas pelayanan primer dan komunitas sangat penting untuk menemukan kasus hipertensi lebih awal.

Dengan demikian, penguatan skrining tekanan darah melalui Posbindu PTM, Posyandu terintegrasi, Puskesmas, dan program cek kesehatan rutin menjadi strategi penting dalam pengendalian hipertensi. Skrining tidak hanya bertujuan menemukan tekanan darah tinggi, tetapi juga menjadi pintu masuk edukasi perilaku hidup sehat, pengendalian obesitas sentral, peningkatan aktivitas fisik, rujukan ke fasilitas kesehatan, serta pemantauan kepatuhan pengobatan. Data BKPK Kemenkes menunjukkan bahwa pada usia produktif 18–59 tahun, proporsi penderita hipertensi dengan obesitas sentral 3,4 kali lebih tinggi, dan proporsi penderita hipertensi dengan aktivitas fisik kurang 1,9 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok pembandingan.

B. Konsep Dasar Pengkajian Komunitas

Pengkajian komunitas adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengetahui status kesehatan, kebutuhan, masalah, faktor risiko, serta potensi sumber daya yang dimiliki suatu komunitas. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) menjelaskan bahwa *community health assessment* memberikan informasi komprehensif tentang status kesehatan, kebutuhan, dan isu kesehatan komunitas, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menyusun rencana peningkatan kesehatan masyarakat.

Dalam praktik keperawatan komunitas, pengkajian komunitas dapat dilakukan melalui observasi wilayah, wawancara tokoh masyarakat, survei keluarga, telaah data Puskesmas, diskusi kelompok, kunjungan rumah, dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Pada konteks skrining hipertensi, pengkajian komunitas mencakup data demografi, perilaku berisiko, riwayat penyakit, pola konsumsi garam, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, status gizi, lingkar perut, tekanan darah, akses layanan

kesehatan, dan dukungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perencanaan kesehatan masyarakat yang menggunakan data pengkajian sebagai dasar penentuan prioritas dan intervensi.

Pengkajian komunitas penting karena hipertensi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan perilaku. Misalnya, pola makan tinggi garam, rendah konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, stres, merokok, dan rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan dapat meningkatkan risiko hipertensi. PNPK Hipertensi Dewasa menekankan bahwa anamnesis pada hipertensi perlu menggali riwayat hipertensi individu dan keluarga, riwayat merokok, pola diet dan konsumsi garam, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, serta faktor risiko lain seperti dislipidemia dan diabetes.

Dalam kegiatan Posbindu/Posyandu PTM, pengkajian komunitas dapat diarahkan pada dua tingkat, yaitu tingkat individu dan tingkat wilayah. Pada tingkat individu, data yang dikaji meliputi identitas peserta, umur, jenis kelamin, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, riwayat hipertensi, dan perilaku berisiko. Pada tingkat wilayah, data yang dikaji meliputi cakupan kunjungan Posbindu, jumlah peserta dengan tekanan darah tinggi, jumlah rujukan, ketersediaan kader, alat tensimeter, media edukasi, dan keterlibatan Puskesmas.

Hasil pengkajian komunitas harus ditindaklanjuti menjadi rencana intervensi. Misalnya, jika ditemukan banyak warga dewasa dengan tekanan darah tinggi tetapi jarang memeriksakan diri, maka intervensi yang dapat dilakukan adalah edukasi hipertensi, kunjungan rumah, peningkatan frekuensi skrining, pelatihan kader, dan penguatan rujukan ke Puskesmas. CDC menjelaskan bahwa *community health improvement plan* merupakan upaya sistematis jangka panjang untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat berdasarkan hasil pengkajian kesehatan komunitas.

C. Pengertian Skrining Hipertensi

Skrining hipertensi adalah kegiatan pemeriksaan tekanan darah yang bertujuan menemukan individu dengan tekanan darah tinggi atau berisiko hipertensi secara dini. Skrining berbeda dengan diagnosis akhir. Skrining bertujuan memilah peserta yang perlu edukasi, pemantauan, pemeriksaan ulang, atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Diagnosis hipertensi tetap memerlukan konfirmasi sesuai pedoman klinis. USPSTF merekomendasikan skrining hipertensi pada orang dewasa usia 18 tahun atau lebih dengan pengukuran tekanan darah, serta menganjurkan konfirmasi pengukuran di luar fasilitas klinik sebelum pengobatan dimulai.

Menurut PNPK (Pedoman Nasional pelayanan kedokteran) Tata Laksana Hipertensi Dewasa, hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Klasifikasi tekanan darah dalam PNPK

mencakup tekanan darah optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi.

Dalam kegiatan Posbindu/Posyandu PTM, skrining hipertensi dilakukan sebagai deteksi dini. Artinya, bila hasil tekanan darah menunjukkan peningkatan, peserta tidak langsung diberi label diagnosis tetap oleh kader, tetapi diarahkan untuk pemeriksaan ulang, konseling, dan rujukan ke tenaga kesehatan. Pendekatan ini penting untuk menghindari kesalahan penafsiran akibat pengukuran satu kali, kondisi peserta yang cemas, aktivitas fisik sebelum pemeriksaan, posisi tubuh yang tidak benar, atau alat yang tidak terkalibrasi.

Skrining hipertensi di Posbindu juga harus dipadukan dengan skrining faktor risiko PTM lainnya. Deteksi dini hipertensi sebagai bagian dari paket skrining PTM bersama obesitas, diabetes melitus, stroke, penyakit jantung, dan faktor risiko lainnya. Dengan demikian, kegiatan skrining tekanan darah sebaiknya tidak dilakukan secara terpisah dari pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, wawancara perilaku berisiko, dan edukasi gaya hidup sehat.

D. Dasar Kebijakan dan Pedoman Resmi

Dasar utama skrining hipertensi di Indonesia dapat merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang PNPK Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Dokumen ini mengesahkan PNPK Hipertensi Dewasa sebagai pedoman bagi dokter, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait, serta menjadi acuan penyusunan standar prosedur operasional di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain PNPK, Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan juga menjadi dasar penting karena mengatur standar pelayanan dasar bidang kesehatan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 April 2024, diundangkan pada 16 April 2024, dan mencabut Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan.

Rencana Induk Posyandu 2024–2029 menjadi pedoman kelembagaan terbaru yang relevan karena menjelaskan peran Posyandu dalam enam bidang standar pelayanan minimal. Dalam bidang kesehatan, Posyandu berperan menggerakkan kunjungan sasaran, memberi penyuluhan kesehatan, melakukan deteksi dini risiko masalah kesehatan, melakukan rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau Puskesmas, serta memantau kepatuhan keluarga dalam pengobatan hipertensi dan penyakit kronis lainnya.

Pedoman internasional juga dapat digunakan sebagai penguat. WHO pada tahun 2021 menerbitkan pedoman farmakologis hipertensi orang dewasa yang

memuat rekomendasi tentang ambang memulai terapi, tindak lanjut, target tekanan darah, dan tenaga kesehatan yang dapat memulai terapi. Sementara itu, USPSTF tahun 2021 merekomendasikan skrining hipertensi pada semua orang dewasa usia 18 tahun atau lebih, dengan konfirmasi pengukuran sebelum memulai terapi.

E. Sasaran Skrining Hipertensi

Sasaran utama skrining hipertensi adalah masyarakat usia dewasa, lanjut usia, dan kelompok berisiko penyakit tidak menular. USPSTF merekomendasikan skrining hipertensi pada orang dewasa usia 18 tahun atau lebih. Dalam konteks Indonesia, kegiatan Posbindu/Posyandu PTM dapat diarahkan pada usia produktif, pralansia, lansia, serta masyarakat dengan faktor risiko seperti obesitas, riwayat keluarga hipertensi, diabetes melitus, merokok, konsumsi garam tinggi, kurang aktivitas fisik, dan stres.

Sasaran skrining juga dapat disesuaikan dengan pendekatan siklus hidup. Rencana Induk Posyandu 2024–2029 menyebutkan bahwa Posyandu berperan pada sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Oleh karena itu, skrining hipertensi dapat difokuskan pada kelompok dewasa dan lansia, tetapi edukasi pencegahan hipertensi dapat mulai diberikan sejak remaja dan usia produktif.

Kelompok prioritas dalam skrining hipertensi mencakup peserta dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya, peserta dengan keluhan sakit kepala berulang, mudah lelah, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak, riwayat stroke, riwayat penyakit ginjal, dan riwayat penyakit jantung. PNPK menekankan pentingnya menggali gejala kerusakan organ akibat hipertensi, termasuk keluhan pada otak, mata, jantung, ginjal, dan pembuluh darah perifer.

Selain sasaran individu, sasaran program juga perlu ditetapkan, misalnya seluruh warga usia ≥ 18 tahun di wilayah kerja Posbindu, warga usia ≥ 15 tahun sesuai kebijakan skrining PTM setempat, lansia di wilayah Posyandu, pekerja informal, petani, nelayan, ibu rumah tangga, atau kelompok masyarakat dengan akses rendah ke fasilitas kesehatan. Penetapan sasaran berbasis wilayah penting agar cakupan skrining dapat dihitung dan dievaluasi secara berkala.

F. Tempat Pelaksanaan Skrining

Skrining hipertensi dapat dilakukan di Posbindu PTM, Posyandu terintegrasi, Puskesmas, Pustu, unit kesehatan desa/kelurahan, kegiatan kunjungan rumah, sekolah, tempat kerja, atau kegiatan masyarakat lainnya. Dalam transformasi Posyandu, kegiatan deteksi dini risiko masalah kesehatan dan rujukan ke Puskesmas menjadi bagian dari fungsi kesehatan Posyandu.

Posbindu PTM merupakan tempat yang strategis karena dekat dengan masyarakat, berbasis partisipasi warga, melibatkan kader, dan dapat menjangkau kelompok yang tidak rutin datang ke fasilitas kesehatan. Kegiatan ini perlu berada dalam pembinaan Puskesmas agar hasil skrining memiliki tindak lanjut yang jelas, terutama bila ditemukan peserta dengan tekanan darah tinggi atau gejala komplikasi.

Pelaksanaan skrining dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan atau sesuai jadwal Posyandu/Posbindu di desa/kelurahan. Kegiatan rutin memungkinkan kader dan tenaga kesehatan memantau perubahan tekanan darah, memberikan edukasi berulang, dan memastikan peserta dengan hasil tinggi tidak hilang dari pemantauan. Prinsip kesinambungan layanan penting karena hipertensi merupakan kondisi kronis yang memerlukan pemantauan jangka panjang.

Tempat pelaksanaan harus memperhatikan kenyamanan dan ketepatan pengukuran. Area pengukuran tekanan darah sebaiknya tenang, tidak terlalu bising, memiliki kursi dengan sandaran, meja untuk meletakkan lengan, pencahayaan cukup, dan menjaga privasi peserta. Kondisi tempat yang tidak nyaman dapat memengaruhi hasil pengukuran karena peserta dapat merasa cemas, tergesa-gesa, atau tidak berada pada posisi tubuh yang benar.

G. Alat Dan Bahan Skrining Hipertensi

1. Alat utama skrining hipertensi adalah tensimeter yang valid dan layak pakai. Alat dapat berupa tensimeter digital atau alat lain yang telah tervalidasi, dengan manset sesuai ukuran lingkaran lengan peserta. Penggunaan manset yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menyebabkan hasil tekanan darah tidak akurat. Prinsip umum pengukuran tekanan darah dalam pedoman klinis menekankan pentingnya alat yang tepat dan prosedur pengukuran yang benar.
2. Kursi dengan sandaran, meja atau permukaan datar setinggi jantung untuk menopang lengan,
3. Alat tulis,
4. Formulir pencatatan,
5. Buku register Posbindu/Posyandu,
6. Media edukasi,
7. Leaflet hipertensi,
8. Kartu kontrol peserta, dan bila tersedia, sistem pencatatan digital yang terhubung dengan aplikasi kesehatan setempat.
9. Alat pendukung pengkajian faktor risiko meliputi timbangan berat badan, microtoise atau alat ukur tinggi badan, pita ukur lingkaran perut, dan formulir wawancara perilaku berisiko. Hal ini penting karena hipertensi sering berkaitan

dengan obesitas, obesitas sentral, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, merokok, dan penyakit metabolik lainnya.

10. Ketersediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau KIE juga penting. Media KIE dapat berisi pengertian hipertensi, cara membaca hasil tekanan darah, tanda bahaya, pencegahan, diet rendah garam, aktivitas fisik, berhenti merokok, kepatuhan minum obat, dan pentingnya kontrol rutin. Kemenkes memperkenalkan perilaku CERDIK untuk mencegah PTM, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.

H. Data Yang Dikaji Dalam Skrining Hipertensi

Data dasar yang perlu dikaji meliputi :

1. Nama, umur, jenis kelamin, alamat, nomor kontak, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, dan riwayat kunjungan sebelumnya. Data identitas membantu kader dan tenaga kesehatan melakukan pemantauan, terutama bila peserta memerlukan pemeriksaan ulang atau rujukan. Dalam pengkajian komunitas, data demografi juga diperlukan untuk memetakan kelompok usia atau wilayah yang paling banyak mengalami risiko hipertensi.
2. Data riwayat kesehatan yang perlu dikaji meliputi riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat minum obat antihipertensi, riwayat diabetes melitus, penyakit ginjal, penyakit jantung, stroke, dislipidemia, dan riwayat hipertensi dalam keluarga.
3. Data perilaku berisiko meliputi kebiasaan merokok, konsumsi garam tinggi, konsumsi makanan berlemak, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, pola tidur, stres, dan kepatuhan kontrol kesehatan. PNPB menyebutkan bahwa faktor risiko seperti riwayat merokok, pola diet dan konsumsi garam, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, peningkatan berat badan, dislipidemia, dan diabetes perlu digali dalam pendekatan diagnosis hipertensi.
4. Data pemeriksaan fisik sederhana meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, dan bila tersedia pemeriksaan gula darah atau kolesterol.
5. Data tindak lanjut meliputi hasil interpretasi tekanan darah, edukasi yang diberikan, keputusan rujukan, jadwal kontrol ulang, dan status kehadiran pada kunjungan berikutnya. Data ini penting untuk evaluasi program, karena keberhasilan skrining tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang diperiksa, tetapi juga dari jumlah peserta berisiko yang mendapatkan tindak lanjut

I. Prosedur Teknik Pengukuran Tekanan Darah

1. Sebelum pengukuran, peserta sebaiknya diminta duduk tenang dan beristirahat. Peserta tidak dianjurkan langsung diperiksa setelah berjalan jauh, berolahraga, merokok, minum kopi, atau berada dalam keadaan emosional. Tujuannya adalah memperoleh hasil tekanan darah yang mendekati kondisi sebenarnya, bukan hasil sementara akibat aktivitas atau stres. Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi skrining tekanan darah yang menekankan perlunya pengukuran yang benar sebelum interpretasi hasil.
2. Posisi peserta harus diperhatikan. Peserta duduk dengan punggung bersandar, kaki menapak di lantai, tidak menyilangkan kaki, lengan diletakkan pada meja atau permukaan datar setinggi jantung, dan peserta tidak berbicara selama pengukuran. Posisi yang salah dapat memengaruhi hasil tekanan darah, sehingga kader perlu dilatih agar mampu memastikan posisi peserta benar sebelum alat dijalankan.
3. Manset dipasang pada lengan atas sesuai ukuran lengan peserta. Manset tidak boleh terlalu longgar atau terlalu ketat. Bagian bawah manset diletakkan beberapa sentimeter di atas lipat siku. Bila menggunakan tensimeter digital, kader memastikan alat dalam kondisi baik, baterai cukup, dan peserta tetap diam selama alat bekerja. Bila hasil tampak sangat tinggi atau tidak sesuai kondisi peserta, pengukuran dapat diulang setelah peserta beristirahat.
4. Hasil tekanan darah dicatat dalam dua angka, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik, dengan satuan mmHg. Misalnya 130/85 mmHg atau 150/95 mmHg. Dalam SATUSEHAT, interpretasi hipertensi menggunakan kategori tekanan darah optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi.

Bila tekanan darah tinggi ditemukan pada satu kali pengukuran, kader tidak boleh langsung menyatakan peserta “pasti hipertensi” tanpa konfirmasi. Peserta perlu diberi penjelasan bahwa hasil tersebut menunjukkan tekanan darah sedang tinggi dan perlu pemeriksaan ulang atau pemeriksaan ke Puskesmas/FKTP.

J. Interpretasi Hasil Skrining

Interpretasi hasil skrining dapat mengacu pada klasifikasi tekanan darah. Berdasarkan PNPB :

1. Tekanan darah optimal adalah sistolik <120 mmHg dan diastolik <80 mmHg, tekanan darah normal adalah sistolik 120–129 mmHg dan/atau diastolik 80–84 mmHg,

2. Tekanan darah normal tinggi adalah sistolik 130–139 mmHg dan/atau diastolik 85–89 mmHg,
3. Hipertensi derajat 1 adalah sistolik 140–159 mmHg dan/atau diastolik 90–99 mmHg,
4. Hipertensi derajat 2 adalah sistolik 160–179 mmHg dan/atau diastolik 100–109 mmHg,
5. Hipertensi derajat 3 adalah sistolik ≥ 180 mmHg dan/atau diastolik ≥ 110 mmHg,
6. Hipertensi sistolik terisolasi adalah sistolik ≥ 140 mmHg dengan diastolik < 90 mmHg.

Dalam kegiatan Posbindu, interpretasi tersebut dapat disederhanakan untuk edukasi masyarakat. Peserta dengan tekanan darah normal diberi apresiasi dan edukasi mempertahankan gaya hidup sehat. Peserta dengan tekanan darah normal tinggi diberi edukasi pencegahan dan dianjurkan kontrol ulang. Peserta dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg perlu diberi edukasi, pemeriksaan ulang, dan rujukan sesuai kondisi. Peserta dengan tekanan darah sangat tinggi atau keluhan berbahaya perlu segera diarahkan ke fasilitas kesehatan.

Tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Nyeri dada,
2. sesak napas,
3. Kelemahan anggota gerak,
4. Bicara pelo,
5. Penurunan kesadaran,
6. Sakit kepala hebat mendadak,
7. Gangguan penglihatan berat,
8. Atau tekanan darah sangat tinggi.

Interpretasi hasil skrining juga harus mempertimbangkan kondisi peserta. Misalnya, peserta yang baru datang tergesa-gesa, cemas, baru merokok, atau baru minum kopi dapat menunjukkan tekanan darah lebih tinggi sementara. Oleh karena itu, pendekatan skrining harus hati-hati, tidak menakut-nakuti, dan tetap mengarahkan peserta pada pemeriksaan ulang serta perubahan perilaku sehat.

K. Tindak Lanjut Hasil Skrining

Tindak lanjut hasil skrining merupakan bagian paling penting dari kegiatan Posbindu/Posyandu PTM. Tanpa tindak lanjut, skrining hanya menjadi kegiatan pemeriksaan angka tekanan darah tanpa dampak nyata pada pengendalian hipertensi. Tindak lanjut dapat berupa edukasi, konseling singkat, pemberian kartu

kontrol, jadwal pemeriksaan ulang, kunjungan rumah, atau rujukan ke Puskesmas/FKTP.

Peserta dengan tekanan darah normal perlu diberikan edukasi mempertahankan perilaku sehat. Pesan edukasi dapat mencakup cek kesehatan secara rutin, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi garam, makan sayur dan buah, rajin aktivitas fisik, tidak merokok, tidur cukup, dan mengelola stres. Kemenkes memperkenalkan perilaku CERDIK sebagai strategi pencegahan PTM, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, istirahat cukup, dan kelola stres.

Peserta dengan tekanan darah normal tinggi atau memiliki faktor risiko perlu diberi konseling perubahan gaya hidup dan diminta kontrol ulang. Kelompok ini penting karena masih berada pada tahap pencegahan primer dan sekunder. Edukasi yang diberikan harus konkret, misalnya mengurangi garam, membatasi makanan tinggi lemak, berjalan kaki minimal beberapa kali seminggu sesuai kemampuan, berhenti merokok, serta melibatkan keluarga sebagai pendukung.

Peserta dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg perlu dirujuk atau diarahkan untuk pemeriksaan ulang di Puskesmas/FKTP. Kader perlu menjelaskan bahwa hasil skrining menunjukkan tekanan darah tinggi dan perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Penjelasan harus diberikan dengan bahasa sederhana agar peserta tidak takut, tetapi memahami pentingnya pemeriksaan lanjutan.

Peserta yang sudah terdiagnosis hipertensi dan sedang minum obat perlu dipantau kepatuhannya. Rencana Induk Posyandu 2024–2029 menyebutkan bahwa Posyandu berperan dalam pemantauan perilaku kepatuhan keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan minimal dan melaksanakan pengobatan hipertensi. Dengan demikian, kader dapat membantu mengingatkan jadwal kontrol, memotivasi minum obat teratur, dan melaporkan peserta yang tidak terkontrol kepada tenaga kesehatan.

L. Evaluasi Program Skrining Hipertensi

Evaluasi program skrining hipertensi bertujuan menilai apakah kegiatan berjalan sesuai tujuan, menjangkau sasaran, menghasilkan data yang valid, dan memberikan dampak terhadap peningkatan deteksi dini serta tindak lanjut hipertensi. Evaluasi diperlukan karena keberhasilan Posbindu tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari mutu pemeriksaan, keterjangkauan sasaran, kesinambungan rujukan, dan perubahan perilaku masyarakat.

1. Indikator input meliputi jumlah kader terlatih, ketersediaan tensimeter, ketersediaan manset yang sesuai, formulir pencatatan, media edukasi, tempat kegiatan, dan dukungan Puskesmas. Input yang baik akan memengaruhi mutu

skrining. Misalnya, tensimeter yang tidak layak atau kader yang belum memahami prosedur pengukuran dapat menghasilkan data tekanan darah yang kurang akurat.

2. Indikator proses meliputi keteraturan jadwal Posbindu, alur pelayanan, ketepatan prosedur pengukuran, kelengkapan pengkajian faktor risiko, pemberian edukasi, pencatatan, dan mekanisme rujukan. Rencana Induk Posyandu menekankan peran Posyandu dalam penyuluhan, deteksi dini risiko, rujukan, dan pemantauan kepatuhan pengobatan, sehingga indikator proses perlu mencerminkan fungsi-fungsi tersebut.
3. Indikator output meliputi jumlah peserta yang diskriming, persentase cakupan skrining terhadap sasaran, jumlah peserta dengan tekanan darah tinggi, jumlah peserta dengan faktor risiko, jumlah peserta mendapat edukasi, dan jumlah peserta dirujuk. Output ini penting untuk mengetahui besarnya masalah hipertensi yang ditemukan di komunitas.
4. Indikator outcome meliputi peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksa tekanan darah, peningkatan kunjungan ulang, peningkatan kepatuhan kontrol bagi penderita hipertensi, perubahan perilaku sehat, dan penurunan proporsi peserta dengan tekanan darah tidak terkontrol. WHO menekankan pentingnya pengendalian hipertensi karena hipertensi tidak terkontrol berdampak pada penyakit kardiovaskular, stroke, kematian dini, dan kerugian ekonomi.

M. Alur Pelayanan Skrining Hipertensi di Posbindu / Posyandu PMT

Alur pelayanan dapat dimulai dari meja pendaftaran :

1. Pada tahap ini, kader mencatat identitas peserta, mengecek apakah peserta baru atau lama, mengambil kartu kontrol, dan menanyakan riwayat singkat. Pendaftaran yang baik membantu pelacakan peserta, terutama bila peserta perlu pemeriksaan ulang atau rujukan.
2. Tahap berikutnya adalah wawancara faktor risiko. Kader dapat menanyakan riwayat hipertensi, riwayat penyakit keluarga, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, pola makan, konsumsi garam, stres, dan riwayat minum obat. PNPK menyebutkan bahwa riwayat merokok, pola diet, konsumsi garam, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, diabetes, dislipidemia, serta riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular keluarga perlu digali dalam pendekatan hipertensi.
3. Tahap ketiga adalah pengukuran antropometri, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi obesitas dan obesitas sentral sebagai faktor risiko PTM. SATUSEHAT menempatkan deteksi dini obesitas dan hipertensi sebagai bagian dari skrining PTM, sehingga pengukuran tekanan darah sebaiknya dikaitkan dengan data antropometri.

4. Tahap keempat adalah pengukuran tekanan darah. Kader atau tenaga kesehatan memastikan peserta duduk dengan benar, lengan setinggi jantung, tidak berbicara, dan dalam keadaan tenang. Hasil tekanan darah dicatat sebagai sistolik dan diastolik. Bila hasil tinggi, peserta dapat diistirahatkan dan dilakukan pengukuran ulang sesuai arahan petugas kesehatan.
5. Tahap kelima adalah interpretasi dan edukasi. Peserta diberi tahu hasil pengukuran dengan bahasa sederhana. Peserta dengan tekanan darah normal diberi edukasi mempertahankan perilaku sehat, sedangkan peserta dengan tekanan darah tinggi diberi penjelasan perlunya pemeriksaan ulang atau rujukan. Kemenkes menganjurkan perilaku CERDIK sebagai pencegahan PTM dan PATUH sebagai pesan pengendalian hipertensi bagi penderita.
6. Tahap keenam adalah rujukan dan tindak lanjut. Peserta dengan tekanan darah tinggi, gejala bahaya, atau riwayat komplikasi perlu diarahkan ke Puskesmas/FKTP. Rencana Induk Posyandu menempatkan rujukan bagi sasaran yang memiliki risiko masalah kesehatan sebagai bagian dari tugas Posyandu bidang kesehatan.

N. Peran Kader, Perawat, dan Puskesmas

1. Kader berperan sebagai penggerak masyarakat, pelaksana pendaftaran, pendamping pengukuran, pencatat hasil, pemberi edukasi sederhana, dan penghubung peserta dengan Puskesmas. Kader tidak berperan menegakkan diagnosis medis, tetapi membantu deteksi dini, edukasi, pemantauan, dan rujukan. Peran ini sejalan dengan fungsi Posyandu dalam penggerakan kunjungan, penyuluhan, deteksi dini risiko, rujukan, dan pemantauan kepatuhan pengobatan.
2. Perawat komunitas berperan dalam pembinaan kader, validasi prosedur skrining, analisis data komunitas, pendidikan kesehatan, konseling, kunjungan rumah, dan koordinasi lintas sektor. Perawat juga dapat menggunakan data Posbindu untuk menyusun diagnosis keperawatan komunitas, menetapkan prioritas masalah, merencanakan intervensi, dan mengevaluasi hasil.
3. Puskesmas berperan sebagai pembina teknis, penyedia pelatihan, penyedia atau pemeriksa kelayakan alat, penerima rujukan, pelaksana konfirmasi diagnosis, pemberi terapi, dan pengelola data program. PNPk Hipertensi Dewasa menyatakan bahwa pedoman ini dapat diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier sesuai fasilitas dan sumber daya yang tersedia.
4. Pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor berperan mendukung tempat kegiatan, mobilisasi masyarakat, pembiayaan operasional, media edukasi, serta

integrasi kegiatan Posyandu dengan program desa. Rencana Induk Posyandu 2024–2029 disusun untuk memperkuat kelembagaan dan implementasi program/kegiatan Posyandu selama lima tahun.

O. Contoh SOP Singkat Skrining Hipertensi di Posbindu / Posyandu PMT

Tujuan: mendeteksi secara dini peserta dengan tekanan darah tinggi dan faktor risiko hipertensi agar dapat diberikan edukasi, pemantauan, dan rujukan sesuai kebutuhan.

Sasaran: seluruh warga dewasa, lansia, dan kelompok berisiko PTM di wilayah kerja Posbindu/Posyandu. Dasar sasaran dapat disesuaikan dengan rekomendasi skrining hipertensi pada orang dewasa usia 18 tahun atau lebih dan pendekatan Posyandu berbasis siklus hidup.

Persiapan: kader menyiapkan tensimeter, manset sesuai ukuran, kursi, meja, formulir pencatatan, kartu kontrol, alat antropometri, media edukasi, dan daftar rujukan Puskesmas. Kesiapan alat dan pencatatan penting agar hasil skrining dapat digunakan untuk tindak lanjut individual dan evaluasi program.

Langkah kerja: peserta melakukan pendaftaran, wawancara faktor risiko, pengukuran berat badan/tinggi badan/lingkar perut, istirahat sebelum pengukuran tekanan darah, duduk dengan posisi benar, tekanan darah diukur, hasil dicatat, interpretasi disampaikan, edukasi diberikan, dan rujukan dilakukan bila perlu.

Kriteria rujukan: peserta dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg pada skrining, peserta dengan tekanan darah sangat tinggi, peserta dengan gejala bahaya, peserta dengan riwayat stroke, penyakit jantung, diabetes, ginjal, atau peserta yang sudah hipertensi tetapi tidak terkontrol. Rujukan perlu dilakukan karena skrining bukan diagnosis akhir dan tekanan darah tinggi memerlukan konfirmasi serta penatalaksanaan tenaga kesehatan.

Dokumentasi: catat tanggal, identitas peserta, hasil tekanan darah sistolik/diastolik, kategori, faktor risiko, edukasi, rujukan, dan jadwal kontrol ulang. Bila memungkinkan, pencatatan mengikuti standar terminologi SATUSEHAT untuk skrining PTM.

P. Contoh Format Pengkajian Skrining Hipertensi

A. Komponen	Data yang dikaji
Identitas	Nama, umur, jenis kelamin, alamat, nomor kontak, pekerjaan
Riwayat kesehatan	Riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, ginjal, kolesterol
Riwayat keluarga	Keluarga dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes
Perilaku risiko	Merokok, konsumsi garam tinggi, kurang aktivitas fisik, stres, alkohol
Antropometri	Berat badan, tinggi badan, IMT, lingkar perut
Tekanan darah	Sistolik, diastolik, hasil pengukuran ulang bila ada
Interpretasi	Normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, 2, 3, atau sistolik terisolasi
Edukasi	CERDIK, PATUH, diet rendah garam, aktivitas fisik, kontrol rutin
Rujukan	Ya/tidak, alasan rujukan, fasilitas rujukan
Tindak lanjut	Jadwal kontrol ulang, kunjungan rumah, pemantauan kader

“Format tersebut disusun dengan mengacu pada kebutuhan pengkajian faktor risiko hipertensi dalam PNPk, standar skrining PTM dalam SATUSEHAT, serta peran Posyandu dalam deteksi dini, penyuluhan, rujukan, dan pemantauan kepatuhan pengobatan. ”

Q. Contoh Indikator Evaluasi Program

B. Jenis indikator	Contoh indikator
Input	Jumlah kader terlatih, ketersediaan tensimeter, media edukasi, formulir skrining
Proses	Persentase peserta yang diukur dengan prosedur benar, kelengkapan pencatatan
Output	Jumlah peserta diskriminasi, jumlah peserta tekanan darah tinggi, jumlah rujukan
Outcome	Peningkatan kunjungan ulang, peningkatan kontrol tekanan darah, perubahan perilaku
Dampak	Penurunan kasus hipertensi tidak terkontrol dan komplikasi di wilayah kerja

Indikator tersebut penting karena program skrining hipertensi tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi perlu dievaluasi dari ketersediaan sumber

daya, kualitas proses, hasil deteksi dini, tindak lanjut, dan perubahan perilaku masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep perencanaan kesehatan komunitas yang menggunakan hasil pengkajian untuk menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program peningkatan Kesehatan.

R. Simpulan

Skrining hipertensi pada kegiatan Posbindu/Posyandu PTM merupakan bagian penting dari upaya deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan menemukan individu dengan tekanan darah tinggi atau faktor risiko hipertensi agar dapat segera diberikan edukasi, pemeriksaan ulang, rujukan, dan pemantauan. Pengkajian komunitas menjadi dasar penting dalam pelaksanaan skrining hipertensi karena membantu tenaga kesehatan dan kader memahami masalah kesehatan wilayah, kelompok berisiko, faktor perilaku, ketersediaan sumber daya, serta hambatan akses layanan. Data hasil pengkajian dapat digunakan untuk menyusun intervensi promotif-preventif berbasis kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan skrining hipertensi harus memperhatikan prosedur pengukuran tekanan darah yang benar, alat yang layak, pencatatan yang rapi, interpretasi yang tepat, dan tindak lanjut yang jelas. Batas tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dapat digunakan sebagai tanda kecurigaan hipertensi, tetapi diagnosis tetap memerlukan konfirmasi oleh tenaga kesehatan. Dalam transformasi layanan primer, Posyandu memiliki peran yang semakin luas, termasuk melayani sasaran dewasa dan lanjut usia, melakukan penyuluhan, deteksi dini risiko, rujukan, dan pemantauan kepatuhan pengobatan hipertensi. Oleh karena itu, Posbindu/Posyandu PTM perlu diperkuat sebagai ujung tombak pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis masyarakat.

S. Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Community planning for health assessment: Community health assessment and community health improvement planning*. CDC.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Community planning for health assessment: Index*. CDC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi*

Dewasa. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Kendalikan hipertensi dengan gerakan PATUH*. Ayo Sehat Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Perilaku CERDIK dalam mencegah penyakit tidak menular*. Ayo Sehat Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Bahaya hipertensi, upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan*. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024/2025). *Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM): SATUSEHAT Platform*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024/2025). *Lampiran terminologi skrining penyakit tidak menular: Interpretasi hipertensi*. SATUSEHAT Platform.

Tim Pembina Posyandu Pusat. (2024). *Rencana Induk Posyandu Tahun 2024–2029*. Tim Pembina Posyandu Pusat.

U.S. Preventive Services Task Force. (2021). *Hypertension in adults: Screening*. USPSTF.

World Health Organization. (2021). *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*. WHO.

World Health Organization. (2023). *Global report on hypertension: The race against a silent killer*. WHO.

Aling, Y., Wowor, R. E., & Rumayar, A. A. (2025). *Gambaran pelaksanaan program Posbindu PTM dalam mencegah kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru Kota Manado*. Jurnal Kesehatan Tambusai, 6(2). doi:10.31004/jkt.v6i2.43565.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Community planning for health assessment: Community health assessment and community health improvement planning*.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Community planning for health assessment: Data and benchmarks*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Posyandu semakin siap melayani masyarakat semua usia*. Ayo Sehat Kemenkes.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Bahaya hipertensi, upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024/2025). *Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM): SATUSEHAT Platform*.
- Santoso, P., Pujiyanto, T., & Nurita, N. (2025). *Pengaruh promosi kesehatan tentang hipertensi melalui Posbindu PTM terhadap perilaku deteksi dini tekanan darah pada masyarakat usia produktif*. Jurnal Ilmu Kesehatan, 13(2). doi:10.32831/jik.v13i2.857.
- U.S. Preventive Services Task Force. (2021). *Hypertension in adults: Screening*.
- Widyaningsih, V., Febrinasari, R. P., Pamungkasari, E. P., Mashuri, Y. A., Sumardiyono, Balgis, Koot, J., Landsman-Dijkstra, J., & Probandari, A. (2022). *Missed opportunities in hypertension risk factors screening in Indonesia: A mixed-methods evaluation of integrated health post (POSBINDU) implementation*. BMJ Open, 12, e051315. doi:10.1136/bmjopen-2021-051315.
- World Health Organization. (2021). *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*.
- World Health Organization. (2023). *Global report on hypertension: The race against a silent killer*.

T. Glosarium

PNPK : Pelayanan Nasional Pelayanan Kedokteran
 PTM : Penyakit tidak menular
 CDC : Centers for Disease Control and Prevention
 SKI : Survei Kesehatan Nasional
 WHO : Word Healyh Organisation

CHAPTER 4

EDUKASI KESEHATAN TENTANG POLA MAKAN, AKTIVITAS FISIK DAN GAYA HIDUP SEHAT

Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep

A. Pendahuluan

Keperawatan komunitas merupakan suatu bidang spesialisasi keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan ilmu kesehatan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara luas. American Nurses Association (ANA) mendefinisikan keperawatan komunitas sebagai sintesis praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan populasi (Stanhope & Lancaster, 2020). Landasan teori keperawatan komunitas bersumber dari berbagai perspektif, di antaranya Teori Health Belief Model yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan individu dalam melakukan tindakan kesehatan preventif, serta Teori Promosi Kesehatan Nola Pender yang menegaskan bahwa perilaku sehat terbentuk melalui interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Dalam praktiknya, perawat komunitas menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama, dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif sebelum kuratif dan rehabilitatif.

Secara konseptual, peran perawat komunitas mencakup enam dimensi utama sebagaimana dirumuskan oleh Stanhope & Lancaster, (2020) yaitu peran sebagai pemberi asuhan langsung (*care provider*), pendidik kesehatan (*health educator*), manajer kasus (*case manager*), advokat (*advocate*), konsultan (*consultant*), dan kolaborator (*collaborator*). Dalam konteks pencegahan hipertensi, peran pendidik kesehatan menjadi sangat dominan, karena perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat memerlukan intervensi edukasi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Suhat et al., (2022) mengemukakan bahwa intervensi edukasi kesehatan berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat komunitas, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai faktor risiko, pencegahan, dan pengendalian hipertensi.

B. Konsep Posbindu

Landasan hukum praktik keperawatan komunitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang memberikan kewenangan kepada perawat untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pada lingkup kesehatan masyarakat, perawat berwenang melakukan pengkajian kesehatan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi kesehatan, kemitraan, penyuluhan, dan konseling. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 yang menegaskan peran Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat berbasis promotif-preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan UKBM, termasuk Posbindu PTM (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Dalam operasional Posbindu PTM, perawat komunitas menjalankan fungsi teknis dan manajerial secara sinergis. Secara teknis, perawat bertugas melakukan skrining faktor risiko PTM (pengukuran tekanan darah, antropometri, glukosa darah, dan kolesterol), memberikan konseling individual, serta merujuk kasus yang memerlukan tatalaksana lanjutan. Secara manajerial, perawat berperan dalam melatih kader Posbindu, mengoordinasikan jadwal kegiatan, mendokumentasikan hasil pemantauan, dan menganalisis tren data kesehatan komunitas. Fungsi ganda ini menempatkan perawat komunitas sebagai motor penggerak yang menentukan efektivitas dan keberlangsungan Posbindu sebagai ujung tombak pencegahan PTM di tingkat komunitas (Kemenkes RI, 2019).

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan, dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Posbindu PTM dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya beban PTM di Indonesia, termasuk hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan kanker, yang secara kolektif menjadi penyebab kematian dominan dengan proporsi mencapai 73% dari total kematian nasional (Kemenkes RI, 2019). Secara konseptual, Posbindu PTM mengadopsi pendekatan *community-based health promotion* yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek layanan, melainkan sebagai subjek aktif yang berdaya dalam mengelola kesehatannya sendiri.

Kegiatan Posbindu memiliki pijakan regulasi yang komprehensif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular merupakan regulasi utama yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan sistem deteksi dini PTM berbasis masyarakat. Peraturan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (Germas) yang menjadikan deteksi dini penyakit sebagai salah satu dari tujuh komponen Germas (Indonesia, 2015). Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mewajibkan Puskesmas untuk membina dan mengembangkan Posbindu PTM di wilayah kerjanya sebagai bagian integral dari upaya kesehatan berbasis Masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Tujuan utama Posbindu PTM adalah: (1) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM; (2) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya PTM; (3) memperkuat layanan terpadu PTM di fasilitas kesehatan primer. Secara empiris, Posbindu PTM telah terbukti berkontribusi pada peningkatan cakupan skrining hipertensi dan PTM lainnya. Data BKKK Kementerian Kesehatan RI, (2023) menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 87,3% telah memiliki Posbindu PTM aktif, dengan total lebih dari 70.000 Posbindu tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perawat komunitas memiliki peran penting di Masyarakat. Selain itu, Ginting, (2023) mengemukakan bahwa Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) bergantung pada kolaborasi antara seluruh komunitas yang prihatin terhadap ancaman PTM melalui Posbindu PTM.

Posbindu PTM merupakan upaya partisipatif masyarakat dalam deteksi dini dan pemantauan faktor risiko utama PTM secara terstruktur, terjadwal, dan berkala. Perawat komunitas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi. Tugas yang diemban tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, edukator gaya hidup sehat, dan pembina kader kesehatan lokal. Di Puskesmas Sako, Palembang, model intervensi melalui pembentukan “Komunitas Sahabat Peduli Hipertensi” terbukti meningkatkan kepatuhan minum obat dari 55% menjadi 84,5% dalam waktu satu bulan, sekaligus meningkatkan frekuensi pengukuran tekanan darah dari sebulan sekali menjadi sekali seminggu (Simamora et al., 2025;Risnawati et al., 2026). Namun, praktik keperawatan komunitas dalam pengendalian hipertensi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan geografis, dan kurangnya integrasi antara sistem layanan formal dengan peran kader. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap pengobatan tetap menjadi isu sentral, terutama di kalangan laki-laki dan individu berpendidikan rendah yang cenderung mengabaikan gejala dan enggan mengakses layanan kesehatan (Robby & Ma’rufi, 2025;Risnawati et al., 2026)

C. Konsep dan Pencegahan Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai kondisi di mana tekanan darah sistolik secara konsisten berada pada nilai ≥ 130 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 80 mmHg berdasarkan panduan American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 2017. Sementara itu, WHO masih menggunakan ambang batas $\geq 140/90$ mmHg sebagai definisi operasional hipertensi dalam konteks global. Secara patofisiologis, hipertensi primer (esensial) yang mencakup 90-95% kasus, terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan yang memengaruhi curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer. Sedangkan hipertensi sekunder (5-10% kasus) merupakan manifestasi dari kondisi medis yang mendasarinya seperti penyakit ginjal, gangguan hormonal, atau efek samping obat-obatan tertentu (Whelton et al., 2017).

Hipertensi diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya: normal ($<120/80$ mmHg), elevated ($120-129/<80$ mmHg), hipertensi stage 1 ($130-139/80-89$ mmHg), dan hipertensi stage 2 ($\geq 140/\geq 90$ mmHg). Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi obesitas, konsumsi garam berlebih, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan stres psikologis. Sementara faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi mencakup usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan ras/etnis. Pemahaman mendalam tentang faktor risiko ini menjadi landasan bagi perawat komunitas dalam merancang intervensi edukasi yang tepat sasaran (WHO, 2023).

Secara global, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan penyebab kematian prematur yang dapat dicegah. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi, dengan sekitar dua pertiga di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Lebih mengkhawatirkan, hampir setengah dari penderita hipertensi global (46%) tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kondisi ini. Secara tren temporal, prevalensi hipertensi global mengalami peningkatan dari 594 juta kasus pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015 (NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), 2017), dan terus meningkat hingga 1,28 miliar pada tahun 2023. Proyeksi WHO memperkirakan jumlah ini dapat mencapai 1,5 miliar pada tahun 2025 jika tidak ada intervensi yang efektif.

Di Indonesia, hipertensi merupakan PTM dengan prevalensi tertinggi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi hipertensi pada penduduk dewasa (≥ 18 tahun) mengalami peningkatan yang konsisten: dari 25,8%

pada tahun 2013, meningkat menjadi 34,1% pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi hipertensi sebesar 29,9% pada penduduk usia ≥ 15 tahun, yang setara dengan sekitar 63 juta penduduk Indonesia. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi metodologi survei, beban hipertensi di Indonesia tetap sangat tinggi. Lebih memprihatinkan, cakupan pengobatan hipertensi masih rendah: hanya 54,4% penderita yang pernah didiagnosis, 40,0% yang sedang minum obat antihipertensi, dan 8,8% yang tekanan darahnya terkontrol (BKPK Kementerian Kesehatan RI, 2023). Data ini menegaskan urgensi upaya deteksi dini dan pencegahan berbasis komunitas melalui Posbindu PTM.

Pencegahan hipertensi berdasarkan stratifikasi risiko mencakup tiga level: pencegahan primer (mencegah terjadinya hipertensi pada individu sehat), pencegahan sekunder (deteksi dini dan tatalaksana untuk mencegah komplikasi), dan pencegahan tersier (rehabilitasi untuk meminimalkan kecacatan akibat komplikasi). Di Posbindu PTM, ketiganya diintegrasikan dalam satu sistem layanan terpadu. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan secara konkret meliputi: modifikasi diet (pengurangan asupan natrium, peningkatan konsumsi kalium, buah, dan sayur melalui pendekatan DASH diet), peningkatan aktivitas fisik aerobik minimal 150 menit/minggu, pengendalian berat badan, penghentian merokok dan konsumsi alkohol, serta manajemen stres. Perawat komunitas di Posbindu berperan menerjemahkan rekomendasi klinis ini ke dalam intervensi edukasi yang kontekstual, terukur, dan aplikatif sesuai kondisi sosiobudaya masyarakat setempat (Kemenkes RI, 2019; Whelton et al., 2017).

D. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Pola Makan Untuk Pencegahan Hipertensi

Edukasi kesehatan tentang pola makan merupakan salah satu intervensi keperawatan komunitas yang paling fundamental dalam pencegahan hipertensi. Perawat komunitas tidak sekadar menyampaikan informasi tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, melainkan menjalankan proses pembelajaran yang terencana dengan tujuan menghasilkan perubahan perilaku makan yang berkelanjutan. Proses ini dilandasi oleh Health Promotion Model Nola Pender yang menegaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan memerlukan integrasi antara pengetahuan (*cognitive*), kepercayaan diri (*self-efficacy*), dan lingkungan yang mendukung. Edukasi pola makan merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan hipertensi karena mampu meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan Health Promotion Model yang menekankan pentingnya faktor kognitif, self-efficacy,

dan dukungan lingkungan dalam pembentukan perilaku sehat (Pender et al., 2019; Rojas-torres et al., 2025). Dalam Posbindu PTM, perawat komunitas berperan sebagai edukator dan fasilitator yang membantu masyarakat memahami hubungan antara pola makan dan tekanan darah melalui kegiatan edukasi dan konseling kesehatan (Sumarni & Setyaningsih, 2019; Aling et al., 2025).

Secara teoritis, pendekatan edukasi gizi untuk pencegahan hipertensi yang paling berbasis bukti adalah DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet, yang dikembangkan melalui serangkaian uji klinis terkontrol. Pendekatan DASH menekankan: peningkatan konsumsi buah-buahan (4-5 porsi/hari), sayuran (4-5 porsi/hari), produk susu rendah lemak (2-3 porsi/hari), biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein nabati; serta pembatasan asupan natrium (tidak lebih dari 2.300 mg/hari, idealnya 1.500 mg/hari), lemak jenuh, lemak trans, makanan dan minuman manis, serta alkohol. Hasil penelitian Mahdavi et al., (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap DASH diet dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4,26 mmHg dan diastolik 2,38 mmHg pada individu non-hipertensi, serta lebih besar lagi pada penderita hipertensi.

Adaptasi prinsip Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) ke dalam konteks budaya kuliner Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang dalam praktik keperawatan komunitas. Pola konsumsi masyarakat Indonesia masih ditandai oleh tingginya penggunaan bahan pangan dan bumbu yang mengandung natrium, seperti kecap, ikan asin, terasi, makanan fermentasi, serta berbagai produk olahan yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko hipertensi. Sebaliknya, Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal yang kaya kalium, magnesium, serat, dan protein nabati, seperti pisang, ubi jalar, singkong, tempe, tahu, serta berbagai jenis sayuran hijau yang sejalan dengan prinsip DASH yang menekankan konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, dan pangan rendah natrium. Oleh karena itu, perawat komunitas perlu mengembangkan strategi edukasi yang mempertimbangkan budaya makan lokal dan mendorong modifikasi diet yang realistis serta dapat diterima masyarakat, misalnya melalui pengurangan garam secara bertahap, peningkatan konsumsi buah dan sayuran, serta substitusi makanan ringan tinggi natrium dengan pangan lokal yang lebih sehat. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap diet DASH dan perubahan perilaku kesehatan pada penderita hipertensi (Rohmah et al., 2023).

Efektivitas edukasi kesehatan di Posbindu sangat ditentukan oleh pemilihan media yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Media edukasi yang terbukti efektif di komunitas mencakup: leaflet dan poster bergambar yang menggunakan bahasa sederhana dan visual yang menarik untuk menyampaikan

pesan gizi praktis; flipchart yang memudahkan perawat dalam memberikan penjelasan tahap demi tahap; food model (model makanan tiga dimensi) yang membantu masyarakat memahami ukuran porsi secara konkret; video edukasi yang dapat diputar di layar di area Posbindu; serta aplikasi mobile health yang semakin relevan di era digital. Penelitian Wijaya et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual dalam edukasi gizi di Posbindu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola makan untuk pencegahan hipertensi secara signifikan dibandingkan metode ceramah konvensional ($p=0,003$).

Perawat komunitas menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan edukasi pola makan di Posbindu. Pertama, resistensi budaya terhadap perubahan kebiasaan makan yang telah mengakar secara turun-temurun. Banyak masyarakat memandang makanan asin dan gurih sebagai bagian dari identitas kuliner yang sulit dilepaskan. Kedua, keterbatasan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat sulit mengakses bahan makanan sehat berkualitas secara konsisten. Ketiga, rendahnya literasi gizi yang menyebabkan masyarakat kesulitan memahami label pangan, takaran saji, dan komposisi nutrisi makanan kemasan. Keempat, waktu Posbindu yang terbatas (umumnya 4-5 jam sebulan sekali) sering tidak cukup untuk memberikan edukasi yang mendalam. Kelima, fluktuasi kehadiran peserta Posbindu yang menyulitkan kontinuitas program edukasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perawat komunitas perlu mengembangkan strategi edukasi yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, memanfaatkan media sosial sebagai saluran edukasi tambahan, serta berkolaborasi dengan lintas sektor termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan PKK (Rahayu et al., 2021).

E. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Aktivitas Fisik Untuk Pencegahan Hipertensi

Edukasi tentang aktivitas fisik merupakan komponen kritis dalam intervensi pencegahan hipertensi berbasis komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari modifikasi diet. Perawat komunitas memiliki peran sentral dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup aktif melalui pendekatan yang bersifat individual, kontekstual, dan berbasis motivasi. Secara teoritis, pendekatan ini dilandasi oleh Transtheoretical Model (TTM) atau Model Tahapan Perubahan yang dikembangkan oleh Prochaska dan DiClemente, yang mengakui bahwa kesiapan individu untuk berubah berada pada tahapan yang berbeda-beda: prarencana, renungan, persiapan, aksi, dan pemeliharaan. Perawat komunitas perlu mengidentifikasi tahapan kesiapan setiap sasaran dan menyesuaikan intervensi edukasinya secara individual (Stanhope & Lancaster, 2020).

Peran perawat komunitas dalam edukasi aktivitas fisik di Posbindu mencakup: (1) memberikan informasi berbasis bukti tentang manfaat aktivitas fisik terhadap pengendalian tekanan darah; (2) membantu masyarakat mengidentifikasi jenis dan intensitas aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan preferensi mereka; (3) mengorganisasi demonstrasi dan latihan aktivitas fisik kelompok di area Posbindu; (4) memantau respons tekanan darah terhadap program aktivitas fisik yang dijalani peserta; dan (5) berkoordinasi dengan tenaga fisioterapi atau instruktur kebugaran dalam merancang program latihan yang aman, khususnya bagi peserta dengan komorbiditas. Penelitian Fatmawati et al. (2022) membuktikan bahwa program edukasi aktivitas fisik terstruktur yang dikelola perawat komunitas di Posbindu secara signifikan meningkatkan tingkat aktivitas fisik dan menurunkan tekanan darah peserta setelah 3 bulan intervensi.

Berdasarkan panduan WHO, (2020) tentang aktivitas fisik dan perilaku sedentari, orang dewasa direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang minimal 150-300 menit per minggu, atau 75-150 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu, atau kombinasi keduanya yang setara. Selain itu, latihan penguatan otot direkomendasikan dilakukan minimal 2 hari per minggu. Dalam konteks pencegahan hipertensi, berbagai jenis aktivitas fisik telah terbukti efektif secara ilmiah, antara lain: Pertama, latihan aerobik (*endurance training*) seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, dan senam aerobik. Cornelissen et al., (2012) menunjukkan bahwa latihan aerobik reguler dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 3,84 mmHg dan diastolik 2,58 mmHg. Jalan kaki cepat selama 30 menit per hari, 5 hari per minggu, merupakan rekomendasi yang paling feasible untuk diterapkan dalam konteks komunitas Indonesia, mengingat tidak memerlukan peralatan khusus, dapat dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal, dan bersifat low-impact sehingga aman bagi berbagai kelompok usia.

Kedua, latihan resistensi (*resistance training*) atau latihan kekuatan otot dengan menggunakan beban tubuh sendiri (*push-up*, *squat*, *lunges*) atau beban ringan. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi latihan aerobik dan resistensi memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pengendalian tekanan darah dibandingkan masing-masing modalitas secara terpisah (Lopes et al., 2021).

Ketiga, senam hipertensi yang merupakan program latihan fisik terstandar yang dikembangkan secara khusus untuk pencegahan dan pengendalian hipertensi. Senam ini mengintegrasikan gerakan aerobik ringan-sedang, latihan fleksibilitas, dan teknik relaksasi dalam satu sesi latihan 30-45 menit. Senam hipertensi telah menjadi program unggulan di berbagai Posbindu PTM di Indonesia dan terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah peserta yang dilakukan secara rutin (Fatmawati et al., 2022).

Keempat, yoga dan meditasi yang menggabungkan latihan pernapasan, postur tubuh (asana), dan meditasi. Bai et al., (2015) mengemukakan bahwa praktik yoga reguler dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 5,21 mmHg melalui mekanisme penurunan aktivitas sistem saraf simpatis, peningkatan fleksibilitas pembuluh darah, dan pengurangan stres psikologis.

F. Peran Perawat Komunitas Dalam Edukasi Kesehatan Tentang Gaya Hidup Sehat Untuk Pencegahan Hipertensi

Gaya hidup sehat (healthy lifestyle) dalam konteks pencegahan hipertensi didefinisikan sebagai totalitas kebiasaan, perilaku, dan pilihan sehari-hari yang secara kolektif berkontribusi pada pemeliharaan tekanan darah dalam rentang normal dan pengurangan risiko penyakit kardiovaskular. Konsep ini melampaui dimensi diet dan aktivitas fisik, mencakup juga manajemen stres, kualitas tidur, perilaku tidak merokok, penghindaran alkohol, serta pemantauan kesehatan secara berkala. menegaskan bahwa modifikasi gaya hidup merupakan intervensi lini pertama yang direkomendasikan untuk semua individu dengan tekanan darah elevated atau hipertensi stage 1 sebelum mempertimbangkan terapi farmakologis.

Teori yang relevan dalam memahami perubahan gaya hidup untuk pencegahan hipertensi mencakup Social Cognitive Theory (SCT) Bandura yang menekankan peran efikasi diri (*self-efficacy*) dan modeling sosial dalam pembentukan perilaku sehat. Individu yang memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya untuk mengubah gaya hidup (*high self-efficacy*) terbukti lebih berhasil dalam mengadopsi dan mempertahankan perilaku hidup sehat dibandingkan mereka yang merasa tidak mampu berubah. Perawat komunitas bertugas membangun efikasi diri masyarakat melalui edukasi yang memberikan informasi konkret, demonstrasi yang mudah ditiru, dan dukungan motivasional yang berkelanjutan (Stanhope & Lancaster, 2020).

Perawat komunitas memainkan peran kunci dalam mendorong transformasi gaya hidup masyarakat melalui berbagai pendekatan edukasi yang terintegrasi di Posbindu. Pertama, perawat berperan sebagai role model yang mencontohkan gaya hidup sehat dalam kehidupan profesionalnya, mengingat bahwa modeling sosial merupakan mekanisme pembelajaran yang kuat, khususnya dalam konteks komunitas. Kedua, perawat berperan sebagai konselor yang membantu masyarakat mengidentifikasi hambatan personal dalam mengadopsi gaya hidup sehat dan merumuskan strategi yang realistis untuk mengatasinya. Ketiga, perawat berperan sebagai penghubung (*connector*) yang memobilisasi sumber daya komunitas termasuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk gaya hidup sehat.

Pendekatan Motivational Interviewing (MI) terbukti efektif digunakan perawat komunitas dalam memfasilitasi perubahan gaya hidup. MI adalah metode konseling direktif, berpusat pada klien, yang membantu individu mengeksplorasi dan menyelesaikan ambivalensi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Rubio-Valera et al., (2014) mengemukakan bahwa intervensi MI yang dilakukan tenaga kesehatan primer secara signifikan meningkatkan adopsi perilaku hidup sehat termasuk berhenti merokok, peningkatan aktivitas fisik, dan perbaikan pola makan pada pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi.

Beberapa perilaku gaya hidup yang terbukti meningkatkan risiko hipertensi dan perlu dijadikan target perubahan dalam program edukasi Posbindu adalah sebagai berikut. Pertama, kebiasaan merokok: nikotin dan karbon monoksida dalam rokok menyebabkan vasokonstriksi akut, kerusakan endotel pembuluh darah, peningkatan kadar katekolamin, dan akselerasi aterosklerosis yang secara kumulatif meningkatkan tekanan darah. Merokok meningkatkan risiko hipertensi sebesar 2-3 kali dibandingkan bukan perokok (WHO, 2023). Perawat komunitas perlu menyampaikan informasi ini dengan cara yang empatik, non-judgmental, sambil menawarkan dukungan bagi perokok yang ingin berhenti.

Kedua, konsumsi alkohol berlebihan: konsumsi alkohol lebih dari 2 unit per hari pada pria dan 1 unit per hari pada wanita berhubungan secara dosis-respons dengan peningkatan tekanan darah. Mekanismenya mencakup stimulasi sistem saraf simpatis, peningkatan aktivitas renin-angiotensin, dan induksi stres oksidatif. Ketiga, perilaku sedentari (*sedentary behavior*) berupa kebiasaan duduk atau berbaring lebih dari 8 jam per hari yang meningkatkan risiko obesitas, resistensi insulin, dan hipertensi. Keempat, konsumsi makanan ultraproses (*ultra-processed food*) yang tinggi natrium, gula tambahan, dan lemak trans, yang kini semakin mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat dari berbagai lapis sosial ekonomi. Kelima, manajemen stres yang tidak adaptif seperti penyangkalan, menghindari masalah, atau mengonsumsi alkohol dan makanan berlebih sebagai respons terhadap tekanan psikologis (Whelton et al., 2017).

Selain menghindari perilaku berisiko, masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi serangkaian gaya hidup positif yang secara sinergis memberikan perlindungan terhadap hipertensi. Pertama, manajemen stres yang efektif: tekanan psikologis kronis mengaktifkan sistem saraf simpatis dan aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal yang meningkatkan tekanan darah. Teknik manajemen stres yang terbukti efektif mencakup relaksasi progresif, pernapasan diafragma, *mindfulness meditation*, dan aktivitas hobi yang menyenangkan. Penelitian Schultchen et al., (2019) menunjukkan bahwa intervensi *mindfulness* berbasis komunitas secara

signifikan menurunkan persepsi stres dan tekanan darah pada individu prehipertensi.

Kedua, pemantauan tekanan darah mandiri (self-monitoring): membiasakan diri mengukur tekanan darah secara rutin di rumah menggunakan tensimeter digital meningkatkan kesadaran individu tentang kondisi kesehatannya dan mendorong kepatuhan terhadap modifikasi gaya hidup yang direkomendasikan. Ketiga, kualitas tidur yang optimal: tidur malam 7-9 jam per malam merupakan salah satu faktor protektif terhadap hipertensi. Durasi tidur yang kurang dari 6 jam per malam secara konsisten berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan risiko hipertensi sebesar 20-32% (Lopes et al., 2021). Keempat, mempertahankan berat badan ideal: setiap penurunan berat badan sebesar 1 kg diestimasi berkontribusi pada penurunan tekanan darah sistolik sebesar 1 mmHg. Target BMI 18,5-24,9 kg/m² merupakan rekomendasi standar untuk pencegahan hipertensi.

Kelima, pemeriksaan kesehatan berkala melalui Posbindu: kehadiran rutin di Posbindu untuk pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan antropometri memungkinkan deteksi dini perubahan faktor risiko sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Perawat komunitas perlu mempromosikan Posbindu tidak hanya sebagai tempat pemeriksaan, melainkan sebagai komunitas belajar kesehatan yang menyenangkan, inklusif, dan memberdayakan. Keenam, dukungan sosial dan keterlibatan komunitas: bergabung dengan kelompok senam, pengajian kesehatan, atau komunitas peduli hipertensi di tingkat RT/RW memberikan dukungan sosial yang memperkuat motivasi individu dalam mempertahankan gaya hidup sehat jangka panjang (Kartika et al., 2022).

Sintesis dari keenam poin gaya hidup sehat ini menegaskan bahwa pencegahan hipertensi bukan sekadar intervensi medis individual, melainkan transformasi budaya kesehatan yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Perawat komunitas, melalui perannya yang multidimensional di Posbindu, merupakan katalisator utama yang menggerakkan transformasi ini secara sistematis, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

G. Referensi

- Aling, Y. N. M., Wowor, R. E., & Rumayar, A. A. (2025). GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM POSBINDU PTM DALAM PUSKESMAS TIKALA BARU KOTA MANADO. *JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI*, 6, 4425–4437.
- Bai, Z., Chang, J., Chen, C., Li, P., Yang, K., & Chi, I. (2015). Investigating the effect of transcendental meditation on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Human Hypertension*, December 2014, 1–10. <https://doi.org/10.1038/jhh.2015.6>

- BKPK Kementerian Kesehatan RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI). In *Kemenkes*. Kementerian Kesehatan RI.
- Cornelissen, V. A., Smart, N. A., & Survey, N. E. (2012). Exercise Training for Blood Pressure: A Systematic Review and Meta- analysis. *Journal of the American Heart Association*, 1–9. <https://doi.org/10.1161/JAHA.112.004473>
- Fatmawati, R., Suharto, S., & Wijayanti, R. A. (2022). Efektivitas program senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah peserta Posbindu PTM di Kota Semarang. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 10(2), 89–97. <https://doi.org/10.26714/jkj.10.2.2022.89-97>
- Ginting, A. (2023). Pelatihan dan pendampingan kader posbindu dalam pengendalian hipertensi. *Jurnal Mandira Cendikia*, 3(3), 67–72.
- Indonesia. (2015). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR* (pp. 1–15). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kartika, L., Sari, D. N., & Mulyadi, M. (2022). Pengaruh edukasi kesehatan berbasis keluarga terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pencegahan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 144–153. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.1788>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*.
- Lopes, S., José Mesquita-Bastos, C. G., Susana Bertoquini, V. R., Teixeira, M., Ribeiro, I. P., Melo, J. B., Oliveira, J., Daniela Figueiredo, Guilherme V Guimarães, L. S. P., Polonia, J., Alves, A. J., & Ribeiro, F. (2021). Effect of Exercise Training on Ambulatory Blood Pressure Among Patients With Resistant Hypertension. *JAMA Cardiology*, 1(11), 1317–1323. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.2735>
- Mahdavi, A., Mohammadi, H., Foshati, S., Cain, N. S., Alireza, C. T. C., & Rouhani, M. H. (2021). Effects of the dietary approach to stop hypertension (DASH) diet on blood pressure , blood glucose , and lipid profile in adolescents with hemophilia : A randomized clinical trial. *Food Science & Nutrition*, October 2020, 145–153. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1972>
- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). (2017). Articles Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015 : a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19 · 1 million participants. *Lancet*, 389, 37–55. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31919-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31919-5)
- Nurhidayah, I., Hendrawati, S., & Adistie, F. (2022). Adaptasi DASH diet dalam konteks budaya pangan lokal Indonesia: Kajian literatur untuk praktik keperawatan komunitas. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 10(1), 55–64. <https://doi.org/10.24198/jkp.v10i1.1810>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN* (pp. 1–52). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT* (pp. 1–158). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rahayu, S., Supratman, S., & Santoso, B. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Posbindu PTM dalam pengendalian hipertensi di wilayah perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(2), 91–99. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i2.4312>
- Risnawati, K., Sari, N. P., Keperawatan, D., Kesehatan, F. I., & Muhammadiyah, U. (2026). Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi: Telaah Issue dan Trend Intervensi Berbasis Komunitas di Indonesia: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 3(1), 1018–1027. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.8308> Peran
- Robby, K. N. A., & Ma'rufi, I. (2025). MODEL MANAJEMEN EPIDEMIOLOGI HIPERTENSI BERBASIS KOMUNITAS PESISIR. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13, 145–160.
- Rohmah, Z. A., Widajati, E., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) Diet Terhadap Asupan Kalium dan Natrium Penderita Hipertensi (Studi Literatur). *HARENA: Jurnal Gizi Vol.*, 3(3), 106–112.
- Rojas-torres, I. L., Dávila, C. M. G., Gómez, K. S. R., Aragón, S. P. F., Perea-rojas, D. M., Olmos, G. M. R., & Meléndez, N. I. L. (2025). Effectiveness of Nola Pender ' s Health Promotion Model : A Comprehensive Approach for Enhancing Healthy Behaviors and Quality of Life in Adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health Research*, 22, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph22101506>
- Rubio-Valera, M., Pons-Vigue's, M., Mari'a Martí'nez-Andre's, P. M.-P., Berenguera, A., & Fernandez, A. (2014). Barriers and Facilitators for the Implementation of Primary Prevention and Health Promotion Activities in Primary Care : A Synthesis through Meta-Ethnography. *PLOS ONE*, 9(2), e89554. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089554>
- Schultchen, D., Reichenberger, J., Mittl, T., Weh, T. R. M., Smyth, J. M., Blechert, J., & Pollatos, O. (2019). Bidirectional relationship of stress and affect with physical activity and healthy eating. *British Journal of Health Psychology*, 24, 315–333. <https://doi.org/10.1111/bjhp.12355>
- Simamora, S., Mangunsong, S., & Rulianti, M. R. (2025). PEMBENTUKAN KOMUNITAS

SAHABAT PEDULI HIPERTENSI UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN MENJALANI HIDUP SEHAT DI PUSKESMAS SAKO PALEMBANG. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 8(1), 61–70.

- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in The Community* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Suhat, S., Suwandono, A., Adi, M. S., & Nugroho, K. H. H. S. (2022). The Influence of a Health Education Intervention on Hypertension-related Knowledge, Attitude and Family Support in Cimahi City: A Quasi Experimental Study. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18(8), 31–38.
- Sumarni, T., & Setyaningsih, R. D. (2019). EDUKASI TATA LAKSANA NON FARMAKOLOGI UNTUK PENCAPAIAN TEKANAN DARAH TERKONTROL PADA PENYANDANG HIPERTENSI DI POSBINDU PTM DESA DUKUHWALUH KEMBARAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 64–68.
- Whelton, P. K., Carey, R., Aronow, W., Casey Jr, D., Dennison, C. K., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Sidney C. Smith, J., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., Williamson, J. D., & Jackson T. Wright, J. (2017). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Journal of the American College of Cardiology*. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006>
- WHO. (2020). *Who guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization; 2020.
- WHO. (2023). *Global report on hypertension: the race against a silent killer*. World Health Organization 2023.
- Wijaya, A. K., Rosyidah, I., & Hidayati, T. (2023). Efektivitas media audiovisual dalam meningkatkan pengetahuan gizi untuk pencegahan hipertensi pada peserta Posbindu PTM. *Media Gizi Indonesia*, 18(1), 24–32. <https://doi.org/10.20473/mgi.v18i1.24-32>

H. Glosarium

ACC/AHA	: American College of Cardiology/American Heart Association
DASH	: Dietary Approaches to Stop Hypertension
PTM	: Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SKI	: Survei Kesehatan Indonesia
WHO	: World Health Organization

CHAPTER 5

PEMBERDAYAAN KADER DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI

Antok Nurwidi Antara, S.Kep.Ns., M.Kep..

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia (*World Health Organization, 2021*). Kondisi ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara persisten yang dapat menyebabkan kerusakan organ target seperti jantung, otak, ginjal, dan pembuluh darah (*World Health Organization, 2021*). Hipertensi juga berkontribusi besar terhadap kejadian penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung koroner (*World Health Organization, 2021*).

Di Indonesia, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan yang signifikan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi sebesar 34,1%, meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Peningkatan ini berkaitan dengan perubahan gaya hidup seperti konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan stres (Maywati et al., 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam pengendalian hipertensi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya (*World Health Organization, 2021*). Banyak individu tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi karena penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala (*silent killer*) (*World Health Organization, 2021*). Oleh karena itu, pendekatan berbasis masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan deteksi dini dan pencegahan hipertensi (Kustriyani et al., 2023).

Pemberdayaan kader kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku kesehatan (Ginting, 2024). Kader kesehatan memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga berperan sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan (Widodo et al., 2025).

B. Konsep Pemberdayaan Kader Kesehatan

Pemberdayaan kader kesehatan merupakan proses peningkatan kapasitas individu dalam menjalankan fungsi kesehatan di masyarakat (Puspitasari et al.,

2025). Proses ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian dalam pengambilan keputusan kesehatan (Lestari et al., 2021).

Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk membantu pelaksanaan program kesehatan (Ginting, 2024). Dalam pencegahan hipertensi, kader memiliki peran strategis karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan berkelanjutan (Kustriyani et al., 2023).

Pemberdayaan kader meliputi:

1. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan (Puspitasari et al., 2025)
2. Pendampingan dalam pelaksanaan program (Widodo et al., 2025)
3. Penguatan peran sosial sebagai agen perubahan (Maywati et al., 2023)
4. Penyediaan sarana pendukung kesehatan (Ginting, 2024)

Penjelasan :

1. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan

Pelatihan merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya kader kesehatan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (*knowledge, skill, attitude*). Melalui pelatihan yang terstruktur, kader tidak hanya memahami teori, namun juga mampu menerapkannya dalam praktik di lapangan.

Pelatihan seperti *Training of Trainers* (TOT) bertujuan menciptakan kader yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu melatih kader lain, sehingga terjadi efek berantai dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

Penjelasan tambahan:

- a. Pengetahuan: memahami konsep kesehatan dasar, penyakit, dan pencegahannya
- b. Keterampilan: mampu melakukan tindakan seperti pengukuran tekanan darah atau penimbangan balita
- c. Sikap: memiliki empati, komunikasi yang baik, dan kepedulian terhadap Masyarakat (Puspitasari, D., et al, 2025)

Peran Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Kader

Melalui pelatihan, kader belajar berbagai kemampuan penting, seperti:

- a. Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
- b. Melakukan deteksi dini penyakit (misalnya hipertensi atau diabetes)
- c. Memberikan pelayanan kesehatan sederhana

Pendekatan pelatihan umumnya menggabungkan antara :

- a. Teori → memberikan dasar pengetahuan
- b. Praktik langsung → meningkatkan keterampilan nyata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kombinasi ini lebih efektif dibandingkan hanya teori saja karena peserta dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapat. (Jurnal Malahayati, 2023).



Gambar 4.1
penyuluhan oleh kader kepada Masyarakat

Bukti Penelitian tentang Efektivitas Pelatihan

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan kader secara signifikan, terutama jika menggunakan metode:

- a. Demonstrasi langsung
- b. Simulasi kasus
- c. Diskusi kelompok

Kader yang mengikuti pelatihan cenderung:

- a. Lebih percaya diri dalam memberikan edukasi
- b. Lebih aktif dalam kegiatan posyandu
- c. Lebih akurat dalam melakukan deteksi dini. (Jurnal Malahayati, 2023).

Contoh Implementasi Pelatihan Kader

- a. Pelatihan Kader Posyandu

Kader dilatih untuk:

- 1) Mengukur tekanan darah
- 2) Menimbang dan memantau pertumbuhan balita

3) Memberikan edukasi tentang gizi seimbang

Manfaat:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan posyandu
- 2) Mencegah masalah gizi sejak dini (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

b. Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kader diberikan materi tentang:

- 1) Faktor risiko PTM (merokok, pola makan, kurang aktivitas fisik)
- 2) Cara edukasi masyarakat untuk hidup sehat
- 3) Deteksi dini seperti pengukuran gula darah dan tekanan darah

Manfaat:

- 1) Mengurangi angka kejadian penyakit kronis
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat (WHO, 2021). Pelatihan merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan kader kesehatan. Dengan pendekatan teori dan praktik, pelatihan terbukti mampu meningkatkan kapasitas kader secara signifikan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Pendampingan dalam pelaksanaan program

Pendampingan merupakan proses lanjutan setelah pelatihan, di mana kader kesehatan mendapatkan bimbingan langsung saat menerapkan pengetahuan dan keterampilan di lapangan. Pendampingan penting karena tidak semua kader langsung mampu mengaplikasikan materi pelatihan secara mandiri tanpa dukungan.

Penjelasan tambahan:

Pendampingan berfungsi untuk:

- a. Menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik
- b. Meningkatkan kepercayaan diri kader
- c. Memastikan program berjalan sesuai standar

Pendampingan biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau petugas puskesmas yang berperan sebagai fasilitator. (Widodo, A., et al, 2025).

Komponen Pendampingan: Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Pendampingan terdiri dari tiga komponen utama:

a. Supervisi

Supervisi adalah proses pengawasan dan pembinaan langsung saat kader menjalankan kegiatan.

Tujuannya untuk memastikan kader melakukan prosedur dengan benar.

b. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kader.

c. Evaluasi

Evaluasi bertujuan menilai hasil kegiatan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan program ke depan.

Pendekatan ini membantu kader tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan program kesehatan masyarakat. (Jurnal Malahayati, 2023).



Gambar 4.2
diskusi evaluasi antara kader dan petugas Kesehatan

Manfaat Pendampingan bagi Kader

Pendampingan terbukti memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Membantu kader memahami praktik kerja secara langsung
- b. Mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- d. Memperkuat keberlanjutan program

Penelitian menunjukkan bahwa kader yang mendapatkan pendampingan cenderung lebih aktif dan konsisten dalam menjalankan tugasnya dibandingkan yang tidak didampingi. (Jurnal Malahayati, 2023).

Contoh Implementasi Pendampingan

a. Pendampingan saat kegiatan Posyandu

Tenaga kesehatan mendampingi kader dalam:

- 1) Penimbangan balita

- 2) Pencatatan data kesehatan
- 3) Penyuluhan kepada ibu dan anak

Pendampingan ini memastikan kegiatan berjalan sesuai standar pelayanan. (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

b. Monitoring oleh Puskesmas

Puskesmas melakukan kunjungan rutin untuk:

- 1) Mengevaluasi kegiatan kader
- 2) Memberikan solusi atas kendala di lapangan
- 3) Memastikan program berjalan berkelanjutan

Monitoring ini membantu menjaga kualitas layanan kesehatan di tingkat masyarakat. (WHO, 2021).

Pendampingan merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program kesehatan masyarakat. Dengan adanya supervisi, monitoring, dan evaluasi, kader dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, percaya diri, dan sesuai standar yang ditetapkan.

3. Penguatan peran sosial sebagai agen perubahan

Kader berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu memengaruhi perilaku masyarakat menuju hidup sehat. Mereka menjadi penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Penguatan peran ini penting agar kader mampu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran kesehatan di komunitas. (Abdimas Madani, 2023)

Contoh:

- * Kader mengajak masyarakat berhenti merokok
- * Kader mengedukasi pentingnya imunisasi dan pola hidup sehat

4. Penyediaan sarana pendukung kesehatan

Pemberdayaan kader tidak akan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana. Sarana ini membantu kader dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif.

Fasilitas seperti alat ukur kesehatan, media edukasi, dan buku panduan kader merupakan hal penting dalam menunjang kegiatan kader di masyarakat.

- * Alat tensi (*sphygmomanometer*) dan timbangan
- * Buku KIA, leaflet kesehatan, dan alat pencatatan data

Pemberdayaan kader merupakan proses yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi:

- * peningkatan kapasitas (pelatihan),
- * pendampingan implementasi,

- * penguatan peran sosial,
- * serta dukungan sarana.

Jika keempat aspek ini berjalan bersama, kader dapat berfungsi optimal sebagai ujung tombak peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan pemberdayaan yang optimal, kader dapat berperan sebagai mitra tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lestari et al., 2021).

C. Peran Kader dalam Pencegahan Hipertensi

1. Sebagai Edukator

Kader memberikan edukasi mengenai faktor risiko hipertensi seperti pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok (Maywati et al., 2023).

2. Sebagai Skrining (Deteksi Dini)

Kader melakukan pengukuran tekanan darah secara rutin di Posyandu atau Posbindu untuk mendeteksi hipertensi lebih awal (Kustriyani et al., 2023).

3. Sebagai Motivator

Kader mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat seperti olahraga rutin dan diet seimbang (Lestari et al., 2021).

4. Sebagai Penghubung (*Linkage*)

Kader menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut (Widodo et al., 2025).

Penjelasan:

Peran Kader dalam Pencegahan Hipertensi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sering tidak bergejala (*silent killer*), sehingga peran kader kesehatan menjadi sangat penting dalam pencegahan berbasis masyarakat.

1. Sebagai Edukator

Kader berperan sebagai penyampai informasi kesehatan kepada masyarakat terkait faktor risiko dan pencegahan hipertensi. Edukasi yang diberikan biasanya bersifat sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kader menjelaskan bahwa hipertensi dapat dipicu oleh:

- a. konsumsi garam berlebih
- b. kurang aktivitas fisik
- c. kebiasaan merokok
- d. stres dan pola hidup tidak sehat

Edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung, diskusi kelompok, maupun media seperti leaflet dan poster. Peran ini penting karena peningkatan pengetahuan masyarakat terbukti berkontribusi pada perubahan perilaku sehat (Maywati et al., 2023).

Contoh:

- a. Kader memberikan penyuluhan di posyandu tentang bahaya konsumsi makanan asin berlebihan
- b. Kader mengedukasi ibu rumah tangga untuk mengurangi penggunaan garam saat memasak
- c. Kader menjelaskan tanda dan risiko hipertensi saat pertemuan PKK

2. Sebagai Skrining (Deteksi Dini)

Kader juga berperan dalam melakukan deteksi dini hipertensi melalui pengukuran tekanan darah secara rutin di kegiatan masyarakat seperti posyandu atau posbindu.

Kegiatan skrining ini bertujuan untuk:

- a. menemukan kasus hipertensi sejak dini
- b. mencegah komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya

Menurut penelitian, keterlibatan kader dalam skrining meningkatkan cakupan pemeriksaan tekanan darah di masyarakat (Kustriyani et al., 2023).

Contoh:

- a. Kader mengukur tekanan darah warga setiap bulan di Posbindu PTM
- b. Kader mencatat hasil pemeriksaan dalam buku register kesehatan

Kader menyarankan warga dengan tekanan darah tinggi untuk pemeriksaan lanjutan.

3. Sebagai Motivator

Kader berfungsi sebagai **pendorong perubahan perilaku** agar masyarakat mau menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten.

Motivasi yang diberikan meliputi:

- a. ajakan untuk rutin berolahraga
- b. mendorong konsumsi makanan sehat (rendah garam dan lemak)
- c. mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol

Peran motivator penting karena perubahan perilaku tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tetapi membutuhkan dorongan sosial dan emosional (*Lestari et al., 2021*).

Contoh:

- a. Kader mengajak warga mengikuti senam pagi bersama
 - b. Kader membuat kelompok jalan sehat di lingkungan RT
 - c. Kader memberikan dukungan kepada warga yang sedang mengurangi rokok
4. Sebagai Penghubung (Linkage)

Kader bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas atau rumah sakit.

Peran ini meliputi:

- a. merujuk warga dengan tekanan darah tinggi ke fasilitas kesehatan
- b. membantu proses administrasi atau informasi layanan kesehatan
- c. menyampaikan program kesehatan dari tenaga medis ke masyarakat

Fungsi linkage ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan (*Widodo et al., 2025*).

Contoh:

- a. Kader mengarahkan pasien hipertensi untuk kontrol ke puskesmas
- b. Kader membantu warga memahami jadwal pemeriksaan kesehatan
- c. Kader mendampingi lansia saat berobat

Peran kader dalam pencegahan hipertensi bersifat multifungsi dan saling terintegrasi, yaitu:

- a. sebagai edukator untuk meningkatkan pengetahuan,
- b. sebagai skrining untuk deteksi dini,
- c. sebagai motivator untuk perubahan perilaku,
- d. serta sebagai penghubung untuk akses layanan kesehatan.

Jika semua peran ini berjalan optimal, kader dapat menjadi ujung tombak dalam menurunkan angka kejadian hipertensi di masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Peran tersebut menjadikan kader sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas (Ginting, 2024).

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Hipertensi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu dalam kegiatan kesehatan (Kustriyani et al., 2023). Tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program pencegahan hipertensi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Bentuk partisipasi meliputi:

1. Mengikuti kegiatan Posbindu PTM (Kementerian Kesehatan RI, 2018)
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (*World Health Organization*, 2021)
3. Menerapkan perilaku hidup sehat (Maywati et al., 2023)
4. Memberikan dukungan dalam lingkungan keluarga (Lestari et al., 2021)

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan, pendidikan, serta akses terhadap informasi dan layanan kesehatan (Lestari et al., 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2018).

E. Strategi Pemberdayaan Kader dan Masyarakat

1. Pelatihan dan Edukasi Kader

Pelatihan kader merupakan langkah awal dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kompetensi (Ginting, 2024). Materi pelatihan mencakup pengukuran tekanan darah, komunikasi kesehatan, serta konseling perubahan perilaku (Kustriyani et al., 2023; Widodo et al., 2025).

2. Skrining dan Deteksi Dini

Kegiatan skrining dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi individu berisiko hipertensi (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

3. Intervensi Perubahan Perilaku

Intervensi difokuskan pada perubahan gaya hidup seperti diet rendah garam, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan pengelolaan stres (*World Health Organization*, 2021).

Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif karena adanya dukungan sosial yang kuat (Kustriyani et al., 2023).

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pencatatan, pemantauan, dan edukasi kesehatan oleh kader (Widodo et al., 2025).

F. Dampak Pemberdayaan Kader

Pemberdayaan kader kesehatan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam aspek pengetahuan, pencegahan, dan deteksi dini penyakit. Kader berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga informasi kesehatan dapat tersampaikan secara lebih efektif.

Penjelasan:

Pemberdayaan kader mencakup pelatihan, pendampingan, serta keterlibatan aktif dalam program kesehatan. Proses ini menjadikan kader sebagai agen perubahan (*agent of change*) di lingkungan masyarakat. (Puspitasari, D., et al., 2025); Ginting, R, 2024).

1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Kader yang telah diberdayakan mampu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara rutin, baik melalui penyuluhan, kunjungan rumah, maupun kegiatan posyandu.

Penjelasan:

- a. Informasi kesehatan menjadi lebih mudah dipahami karena disampaikan oleh orang yang dekat dengan masyarakat
- b. Terjadi peningkatan kesadaran tentang pola hidup sehat
- c. Masyarakat lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga

Dengan demikian, pemberdayaan kader berkontribusi dalam meningkatkan literasi kesehatan Masyarakat. (Puspitasari et al, 2025).

2. Peningkatan Deteksi Dini Penyakit

Kader memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan gizi.

Penjelasan:

- a. Kader dapat melakukan pemeriksaan sederhana (misalnya tekanan darah)
- b. Masyarakat dapat teridentifikasi lebih awal sebelum penyakit menjadi berat
- c. Mempercepat rujukan ke fasilitas kesehatan

Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan. (Ginting, R, 2024).

3. Penurunan Faktor Risiko Hipertensi

Pemberdayaan kader juga berdampak pada penurunan faktor risiko hipertensi di masyarakat.

Penjelasan:

- a. Kader mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat (rendah garam, tinggi serat)
- b. Mendorong aktivitas fisik secara rutin
- c. Mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala

Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat lebih mampu mengendalikan faktor risiko seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan stres.

(Puspitasari et al., 2025); Ginting, R., 2024).



Gambar 4.3
pemeriksaan kesehatan sederhana (tekanan darah) oleh kader

Pemberdayaan kader kesehatan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dampak tersebut terlihat pada meningkatnya pengetahuan masyarakat, kemampuan deteksi dini penyakit, serta penurunan faktor risiko hipertensi melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan.

G. Tantangan dan Solusi Pemberdayaan Kader

Dalam implementasi program kesehatan berbasis masyarakat, tidak semua proses berjalan optimal. Terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja kader, terutama terkait keterbatasan pelatihan dan fasilitas pendukung.

Penjelasan :

Tantangan ini umumnya muncul karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga, sarana, maupun sistem pendukung. Jika tidak ditangani dengan baik, hal

ini dapat menurunkan efektivitas program kesehatan di masyarakat. (Widodo, A., et al, 2025). Tantangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Pelatihan

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses kader terhadap pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penjelasan:

- a. Tidak semua kader mendapatkan pelatihan secara rutin
- b. Materi pelatihan terkadang tidak diperbarui sesuai perkembangan ilmu kesehatan
- c. Kurangnya metode praktik langsung membuat kader kurang percaya diri

Akibatnya, kemampuan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi tidak merata. (Jurnal Malahayati, 2023).

2. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Penjelasan:

- a. Keterbatasan alat kesehatan (misalnya tensimeter, timbangan)
- b. Kurangnya media edukasi seperti poster atau leaflet
- c. Minimnya dukungan tempat atau sarana kegiatan

Hal ini dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh kader kepada masyarakat. (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Solusi: Pelatihan Berkelanjutan

Untuk mengatasi keterbatasan pelatihan, diperlukan program pelatihan berkelanjutan (*continuous training*).

Penjelasan:

- a. Pelatihan dilakukan secara berkala
- b. Materi diperbarui sesuai perkembangan ilmu
- c. Menggunakan metode interaktif (praktik, simulasi, diskusi)

Pelatihan berkelanjutan membantu kader meningkatkan kompetensi secara konsisten.

Solusi: Dukungan Sistem Kesehatan

Selain pelatihan, dukungan dari sistem kesehatan sangat penting.

Penjelasan:

- a. Penyediaan fasilitas dan alat kesehatan yang memadai
- b. Pendampingan oleh tenaga kesehatan (puskesmas)
- c. Monitoring dan evaluasi program secara rutin

Dukungan ini memastikan kader dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berkelanjutan. (WHO, 2021)

Tantangan dalam pemberdayaan kader, seperti keterbatasan pelatihan dan fasilitas, merupakan hal yang umum terjadi. Namun, melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan sistem kesehatan yang kuat, hambatan tersebut dapat diatasi sehingga program kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

H. Simpulan

Pemberdayaan kader dan partisipasi masyarakat merupakan strategi efektif dalam pencegahan hipertensi melalui peningkatan kesadaran, deteksi dini, dan perubahan perilaku Kesehatan.

I. Referensi

- Abdimas Madani. (2023). *Pemberdayaan kader dalam pembentukan agent of change* agen pemberdayaan kesehatan masyarakat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian*
- Ahyanti, A., et al. (2023). Masyarakat sehat melalui penguatan peran kader sebagai *and evaluation framework. berbasis komunitas. control guidelines.*
- Ginting, A. (2024). Pelatihan dan pendampingan kader posbindu dalam pengendalian
- Ginting, R. (2024). *Peran kader dalam deteksi dini penyakit tidak menular. hipertensi. Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 67–72.
- Journal of Community Empowerment*, 3(2), 48–56.
- Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).*
- Jurnal Malahayati. (2023a). Efektivitas pelatihan kader dalam meningkatkan
- Jurnal Malahayati. (2023b). Peningkatan pengetahuan kader melalui metode pelatihan
- Jurnal Malahayati. (2023c). Efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kinerja
- Jurnal Malahayati. (2023d). Evaluasi pelatihan kader dalam program kesehatan kader kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Riskesdas 2018.*

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). *Pedoman pelaksanaan posyandu*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). *Standar sarana dan prasarana kepada Masyarakat (PKM) kesehatan berbasis masyarakat*.
- Kustriyani, M., et al. (2023). Optimalisasi peran kader dalam deteksi hipertensi. *Jurnal Lestari*, R., et al. (2021). Peningkatan kemampuan kader dalam pengendalian hipertensi. *Masyarakat Mandiri*. masyarakat.
- Maywati, S., et al. (2023). Edukasi kader dalam pencegahan hipertensi. *Jurnal of Community Empowerment*, 7(2), 303–313. *pelayanan kesehatan masyarakat*. *Pengabdian Masyarakat*, 3(1). *PengabdianMu*, 10(6), 1490–1499. pengetahuan dan keterampilan kesehatan masyarakat. *penyakit tidak menular di Puskesmas Jambe tahun 2023*.
- Puspitasari, D., et al. (2025a). *Pemberdayaan kader kesehatan melalui pelatihan*
- Puspitasari, D., et al. (2025b). *Peningkatan literasi kesehatan melalui peran kader*.
- Puspitasari, N., et al. (2025). Capacity building kader dalam deteksi dini hipertensi.
- Sari, R. N., & Nugroho, F. A. (2024). Pengetahuan kader tentang hipertensi. *Proceeding*
- Syaiful, S., et al. (2023). *Pelatihan training of trainer kader penyuluh kesehatan dalam teori dan praktik*. *upaya peningkatan pengetahuan kader kesehatan di Kelurahan Kolo Kota Bima*. *URECOL*, 18, 93–99.
- Widodo, A., et al. (2025a). *Pendampingan kader dalam implementasi program*
- Widodo, A., et al. (2025b). *Tantangan dan strategi pemberdayaan kader kesehatan*.
- Widodo, G. G., et al. (2025). Pendampingan kader berbasis digital. *Indonesian Journal workers*.
- World Health Organization. (2021a). *Community health worker programs: Monitoring*
- World Health Organization. (2021b). *Health system support for community health*

World Health Organization. (2021c). *Hypertension*.

World Health Organization. (2021d). *Noncommunicable diseases prevention and*

J. Glosarium

Posbindu = Pos Pembinaan Terpadu

PTM = Penyakit Tidak Menular

TOT = Training of Trainers

CHAPTER 6

KOLABORASI PERAWAT KOMUNITAS PUSKESMAS DAN KELUARGA DALAM TINDAK LANJUT KASUS

Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena pada banyak kasus tidak menunjukkan gejala yang jelas, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan kematian apabila tidak dikendalikan dengan baik. Menurut *World Health Organization* (WHO), hipertensi menjadi salah satu faktor risiko utama penyebab kematian prematur secara global (WHO, 2023).

Di Indonesia, prevalensi hipertensi masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah mencapai 30,8% (Kemenkes, 2023). Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 34,1%, hipertensi tetap menjadi masalah kesehatan utama karena masih tingginya jumlah masyarakat yang belum terdiagnosis maupun belum menjalani pengobatan secara teratur.

Tingginya angka hipertensi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko komplikasi penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pengendalian hipertensi tidak cukup hanya dilakukan melalui deteksi dini, tetapi memerlukan tindak lanjut yang berkesinambungan melalui monitoring tekanan darah, kepatuhan terapi, modifikasi gaya hidup, dan dukungan keluarga. Pendekatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas menjadi sangat penting dalam mengendalikan hipertensi secara berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia dalam pengendalian penyakit tidak menular adalah melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Posbindu PTM merupakan bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berfokus pada deteksi dini, pemantauan faktor risiko, edukasi kesehatan, serta tindak lanjut kasus penyakit tidak menular termasuk hipertensi (Kemenkes, 2021). Dalam pelaksanaannya, pengendalian hipertensi melalui Posbindu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan

kolaborasi antara perawat komunitas, puskesmas, kader kesehatan, dan keluarga untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien, memperkuat edukasi kesehatan, memfasilitasi tindak lanjut kasus, serta mendorong perubahan perilaku sehat di masyarakat.

B. Konsep Tindak Lanjut Kasus Hipertensi

Tindak lanjut kasus hipertensi merupakan rangkaian pelayanan kesehatan berkelanjutan yang bertujuan menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi. Pengelolaan hipertensi membutuhkan pendekatan jangka panjang karena hipertensi merupakan penyakit kronis yang memerlukan pemantauan, pengobatan, dan perubahan perilaku secara terus-menerus (WHO, 2021). Dalam pelayanan kesehatan komunitas, tindak lanjut hipertensi tidak hanya dilakukan melalui kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan perawat komunitas, kader kesehatan, keluarga, dan pelayanan kesehatan primer. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pengobatan, memperkuat *self-management*, dan memastikan pasien tetap mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan (Bhattarai et al., 2024).

1. Monitoring Berkelanjutan

Monitoring berkelanjutan merupakan bagian penting dalam pengendalian hipertensi karena membantu tenaga kesehatan mengevaluasi efektivitas terapi, mendeteksi komplikasi lebih dini, serta memantau kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Dalam konteks komunitas, monitoring hipertensi tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui kunjungan rumah (*home visit*), pemantauan tekanan darah di Posbindu, komunikasi berkala dengan pasien, dan tindak lanjut oleh kader kesehatan atau *community health workers* (CHWs). (Bhattarai et al., 2024) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas melalui kunjungan rumah oleh CHWs mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, meningkatkan aktivitas fisik, serta meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi. Selain itu, CHWs juga berperan dalam memberikan edukasi gaya hidup sehat, mengingatkan jadwal kontrol, dan memotivasi pasien untuk tetap menjalani terapi hipertensi secara teratur (Ingenhoff et al., 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa monitoring berbasis komunitas dapat membantu memperkuat keterlibatan pasien dalam pengelolaan penyakitnya.

Perkembangan teknologi juga mendukung proses monitoring hipertensi secara berkelanjutan. (Zheng et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan tekanan darah

secara *real-time* dan membantu meningkatkan kontrol tekanan darah pasien hipertensi di komunitas. Selain itu, Li et al. (2019) menunjukkan bahwa intervensi berbasis aplikasi digital seperti WeChat mampu meningkatkan self-management pasien hipertensi dan menurunkan tekanan darah secara signifikan. Dalam konteks pelayanan komunitas di Indonesia, pendekatan ini dapat diadaptasi melalui pemanfaatan media komunikasi sederhana seperti telepon atau WhatsApp untuk mendukung tindak lanjut pasien hipertensi.

2. Kontrol Rutin

Kontrol rutin merupakan bagian penting dalam tindak lanjut hipertensi karena memungkinkan tenaga kesehatan memantau tekanan darah, mengevaluasi kepatuhan pengobatan, mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan pasien, serta menyesuaikan terapi bila diperlukan. Kontrol rutin juga memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi berulang mengenai pola hidup sehat dan pentingnya kepatuhan terapi hipertensi (WHO, 2021).

Dalam pelayanan kesehatan komunitas, kontrol rutin tidak hanya dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui Posbindu PTM dan monitoring berbasis komunitas. Melalui Posbindu, pasien hipertensi dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah berkala, memperoleh edukasi kesehatan, serta mendapatkan tindak lanjut awal sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan tekanan darah yang tidak terkontrol (Kemenkes, 2021). Pendekatan komunikasi yang personal dalam tindak lanjut hipertensi juga berpengaruh terhadap keberhasilan kontrol rutin pasien. B. Li (2025) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan hipertensi dan membantu pasien merasa lebih didukung selama menjalani pengobatan jangka panjang.

3. Kepatuhan Terapi

Kepatuhan terapi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengendalian hipertensi. Pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan kematian akibat penyakit kardiovaskular (Burnier & Egan, 2019). Oleh karena itu, tindak lanjut pasien hipertensi perlu dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk memastikan pasien tetap menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Beberapa faktor diketahui memengaruhi kepatuhan pasien terhadap terapi hipertensi, antara lain tingkat pendidikan, dukungan keluarga, komunikasi dengan tenaga kesehatan, kondisi ekonomi, akses pelayanan kesehatan, dan

tingkat literasi kesehatan (Marcelline et al., 2026). Selain faktor individu, dukungan sosial dan lingkungan juga berpengaruh terhadap kemampuan pasien mempertahankan pengobatan jangka panjang.

Pendekatan berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kepatuhan terapi pasien hipertensi. Ingenhoff et al. (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan CHWs dalam tindak lanjut hipertensi membantu meningkatkan kepatuhan pasien melalui edukasi kesehatan, pengingat jadwal kontrol, dan monitoring rutin di masyarakat. Selain itu, hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan juga berkontribusi terhadap keberhasilan terapi hipertensi karena pasien merasa lebih didukung dan termotivasi menjalani pengobatan (B. Li, 2025).

Keluarga juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terapi pasien hipertensi. Dukungan keluarga dapat berupa mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi pasien saat kontrol kesehatan, membantu menyediakan makanan sehat, dan memberikan dukungan emosional selama proses pengobatan (Friedman et al., 2003).

4. Modifikasi Gaya Hidup

Selain terapi farmakologis, modifikasi gaya hidup merupakan komponen utama dalam pengendalian hipertensi. WHO merekomendasikan perubahan gaya hidup sehat seperti pengurangan konsumsi garam, peningkatan aktivitas fisik, penghentian merokok, pengendalian berat badan, pembatasan konsumsi alkohol, dan manajemen stres sebagai bagian penting dalam pengendalian tekanan darah (WHO, 2021).

Keberhasilan modifikasi gaya hidup sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pasien dalam *self-management*. Li et al. (2019) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan edukasi digital mampu meningkatkan kemampuan self-management pasien hipertensi, termasuk kepatuhan diet, aktivitas fisik, dan monitoring tekanan darah mandiri.

Dalam pelayanan kesehatan komunitas, perubahan gaya hidup sehat perlu didukung melalui edukasi berkelanjutan dan pendampingan oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan keluarga. Bhattarai et al. (2024) menunjukkan bahwa program tindak lanjut hipertensi berbasis komunitas mampu meningkatkan aktivitas fisik dan perilaku hidup sehat pasien hipertensi melalui pendekatan edukasi dan monitoring rutin di masyarakat.

Dukungan keluarga juga berperan penting dalam membantu pasien mempertahankan perubahan gaya hidup sehat. Keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan pengendalian stres sehingga pasien lebih mudah mempertahankan perilaku hidup sehat dalam jangka panjang (Friedman et al., 2003).

C. Peran Perawat Komunitas dalam Tindak Lanjut Kasus Hipertensi

Perawat komunitas memiliki peran strategis dalam pengendalian hipertensi berbasis masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan komunitas, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai edukator, koordinator pelayanan, advokat kesehatan, dan fasilitator perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan keperawatan komunitas menekankan pelayanan promotif dan preventif yang dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan masyarakat (Stanhope & Lancaster, 2020).

1. Perawat sebagai Edukator

Sebagai edukator, perawat komunitas bertanggung jawab memberikan informasi dan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga terkait pengendalian hipertensi. Edukasi meliputi penerapan diet rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, manajemen stres, penghentian merokok, serta kepatuhan dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Edukasi kesehatan yang dilakukan secara konsisten oleh perawat dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai hipertensi dan mendorong perubahan perilaku kesehatan. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terapi dan kualitas hidup pasien hipertensi (Dennison & Hill, 2005).

2. Perawat sebagai Care Coordinator

Perawat komunitas juga berperan sebagai care coordinator yang menghubungkan pasien dengan berbagai sumber pelayanan kesehatan, termasuk kader kesehatan, Posbindu, dan puskesmas. Peran koordinasi ini penting untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Alvarez et al. (2022) menjelaskan bahwa kolaborasi antara perawat dan tenaga kesehatan komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hipertensi. Melalui koordinasi yang baik, pasien dapat memperoleh pemantauan kesehatan, tindak lanjut pengobatan, serta dukungan sosial secara optimal.

3. Home Visit dan Monitoring Pasien

Kunjungan rumah (home visit) merupakan salah satu bentuk pelayanan keperawatan komunitas yang bertujuan untuk memantau kondisi pasien secara langsung di lingkungan tempat tinggalnya. Melalui home visit, perawat dapat melakukan pemantauan tekanan darah, mengidentifikasi hambatan pengobatan, serta memberikan pendampingan kepada pasien dan keluarga. Pendekatan home-based care terbukti efektif dalam meningkatkan pengendalian tekanan darah dan kepatuhan pasien terhadap terapi hipertensi (Tu et al., 2018). Selain itu,

home visit juga membantu tenaga kesehatan memahami kondisi sosial dan lingkungan yang memengaruhi perilaku kesehatan pasien.

4. Dokumentasi dan Evaluasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam proses tindak lanjut kasus hipertensi. Pencatatan hasil monitoring tekanan darah, kepatuhan pengobatan, dan perubahan perilaku pasien diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi berkala memungkinkan tenaga kesehatan melakukan penyesuaian intervensi sesuai kebutuhan pasien.

D. Peran Puskesmas dalam Pengendalian Hipertensi Berbasis Komunitas

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam pengendalian hipertensi di masyarakat. Sebagai pusat pelayanan kesehatan primer, puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkesinambungan (Kemenkes, 2024).

1. Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Primer

Dalam pengendalian hipertensi, puskesmas berperan dalam melakukan deteksi dini, pemeriksaan rutin, pengobatan, konseling kesehatan, serta pemantauan pasien hipertensi. Pelayanan hipertensi di puskesmas juga mencakup edukasi kesehatan masyarakat dan penguatan peran keluarga dalam pengendalian penyakit.

2. Pembinaan Posbindu dan Kader

Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam membina Posbindu dan kader kesehatan masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan kader, supervisi kegiatan Posbindu, penyediaan alat kesehatan, serta pendampingan pelaksanaan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. Puskesmas berfungsi sebagai pembina teknis dalam pelaksanaan Posbindu PTM agar kegiatan skrining dan tindak lanjut dapat berjalan secara optimal (Kemenkes, 2021).

3. Pelayanan Kuratif dan Preventif

Pelayanan hipertensi di puskesmas tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah rutin, pengobatan antihipertensi, konseling gizi, edukasi aktivitas fisik, dan pengendalian faktor risiko lainnya. WHO menekankan bahwa pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting dalam pengendalian hipertensi melalui pendekatan berbasis komunitas dan pelayanan terintegrasi (WHO, 2021).

4. Sistem Rujukan dan Kolaborasi Lintas Program

Puskesmas juga berperan dalam sistem rujukan apabila ditemukan pasien dengan hipertensi tidak terkontrol atau komplikasi yang memerlukan pelayanan lanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas program diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hipertensi di masyarakat.

E. Peran Keluarga dalam Tindak Lanjut Kasus Hipertensi

Keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi pasien hipertensi dalam menjalani pengobatan dan mempertahankan perubahan gaya hidup sehat. Dalam pendekatan keperawatan keluarga, keluarga dipandang sebagai unit pelayanan yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan anggota keluarganya. Keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan self-care, mempertahankan kepatuhan terapi, serta mendukung keberhasilan pengendalian penyakit kronis, termasuk hipertensi (Proboningsih et al., 2025). Pendekatan family-centered care menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses pelayanan kesehatan melalui keterlibatan aktif keluarga dalam pengambilan keputusan, perawatan sehari-hari, dan dukungan emosional pasien. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal (Kamaryati & Malathum, 2020).

1. Dukungan Emosional dan Motivasi

Dukungan emosional dari keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien hipertensi menghadapi stres psikologis akibat penyakit kronis yang dialaminya. Dukungan berupa perhatian, empati, motivasi, dan pendampingan dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pasien selama menjalani pengobatan. Pasien hipertensi yang memperoleh dukungan emosional dari keluarga cenderung memiliki motivasi lebih tinggi dalam mengontrol tekanan darah dan menjalankan terapi yang dianjurkan (Ayaturahmi et al., 2022).

Selain itu, dukungan emosional yang baik juga dapat membantu menurunkan tingkat stres pasien. Kondisi stres yang tidak terkontrol diketahui dapat memengaruhi peningkatan tekanan darah melalui aktivasi sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon stres. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan psikologis menjadi bagian penting dalam pengendalian hipertensi jangka panjang (PERHI, 2021).

2. Dukungan Kepatuhan Pengobatan

Kepatuhan pengobatan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengendalian hipertensi. Pasien yang tidak patuh mengonsumsi obat antihipertensi memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti

stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Dalam hal ini, keluarga berperan penting dalam membantu pasien mempertahankan kepatuhan terapi melalui pengawasan dan pendampingan sehari-hari (Burnier & Egan, 2019).

Bentuk dukungan keluarga dapat berupa mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi pasien saat kontrol kesehatan, membantu menyediakan obat, serta memberikan motivasi agar pasien tetap menjalani terapi secara teratur. Penelitian Ayaturahmi et al. (2022) menunjukkan bahwa dukungan keluarga berhubungan dengan peningkatan motivasi pasien dalam mengontrol tekanan darah dan menjalani pengobatan hipertensi.

Keterlibatan keluarga juga membantu pasien memahami pentingnya terapi jangka panjang pada hipertensi. Banyak pasien menghentikan pengobatan ketika gejala berkurang atau tekanan darah mulai membaik. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga perlu dilakukan agar keluarga dapat menjadi sistem pendukung yang aktif dalam menjaga kepatuhan pengobatan pasien hipertensi (WHO, 2021).

3. Pendampingan Perubahan Gaya Hidup

Keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku sehat. Dukungan keluarga dapat diwujudkan melalui penyediaan makanan sehat rendah garam, mengajak pasien melakukan aktivitas fisik bersama, mengingatkan pola hidup sehat, serta membantu mengurangi faktor-faktor pemicu stres dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang suportif terbukti membantu pasien mempertahankan perilaku hidup sehat secara konsisten (Antari et al., 2024).

Pendampingan keluarga juga penting karena perubahan gaya hidup pada pasien hipertensi sering kali membutuhkan proses adaptasi yang tidak mudah. Dukungan yang diberikan secara terus-menerus dapat meningkatkan motivasi pasien untuk mempertahankan perilaku sehat dalam jangka panjang (Pramadaningati et al., 2021).

4. *Family Centered Care* dalam Pengendalian Hipertensi

Pendekatan *family-centered care* menekankan bahwa keluarga bukan hanya pendamping pasien, tetapi merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan melibatkan keluarga dalam proses edukasi, pengambilan keputusan, monitoring kesehatan, dan evaluasi pengobatan pasien hipertensi (Friedman et al., 2003).

Penerapan *family-centered care* pada pengendalian hipertensi dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan karena keluarga berperan sebagai sumber dukungan emosional, sosial, dan praktis bagi pasien. Keterlibatan keluarga juga membantu meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan

self-management dan mempertahankan kepatuhan terhadap terapi maupun perubahan gaya hidup sehat (Kamaryati & Malathum, 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan komunitas, pendekatan family-centered care mendukung terciptanya pelayanan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pengendalian hipertensi serta mencegah terjadinya komplikasi penyakit tidak menular di masyarakat (Stanhope & Lancaster, 2020).

F. Model Kolaborasi Perawat Komunitas, Puskesmas, dan Keluarga

Kolaborasi antara perawat komunitas, puskesmas, keluarga, dan kader kesehatan merupakan komponen penting dalam tindak lanjut kasus hipertensi berbasis komunitas. Pendekatan kolaboratif memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien (patient-centered care) sehingga pengendalian hipertensi tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis, tetapi juga pada perubahan perilaku, monitoring jangka panjang, dan penguatan dukungan sosial pasien (WHO, 2010).

Pengelolaan hipertensi berbasis komunitas memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena hipertensi merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi oleh faktor biologis, perilaku, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, tindak lanjut kasus hipertensi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kuratif di fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan terapi jangka panjang dan pencegahan komplikasi penyakit kardiovaskular (Ibe et al., 2021).

Model kolaborasi dalam pengendalian hipertensi berbasis komunitas menekankan keterhubungan antara pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks Posbindu PTM, kolaborasi dilakukan melalui pembagian peran yang jelas antara kader kesehatan, perawat komunitas, puskesmas, pasien, dan keluarga. Setiap pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk mendukung keberhasilan tindak lanjut kasus hipertensi di masyarakat (Kemenkes, 2021).

1. Konsep Kolaborasi dalam Pelayanan Komunitas

Dalam pelayanan kesehatan komunitas, kolaborasi tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan profesional, tetapi juga kader kesehatan dan keluarga sebagai bagian dari sistem pelayanan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based care* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengelolaan kesehatan (Stanhope & Lancaster, 2020). Pada pengendalian hipertensi, perawat komunitas berperan sebagai koordinator pelayanan (*care*

coordinator) yang menghubungkan pasien dengan pelayanan kesehatan primer, kader kesehatan, dan keluarga. Alvarez et al. (2022) menjelaskan bahwa model kolaborasi antara perawat dan *community health workers* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan hipertensi melalui edukasi kesehatan, monitoring pasien, dan tindak lanjut pengobatan secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi multidisiplin juga terbukti mampu meningkatkan kontrol tekanan darah dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Han et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan *multidisciplinary comprehensive management team* pada pasien hipertensi dapat meningkatkan keberhasilan pengendalian tekanan darah melalui koordinasi pelayanan yang lebih baik antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga.

2. Alur Kolaborasi Tindak Lanjut Kasus Hipertensi melalui Posbindu

Kolaborasi tindak lanjut kasus hipertensi melalui Posbindu PTM dimulai dari proses skrining dan deteksi dini faktor risiko hipertensi di masyarakat. Posbindu PTM merupakan bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berperan dalam melakukan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular secara rutin, termasuk pemeriksaan tekanan darah, pengukuran indeks massa tubuh, edukasi kesehatan, dan konseling kesehatan (Kemenkes, 2021).

Pada tahap awal, kader kesehatan bersama perawat komunitas melakukan skrining tekanan darah dan identifikasi faktor risiko hipertensi pada masyarakat yang datang ke Posbindu. Selain melakukan pemeriksaan tekanan darah, kader dan perawat komunitas juga melakukan wawancara terkait pola makan, aktivitas fisik, riwayat merokok, kepatuhan pengobatan, dan riwayat keluarga hipertensi sebagai bagian dari asesmen faktor risiko penyakit kardiovaskular (Yandrizal et al., 2018). Apabila ditemukan hasil tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg atau terdapat faktor risiko hipertensi yang signifikan, pasien dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan dan penegakan diagnosis. Pada tahap ini, puskesmas melakukan asesmen klinis, pemeriksaan fisik, evaluasi faktor risiko, pemeriksaan laboratorium bila diperlukan, serta pemberian terapi farmakologis dan nonfarmakologis sesuai pedoman nasional maupun internasional pengelolaan hipertensi (PERHI, 2021; WHO, 2021).

Setelah terapi diberikan, perawat komunitas memiliki peran penting dalam melakukan tindak lanjut pasien di masyarakat. Tindak lanjut dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*), monitoring tekanan darah, edukasi kesehatan, pemantauan kepatuhan pengobatan, dan pendampingan perubahan gaya hidup sehat. Zhu et al. (2014) menjelaskan bahwa model *nurse-led hypertension management* mampu meningkatkan kontrol tekanan darah dan kepatuhan pasien melalui monitoring rutin dan edukasi kesehatan yang berkelanjutan.

Selain kunjungan rumah, tindak lanjut kasus hipertensi juga dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon, pesan singkat, atau grup WhatsApp sebagai bentuk remote patient monitoring. Kirkland et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan remote patient monitoring efektif meningkatkan kepatuhan terapi dan kontrol tekanan darah, terutama pada populasi dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan komunitas di Indonesia, pendekatan ini dapat diadaptasi melalui pemanfaatan teknologi sederhana berbasis telekomunikasi untuk memperkuat tindak lanjut pasien hipertensi di masyarakat.

Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tindak lanjut kasus hipertensi. Dukungan keluarga dapat berupa mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi kontrol kesehatan, membantu menyediakan makanan rendah garam, memotivasi pasien melakukan aktivitas fisik, dan memberikan dukungan emosional selama proses pengobatan (Friedman et al., 2003). (Gleason-Comstock et al., 2022) menjelaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam program kesehatan komunitas mampu meningkatkan kesadaran risiko penyakit kardiovaskular dan mendukung keberhasilan perubahan perilaku kesehatan pasien.

Kolaborasi antara puskesmas, perawat komunitas, kader kesehatan, dan keluarga memungkinkan proses pengendalian hipertensi dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. (Gleason-Comstock et al., 2022) menunjukkan bahwa kemitraan antara fasilitas kesehatan dan komunitas mampu meningkatkan kontrol tekanan darah serta memperkuat integrasi sumber daya kesehatan di masyarakat.

Secara umum, alur kolaborasi tindak lanjut kasus hipertensi melalui Posbindu dapat meliputi:

- a. Skrining tekanan darah dan faktor risiko hipertensi di Posbindu PTM
- b. Identifikasi pasien berisiko hipertensi oleh kader dan perawat komunitas
- c. Edukasi kesehatan dan konseling awal di Posbindu
- d. Rujukan pasien ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan
- e. Diagnosis dan pemberian terapi hipertensi di puskesmas
- f. Monitoring kepatuhan terapi dan perubahan gaya hidup oleh perawat komunitas dan keluarga
- g. Home visit dan pemantauan tekanan darah berkala
- h. Komunikasi tindak lanjut melalui telemonitoring atau media digital
- i. Evaluasi berkala tekanan darah dan faktor risiko hipertensi
- j. Rujukan lanjutan apabila ditemukan komplikasi atau hipertensi tidak terkontrol

Model pelayanan tersebut menunjukkan adanya integrasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas yang mendukung keberhasilan pengendalian hipertensi jangka panjang.

Meskipun demikian, implementasi model kolaborasi dalam tindak lanjut hipertensi masih menghadapi berbagai tantangan. Adler et al. (2020) menjelaskan bahwa hambatan dalam implementasi program hipertensi berbasis komunitas meliputi keterbatasan pelatihan kader kesehatan, kurangnya komunikasi antarprofesi, keterbatasan sumber daya, dan sistem dokumentasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, pengembangan sistem komunikasi yang lebih baik, serta dukungan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi pelayanan hipertensi berbasis komunitas.

3. Continuity of Care dalam Hipertensi

Konsep *continuity of care* menjadi dasar penting dalam tindak lanjut hipertensi berbasis komunitas karena hipertensi merupakan penyakit kronis yang memerlukan pemantauan jangka panjang dan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan yang terfragmentasi dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan terapi, keterlambatan deteksi komplikasi, dan kegagalan pengendalian tekanan darah (Haggerty et al., 2003). *Continuity of care* terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *relational continuity*, *informational continuity*, dan *management continuity*. *Relational continuity* mengacu pada hubungan berkelanjutan antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam pengelolaan hipertensi, hubungan yang baik antara pasien dengan perawat komunitas maupun tenaga kesehatan puskesmas dapat meningkatkan kepercayaan pasien, komunikasi terapeutik, dan kepatuhan terhadap terapi hipertensi (Haggerty et al., 2003).

Informational continuity berkaitan dengan kesinambungan informasi kesehatan pasien dalam proses pelayanan. Dokumentasi hasil pemeriksaan tekanan darah, kepatuhan pengobatan, hasil kunjungan rumah, serta riwayat kesehatan pasien perlu dicatat dan dikomunikasikan dengan baik antara Posbindu, perawat komunitas, dan puskesmas agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Lalonde et al. (2012) menjelaskan bahwa sistem komunikasi dan dokumentasi yang baik antar tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan penyakit kronis di pelayanan primer. Sementara itu, *management continuity* menekankan konsistensi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien.

Dalam pengendalian hipertensi, kesinambungan pelayanan memungkinkan pasien memperoleh edukasi kesehatan, monitoring tekanan darah, konseling

gaya hidup, evaluasi terapi, dan tindak lanjut pengobatan secara berkala sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. WHO menekankan bahwa pelayanan hipertensi berbasis pelayanan primer dan komunitas perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan pasien memperoleh pengobatan dan dukungan kesehatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan kualitas hidup pasien hipertensi melalui penguatan self-management dan pencegahan komplikasi jangka panjang (WHO, 2021).

Tu et al. (2018) menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan hipertensi berbasis komunitas dengan monitoring berkelanjutan mampu meningkatkan kontrol tekanan darah dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Oleh karena itu, continuity of care menjadi komponen penting dalam model kolaborasi perawat komunitas, puskesmas, dan keluarga dalam tindak lanjut kasus hipertensi melalui Posbindu.

G. Penutup

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang memerlukan pengelolaan jangka panjang karena berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Pengendalian hipertensi memerlukan pendekatan komprehensif melalui deteksi dini, edukasi kesehatan, perubahan gaya hidup, monitoring rutin, serta dukungan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Posbindu PTM berperan penting sebagai pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam mendukung skrining, pemantauan faktor risiko, edukasi kesehatan, dan tindak lanjut kasus hipertensi. Keberhasilan pengendalian hipertensi melalui Posbindu sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara perawat komunitas, puskesmas, kader kesehatan, dan keluarga.

Perawat komunitas berperan sebagai edukator, care coordinator, dan fasilitator dalam tindak lanjut pasien hipertensi, sedangkan puskesmas menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Keluarga juga berperan sebagai sistem pendukung utama dalam menjaga kepatuhan pengobatan dan perubahan gaya hidup sehat pasien.

Kolaborasi yang terintegrasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat mencerminkan penerapan interprofessional collaboration dan continuity of care dalam pelayanan kesehatan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan hipertensi dilakukan secara berkesinambungan mulai dari skrining di Posbindu hingga monitoring pasien di rumah. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dan pelayanan kesehatan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian hipertensi di Indonesia.

H. Referensi

- Adler, A. J., Laar, A. K., Kotoh, A. M., Legido-Quigley, H., Perel, P., Lampitey, P., & Lange, I. L. (2020). Barriers and facilitators to the implementation of a community-based hypertension improvement project in Ghana: a qualitative study of ComHIP. *BMC Health Services Research*, 20(1), 67. <https://doi.org/10.1186/S12913-019-4774-X>
- Alvarez, C., Ibe, C., Dietz, K., Carrero, N. D., Avornu, G., Turkson-Ocran, R.-A., Bhattarai, J., Crews, D., Lipman, P. D., & Cooper, L. A. (2022). Development and Implementation of a Combined Nurse Care Manager and Community Health Worker Training Curriculum to Address Hypertension Disparities. *Journal of Ambulatory Care Management*, 45(3), 230–241. <https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000422>
- Antari, L. P. J., Kamaryati, N. P., & Krisnandari, A. A. I. W. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Self Care Management Pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukawati I. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 4(12), 5381–5396. <https://doi.org/10.33024/MAHESA.V4I12.15658>
- Ayaturahmi, A., Mahmudah, R., & Tasalim, R. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga dan Peran Perawat Terhadap Motivasi Pengendalian Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(4), 284–294. <https://doi.org/10.54259/SEHATRAKYAT.V1I4.1102>
- Bhattarai, S., Skovlund, E., Shrestha, A., Mjølstad, B. P., Åsvold, B. O., & Sen, A. (2024). Impact of a community health worker led intervention for improved blood pressure control in urban Nepal: an open-label cluster randomised controlled trial. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100461>
- Burnier, M., & Egan, B. M. (2019). Adherence in Hypertension: A Review of Prevalence, Risk Factors, Impact, and Management. *Circulation Research*, 124(7), 1124–1140. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313220>;WGROUP:STRING:PUBLICATION
- Dennison, C. R., & Hill, M. N. (2005). *The role of nurses and nurse practitioners in hypertension management* (pp. 587–600). CRC Press. <https://pure.johnshopkins.edu/en/publications/the-role-of-nurses-and-nurse-practitioners-in-hypertension-manage/>
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. (2003). *Family nursing: research, theory, & practice* (5th ed.). Prentice Hall. https://catalog.nlm.nih.gov/discovery/fulldisplay/alma9911401583406676/01NLM_INST:01NLM_INST

- Gleason-Comstock, J., Mozeb, G., & Louis, C. (2022). Using the cardiovascular risk profile in a community heart health outreach intervention: Implications for primary care. *Annals of Family Medicine*, 20(20 Suppl 1). <https://doi.org/10.1370/AFM.20.S1.2961>
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 327(7425), 1219–1221. <https://doi.org/10.1136/BMJ.327.7425.1219>
- Han, D., Nie, L., Wang, M., Wu, J., Yan, S., Li, F., Qian, Y., & Xi, Y. (2024). Study on the management model of elderly patients with hypertension by multidisciplinary comprehensive management team of tertiary hospital collaborated with community pharmacists. *China Pharmacy*, 35(16), 2033–2037. <https://doi.org/10.6039/j.issn.1001-0408.2024.16.17>
- Ibe, C. A., Alvarez, C., Carson, K. A., Marsteller, J. A., Crews, D. C., Dietz, K. B., Greer, R. C., Bone, L., Cooper, L. A., Ahima, R., Antoine, D. G., Avornu, G. D., Bhattarai, J., Boonyasai, R. T., Charleston, J., Chung, S., Cort, M., Daumit, G. L., Eyer, T., ... Zeren, K. L. (2021). Social Determinants of Health as Potential Influencers of a Collaborative Care Intervention for Patients with Hypertension. *Ethnicity & Disease*, 31(1), 47–56. <https://doi.org/10.18865/ED.31.1.47>
- Ingenhoff, R., Nandawula, J., Siddharthan, T., Ssekitoleko, I., Munana, R., Bodnar, B. E., Weswa, I., Kirenga, B. J., Mutungi, G., van der Giet, M., Kalyesubula, R., & Knauf, F. (2022). Effectiveness of a community health worker-delivered care intervention for hypertension control in Uganda: study protocol for a stepped wedge, cluster randomized control trial. *Trials*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S13063-022-06403-9>
- Kamaryati, N. P., & Malathum, P. (2020). Family Support: A Concept Analysis. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 24(3), 403–411. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRJNR/article/view/217961>
- Kemenkes. (2021). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Lanjutan Usia dan Posbindu PTM Terintegrasi*. Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/62>
- Kemenkes. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023*. <https://www.slideshare.net/slideshow/survei-kesehatan-indonesia-ski-tahun-2023/269424965>
- Kemenkes, Pub. L. 19, Kementerian Kesehatan, RI (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312837/permenkes-no-19-tahun-2024>
- Kirkland, E. B., Dericke, D., Bays, C. C., Wallinger, C., McElligott, J., Slaughter, S., & Moran, W. P. (2023). Dissemination of Remote Patient Monitoring: An

- Academic-Community Primary Care Partnership in South Carolina. *Journal of Public Health Management and Practice : JPHMP*, 29(4), 516–524. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001593>
- Lalonde, L., Goudreau, J., Hudon, E., Lussier, M. T., Duhamel, F., Bélanger, D., Lévesque, L., & Martin, E. (2012). Priorities for action to improve cardiovascular preventive care of patients with multimorbid conditions in primary care--a participatory action research project. *Family Practice*, 29(6), 733–741. <https://doi.org/10.1093/FAMPRA/CMS021>
- Li, B. (2025). Unintended Consequences of Follow-Up Care: Patient Experiences with Hypertension Management in Chinese Community Nursing. *Journal of Community Health Nursing*, 42(3), 169–184. <https://doi.org/10.1080/07370016.2025.2462006>
- Li, X., Li, T., Chen, J., Xie, Y., An, X., Lv, Y., & Lin, A. (2019). A WeChat-Based Self-Management Intervention for Community Middle-Aged and Elderly Adults with Hypertension in Guangzhou, China: A Cluster-Randomized Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/IJERPH16214058>
- Marcelline, O. D., Bertin, T. S. N., Marius, B. B. B. O., & Dismant, H. (2026). Factors Associated with Non-Adherence to Clinical Follow-Up Among Hypertensive Patients in Abomey-Calavi, Benin: A Cross-Sectional Study. *HEALTH RESEARCH IN AFRICA*, 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18272176>
- PERHI. (2021). *Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2021*. Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia.
- Pramadaningati, I., Nurbadriyah, W. D., & Fikriana, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Dukungan Keluarga terhadap Self Care Manajement pada Penderita Hipertensi dengan Pendekatan Teori Doreothea E Orem. *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 15(01), 21–23. <https://doi.org/10.35960/VM.V15I01.668>
- Proboningsih, J., Sriyono, S., Ambarwati, R., Wuryaningsih, S. H., & Joeliantina, A. (2025). Optimisation of the role of families of chronic hypertension patients based on the mcmaster model of family functioning in self-care agency. *Jurnal Ners*, 20(2), 173–182. <https://doi.org/10.20473/JN.V20I2.65083>
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). Public Health Nursing : Population-Centered Health Care in the Community. In *Mosby Elsevier* (Vol. 7). Elseiver. https://catalog.nlm.nih.gov/discovery/fulldisplay/alma9913218343406676/01NLM_INST:01NLM_INST
- Tu, Q., Xiao, L. D., Ullah, S., Fuller, J., & Du, H. (2018). Hypertension management for community-dwelling older people with diabetes in Nanchang, China:

- Study protocol for a cluster randomized controlled trial. *Trials*, 19(1).
<https://doi.org/10.1186/s13063-018-2766-5>
- WHO. (2010). *Framework for action on interprofessional education & collaborative practice*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice>
- WHO. (2021). Guideline for The pharmacological tretment of hypertension in addults. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1). World Health Organization.
- WHO. (2023). Global report on hypertension: the race against a silent killer. In
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062>.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062>
- Yandrizal, Y., Machmud, R., Noer, M., Dasman, H., Rahajeng, E., Suryani, D., & Pramudho, P. A. (2018). Policy and role analysis integrated health education centers for non-communicable diseases toward the prevention and controlling of hypertension. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 9, 705. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.01920.4>
- Zheng, W., Hua, L. L., Tan, J., Zhang, J. S., Liang, Y., Pan, J., Yu, M. X., & Gan, J. W. (2025). Development and evaluation of an IoT-based hypertension surveillance system in community health settings: a mixed-methods quasi-experimental study protocol. *BMC Health Services Research*, 25(1).
<https://doi.org/10.1186/S12913-025-13562-3>
- Zhu, X., Wong, F. K. Y., & Wu, L. H. (2014). Development and evaluation of a nurse-led hypertension management model in a community: a pilot randomized controlled trial. *International Journal of Clinical and Experimental Medicine*, 7(11), 4369.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4276214/>

CHAPTER 7

EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN HIPERTENSI BERBASIS KOMUNITAS

Hartin Suidah, S.Kep., Ns., M.Kep

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling banyak ditemukan di dunia dan menjadi penyebab utama meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan penyakit tidak menular di berbagai negara. Karena perkembangan penyakitnya sering berlangsung tanpa gejala yang jelas, hipertensi sering terlambat diketahui oleh penderitanya, (WHO, 2023). Hipertensi dengan gejala meningkatnya tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg yang berlangsung secara terus-menerus. Penyakit ini sering disebut sebagai *silent killer* karena banyak penderita tidak menyadari dirinya mengalami hipertensi sampai muncul komplikasi berat seperti stroke, gagal ginjal, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Secara global, peningkatan jumlah penderita hipertensi dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat modern. Konsumsi makanan olahan yang tinggi natrium, aktivitas fisik yang rendah, peningkatan angka obesitas, kebiasaan merokok, serta tekanan psikologis akibat gaya hidup perkotaan menjadi faktor utama yang mempercepat peningkatan kasus hipertensi. Selain itu, bertambahnya populasi usia lanjut di berbagai negara juga menjadi faktor yang menyebabkan prevalensi hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. WHO melaporkan bahwa lebih dari satu miliar penduduk dunia hidup dengan hipertensi dan sebagian besar berada di negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan (WHO, 2023).

Hipertensi tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan kesehatan suatu negara. Tingginya angka kejadian hipertensi menyebabkan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan jangka panjang dan pembiayaan pengobatan penyakit kronis. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem kesehatan global karena hipertensi memerlukan pengendalian secara berkelanjutan melalui deteksi dini, perubahan perilaku, serta kepatuhan terhadap pengobatan dan pemeriksaan kesehatan rutin (Mills et al., 2020).

Di Indonesia hipertensi masih menjadi salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi yang cukup tinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi hipertensi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi tantangan besar bagi sistem pelayanan kesehatan. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa hipertensi banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mulai terjadi peningkatan kasus pada usia produktif. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa tekanan darah secara berkala menyebabkan banyak penderita hipertensi baru mengetahui penyakitnya setelah mengalami komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Permasalahan hipertensi di Indonesia juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Pola makan tinggi garam, makanan instan, rendah konsumsi buah dan sayur, kurang olahraga, serta tingginya angka perokok menjadi faktor yang memperbesar risiko hipertensi. Di samping itu, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa daerah turut memengaruhi keberhasilan pengendalian hipertensi di masyarakat (Nuraini, 2019).

Tingginya angka kejadian hipertensi tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan dan perawatan komplikasi penyakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, (Kemenkes, 2019). Besarnya dampak hipertensi terhadap kesehatan masyarakat menyebabkan pemerintah Indonesia terus mengembangkan program pengendalian penyakit tidak menular melalui pendekatan promotif dan preventif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko hipertensi serta mendorong deteksi dini dan pengendalian tekanan darah secara rutin (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dalam pelaksanaan program Posbindu masih ditemukan berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sehingga diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan untuk mencapai keberhasilan program yang dijalankan, (Risnawati & Sari, 2025). Pada topik ini akan diuraikan tentang : Pendahuluan, Keperawatan komunitas dalam pencegahan hipertensi, Program pencegahan hipertensi berbasis komunitas, evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas, Inovasi dan pengembangan program, Instrumen evaluasi.

B. Keperawatan Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi

Keperawatan komunitas merupakan salah satu bentuk pelayanan keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan melibatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Dalam konteks penyakit tidak menular, keperawatan komunitas memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi karena hipertensi merupakan masalah kesehatan yang prevalensinya terus meningkat di masyarakat (Risnawati & Sari, 2025).

Pencegahan hipertensi melalui pendekatan keperawatan komunitas dilakukan dengan menitikberatkan pada perubahan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat. Perawat komunitas berperan sebagai edukator yang memberikan informasi mengenai faktor risiko hipertensi, pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, pengendalian stres, penghentian kebiasaan merokok, serta pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Edukasi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong perilaku pencegahan hipertensi secara mandiri (Widodo et al., 2025).

Selain sebagai edukator, perawat komunitas juga berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembentukan kelompok peduli hipertensi, pelatihan kader kesehatan, penyelenggaraan Posbindu PTM, pendampingan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Keterlibatan kader kesehatan dan keluarga dinilai efektif dalam membantu masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan meningkatkan kepatuhan dalam pengendalian tekanan darah (Siregar, 2025). Intervensi keperawatan komunitas dalam pencegahan hipertensi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan kesehatan, senam hipertensi, terapi relaksasi, edukasi diet DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*), serta pendampingan manajemen diri pada penderita hipertensi. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan perilaku hidup sehat dan membantu menurunkan tekanan darah pada masyarakat yang berisiko hipertensi maupun penderita hipertensi (Citra & Lismayanti, 2025).

Program keperawatan komunitas juga menekankan pentingnya deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan tekanan darah secara berkala di masyarakat. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Kegiatan skrining kesehatan yang dilakukan oleh perawat komunitas bersama kader kesehatan di Posbindu PTM dapat membantu menemukan kasus

hipertensi lebih awal sehingga penanganan dapat segera dilakukan (Widodo et al., 2025).

Dalam pelaksanaan program pencegahan hipertensi, perawat komunitas juga memiliki peran sebagai koordinator dan kolaborator. Perawat bekerja sama dengan puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas (Sari, Rekawati, & Widyatuti, 2022). Keberhasilan keperawatan komunitas dalam pencegahan hipertensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan masyarakat, dukungan keluarga, partisipasi kader kesehatan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Dukungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan masyarakat dalam menjalankan diet hipertensi, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Oleh karena itu, pendekatan keluarga menjadi bagian penting dalam intervensi keperawatan komunitas (Liawati, Purnairawan, & Ihsan, 2023). Selain itu, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan dalam praktik keperawatan komunitas. Penggunaan media digital dan aplikasi kesehatan membantu perawat dalam melakukan edukasi, monitoring tekanan darah, serta pendampingan kesehatan masyarakat secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis komunitas dapat meningkatkan akses informasi kesehatan dan memperkuat upaya pencegahan hipertensi di masyarakat (Widodo et al., 2025). Dengan demikian, keperawatan komunitas memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pencegahan hipertensi melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat. Melalui edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor, perawat komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan hipertensi dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya.

C. Program Pencegahan Hipertensi Berbasis Komunitas

Program pencegahan hipertensi berbasis komunitas merupakan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan hipertensi melalui pendekatan promotif dan preventif. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko hipertensi, mendorong perilaku hidup sehat, serta memperkuat deteksi dini dan pengendalian tekanan darah di lingkungan masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat (Risnawati & Sari, 2025).

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Banyak penderita hipertensi tidak menyadari kondisi yang dialaminya karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Oleh karena itu, program pencegahan berbasis komunitas menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin dan penerapan gaya hidup sehat (Aling et al., 2025).

Salah satu bentuk program pencegahan hipertensi berbasis komunitas di Indonesia adalah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Posbindu PTM merupakan kegiatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Kegiatan Posbindu meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran indeks massa tubuh, pemeriksaan lingkar perut, edukasi kesehatan, konseling kesehatan, serta pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular termasuk hipertensi (Aling et al., 2025). Program pencegahan hipertensi berbasis komunitas umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah kesehatan masyarakat, perencanaan intervensi, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi program. Pada tahap identifikasi masalah, tenaga kesehatan bersama masyarakat melakukan pengkajian terhadap faktor risiko hipertensi yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyusunan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan kader kesehatan, senam hipertensi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pendampingan keluarga (Widodo et al., 2025). Edukasi kesehatan menjadi salah satu komponen utama dalam program pencegahan hipertensi berbasis komunitas. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab, faktor risiko, komplikasi, serta cara pencegahan hipertensi. Materi edukasi biasanya mencakup pentingnya mengurangi konsumsi garam, menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik secara rutin, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres dengan baik. Program edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku hidup sehat (Darmawan, 2025). Selain edukasi kesehatan, pemberdayaan kader kesehatan juga menjadi bagian penting dalam program berbasis komunitas. Kader kesehatan berperan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan skrining tekanan darah, memberikan penyuluhan kesehatan, memotivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posbindu, serta melakukan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala. Pelatihan dan pendampingan kader kesehatan terbukti mampu meningkatkan efektivitas program pencegahan hipertensi di masyarakat (Ginting, 2024). Program pencegahan

hipertensi berbasis komunitas juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung pengendalian hipertensi (Irawan et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, program berbasis komunitas sering menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah kader aktif. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap pemeriksaan kesehatan hanya diperlukan ketika sudah sakit sehingga minat untuk melakukan deteksi dini hipertensi masih rendah (Aling et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan hipertensi berbasis komunitas memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan cakupan pemeriksaan tekanan darah, serta perubahan perilaku hidup sehat. Program yang melibatkan masyarakat secara aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya sendiri (Pradana & Iqbal, 2025). Dengan demikian, program pencegahan hipertensi berbasis komunitas merupakan strategi penting dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular di masyarakat. Melalui edukasi kesehatan, pemberdayaan kader, keterlibatan keluarga, serta kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menurunkan angka kejadian hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

D. Evaluasi Program Pencegahan Hipertensi Berbasis Komunitas

Evaluasi program kesehatan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai keberhasilan, efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu program kesehatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program sehingga dapat diketahui apakah tujuan program telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam bidang kesehatan masyarakat, evaluasi sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan program, serta pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang (Nurhayati & Suprpto, 2022). Evaluasi program kesehatan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, kelemahan, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan program kesehatan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan dan pengelola program dalam menentukan strategi perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Evaluasi program kesehatan dapat dilakukan pada berbagai tahap pelaksanaan program. Secara umum, evaluasi dibedakan menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama program berlangsung dengan tujuan memantau pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki hambatan yang ditemukan selama proses program. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan dan dampaknya terhadap masyarakat (Sari & Wibowo, 2023). Dalam pelaksanaannya, evaluasi program kesehatan memiliki beberapa fungsi penting, menurut Rachman (2021) yaitu :

1. Fungsi pengendalian

Dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditentukan.

2. Fungsi perbaikan program

Digunakan untuk mengetahui kekurangan program sehingga dapat dilakukan penyempurnaan

3. Fungsi pengembangan kebijakan

Digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran,

4. Fungsi pertanggungjawaban

Digunakan untuk mempertanggungjawaban dengan menunjukkan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat maupun pihak terkait

Dalam bidang kesehatan masyarakat, evaluasi program sering menggunakan pendekatan input, proses, output, dan outcome. Berikut penjelasan mengenai pendekatan input, proses, output, dan outcome menurut Handayani et al (2024) :

1. Evaluasi input

Menilai sumber daya yang digunakan dalam program seperti tenaga kesehatan, dana, sarana, dan kebijakan pendukung.

2. Evaluasi proses

Menilai bagaimana pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi output

Menilai hasil langsung dari program, misalnya jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan atau kegiatan edukasi.

4. Evaluasi outcome

Menilai dampak jangka panjang program terhadap perubahan perilaku dan status kesehatan masyarakat

Sedangkan salah satu model evaluasi yang banyak digunakan dalam program kesehatan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model ini dikembangkan untuk membantu mengevaluasi program secara menyeluruh menurut Prasetyo & Lestari (2021) sebagai berikut :

1. Evaluasi context

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program.

2. Evaluasi input

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kesiapan sumber daya yang mendukung program.

3. Evaluasi process

Evaluasi ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan program

4. Evaluasi product

Evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil dan dampak program terhadap sasaran masyarakat

Dalam program pencegahan hipertensi berbasis komunitas, evaluasi program kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui efektivitas kegiatan promotif dan preventif yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan Posbindu PTM, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan tekanan darah rutin, pelatihan kader kesehatan, dan keterlibatan masyarakat dalam program. Melalui evaluasi, tenaga kesehatan dapat mengetahui apakah program mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan perilaku hidup sehat, dan menurunkan faktor risiko hipertensi di masyarakat (Risnawati & Sari, 2025). Keberhasilan evaluasi program kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan data yang akurat, keterlibatan tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan institusi kesehatan. Data yang lengkap dan valid sangat penting agar hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi program secara nyata. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga membantu meningkatkan kualitas program kesehatan berbasis komunitas (Widodo et al., 2025).

Di era perkembangan teknologi, evaluasi program kesehatan juga mulai memanfaatkan sistem digital dan aplikasi kesehatan untuk memudahkan pengumpulan data, monitoring program, dan analisis hasil kegiatan kesehatan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi membantu tenaga kesehatan melakukan evaluasi secara lebih cepat, efektif, dan akurat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik (Handayani et al., 2024). Dengan demikian, evaluasi program kesehatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk

menilai keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan strategi kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui evaluasi yang baik, program kesehatan diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh.

E. Inovasi Dan Pengembangan Program

Inovasi dan pengembangan program dalam pencegahan hipertensi berbasis komunitas merupakan proses pembaruan strategi pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif. Inovasi diperlukan karena hipertensi menjadi salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi yang terus meningkat sehingga membutuhkan pendekatan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pengembangan program dilakukan agar kegiatan pencegahan hipertensi tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada perubahan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat secara aktif (World Health Organization, 2023).

Salah satu inovasi yang banyak dikembangkan adalah penguatan program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) yang sudah dijalankan. Posbindu PTM tidak hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan tekanan darah, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Kegiatan Posbindu meliputi skrining faktor risiko hipertensi, konsultasi kesehatan, edukasi pola makan sehat, pemantauan berat badan, senam hipertensi, serta pendampingan masyarakat berisiko tinggi hipertensi. Pengembangan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pengendalian faktor risiko hipertensi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Selain pengembangan Posbindu, inovasi program juga dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga (*family centered care*). Dalam pendekatan ini, keluarga dilibatkan secara aktif dalam mendukung anggota keluarga yang memiliki risiko hipertensi. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pendampingan pola makan rendah garam, pengawasan aktivitas fisik, pengingat pemeriksaan tekanan darah, serta dukungan emosional untuk menjaga kepatuhan terhadap perilaku hidup sehat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dapat meningkatkan keberhasilan program pencegahan hipertensi karena keluarga menjadi sistem pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Irawan et al., 2024).

Inovasi lainnya adalah penggunaan teknologi digital dalam program kesehatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan aplikasi kesehatan, media sosial, dan sistem pencatatan digital dalam monitoring hipertensi di komunitas. Teknologi digital digunakan untuk pencatatan

tekanan darah, pengingat kontrol kesehatan, penyebaran edukasi kesehatan melalui media sosial, serta konsultasi daring dengan tenaga kesehatan. Penggunaan media digital dinilai efektif dalam meningkatkan akses informasi kesehatan dan memperluas jangkauan edukasi masyarakat, terutama pada kelompok usia produktif (Handayani et al., 2024).

Program inovatif lain yang mulai dikembangkan adalah pembentukan komunitas peduli hipertensi di lingkungan masyarakat. Komunitas ini berfungsi sebagai kelompok pendukung yang membantu masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui kegiatan bersama, seperti senam rutin, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gizi, dan kampanye pengurangan konsumsi garam. Kegiatan kelompok masyarakat dinilai mampu meningkatkan motivasi dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan karena dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan (Darmawan, 2025).

Pengembangan program juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat. Kader kesehatan diberikan pelatihan mengenai deteksi dini hipertensi, penggunaan alat tensimeter digital, edukasi kesehatan, serta teknik komunikasi efektif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Keberadaan kader kesehatan yang terlatih membantu tenaga kesehatan dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan keberlanjutan program di tingkat komunitas (Ginting, 2024).

Selain itu, beberapa daerah mulai mengembangkan inovasi melalui integrasi program kesehatan dengan kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Contohnya adalah penyuluhan hipertensi yang dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan, pertemuan warga, kegiatan PKK, atau acara olahraga masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena masyarakat merasa lebih nyaman dan mudah menerima edukasi kesehatan dalam kegiatan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka (Widodo et al., 2025).

Pengembangan program pencegahan hipertensi berbasis komunitas juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, puskesmas, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama dalam menyediakan sumber daya, fasilitas kesehatan, media edukasi, serta dukungan kebijakan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor membantu memperkuat keberlanjutan program dan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat (Sari, Rekawati, & Widyatuti, 2022).

Pelaksanaan program inovasi masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi kesehatan digital. Oleh karena itu, evaluasi program secara rutin sangat diperlukan

agar inovasi yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah setempat. Dengan demikian, inovasi dan pengembangan program pencegahan hipertensi berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui penguatan Posbindu PTM, pemanfaatan teknologi digital, pendekatan keluarga, pemberdayaan kader kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor, program pencegahan hipertensi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat dan menurunkan angka kejadian hipertensi secara berkelanjutan.

F. Instrument evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas

Tabel 6.1
Identitas Program

Komponen	Keterangan
Nama Program	Program Pencegahan Hipertensi Berbasis Komunitas
Lokasi Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan	
Penanggung Jawab	
Jumlah Peserta	
Nama Evaluator	

Tabel 6.2
Evaluasi Input

No	Komponen yang Dinilai	Ya	Tidak	Keterangan
1	Tersedia tenaga kesehatan			
2	Tersedia kader kesehatan aktif			
3	Tersedia alat tensimeter			
4	Tersedia media edukasi kesehatan			
5	Tersedia tempat kegiatan Posbindu			
6	Ada dukungan dari puskesmas			
7	Ada dukungan tokoh masyarakat			
8	Tersedia dana operasional program			

Tabel 6.3
Evaluasi Proses

No	Kegiatan Program	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Keterangan
1	Pemeriksaan tekanan darah rutin			
2	Penyuluhan kesehatan hipertensi			
3	Senam/aktivitas fisik bersama			
4	Konseling pola makan sehat			
5	Pelatihan kader kesehatan			
6	Kegiatan monitoring peserta hipertensi			
7	Kunjungan rumah bagi kelompok risiko tinggi			
8	Dokumentasi kegiatan program			

Tabel 6.4
Evaluasi Output

No	Indikator Output	Target	Hasil	Keterangan
1	Jumlah peserta hadir			
2	Jumlah masyarakat diperiksa tekanan darah			
3	Jumlah peserta mendapat edukasi			
4	Jumlah kader yang aktif			
5	Jumlah kasus hipertensi terdeteksi			
6	Jumlah peserta mengikuti senam kesehatan			

Tabel 6.5
Evaluasi Outcome

No	Indikator Outcome	Meningkat	Tetap	Menurun	Keterangan
1	Pengetahuan masyarakat tentang hipertensi				
2	Kesadaran cek tekanan darah rutin				
3	Perilaku hidup sehat masyarakat				
4	Kepatuhan diet rendah garam				

5	Aktivitas fisik masyarakat				
6	Jumlah masyarakat dengan tekanan darah terkontrol				

Tabel 6.6
Kesimpulan Hasil Evaluasi

Komponen	Hasil Evaluasi
Kekuatan Program	
Hambatan Program	
Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Efektivitas Program	

Tabel 6.7
Rekomendasi Tindak Lanjut (pilih sesuai hasil evaluasinya)

No	Jenis Rekomendasi	Centang Rekomendasi yang dipilih
1	Meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat tentang hipertensi.	
2	Memperkuat peran kader kesehatan dan Posbindu PTM.	
3	Meningkatkan pemeriksaan tekanan darah rutin.	
4	Mengembangkan inovasi program berbasis digital dan keluarga.	

Tabel 6.8
Instrumen Kuesioner Pengetahuan Masyarakat Tentang Hipertensi

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1	Hipertensi disebut tekanan darah tinggi		
2	Merokok dapat meningkatkan risiko hipertensi		
3	Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan hipertensi		
4	Olahraga teratur membantu mencegah hipertensi		
5	Hipertensi dapat menyebabkan stroke		
6	Tekanan darah perlu diperiksa secara rutin		
7	Hipertensi selalu menimbulkan gejala		

8	Stres dapat meningkatkan tekanan darah		
9	Buah dan sayur membantu menjaga tekanan darah		
10	Hipertensi hanya terjadi pada lansia		

Interpretasi Nilai

1. 8–10 benar = Pengetahuan baik
2. 5–7 benar = Pengetahuan cukup
3. <5 benar = Pengetahuan kurang

Tabel 6.9
Instrumen Lembar Observasi Perilaku Hidup Sehat

No	Perilaku	Ya	Tidak
1	Mengurangi konsumsi garam		
2	Berolahraga minimal 3x/minggu		
3	Tidak merokok		
4	Memeriksa tekanan darah rutin		
5	Mengonsumsi buah dan sayur		
6	Menghindari stres berlebihan		

G. Kesimpulan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan angka kesakitan, kematian, serta beban ekonomi masyarakat. Tingginya prevalensi hipertensi menunjukkan bahwa upaya pengendalian penyakit tidak menular tidak dapat hanya dilakukan melalui pelayanan kuratif, tetapi harus diperkuat melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas. Program pencegahan hipertensi berbasis komunitas menjadi strategi penting karena mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri.

Keperawatan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program pencegahan hipertensi melalui edukasi kesehatan, deteksi dini, pemberdayaan kader kesehatan, pendampingan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran terhadap faktor risiko hipertensi dan menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan.

Program seperti Posbindu PTM terbukti menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi kesehatan, serta pengendalian faktor risiko hipertensi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kader aktif, dan belum optimalnya pendampingan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi program kesehatan menjadi bagian yang sangat penting untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan langkah perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Inovasi program melalui pemanfaatan teknologi digital, pendekatan berbasis keluarga, penguatan kader kesehatan, pembentukan komunitas peduli hipertensi, serta integrasi program kesehatan dengan kegiatan sosial masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan hipertensi berbasis komunitas. Dengan dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan partisipasi aktif masyarakat, program pencegahan hipertensi diharapkan mampu menurunkan angka kejadian hipertensi, mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

H. Referensi

- Aling, Y. N. M., Wowor, R. E., & Rumayar, A. A. (2025). Gambaran Pelaksanaan Program Posbindu PTM dalam Mencegah Kasus Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Tikala Baru Kota Manado. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 4425–4437.
- Citra, A. Y., & Lismayanti, L. (2025). Efektivitas Intervensi Keperawatan Komunitas dalam Menurunkan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 787–795.
- Darmawan, D. (2025). *Edukatif Berbasis Komunitas untuk Pencegahan dan Penanganan Hipertensi*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2).
- Ginting, A. (2024). *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posbindu dalam Pengendalian Hipertensi*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia*, 3(3), 67–72.
- Handayani, F., Nugroho, H., & Utami, R. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(1), 11–19.
- Irawan, A., Fransiska, W., Putri, A. L. S. K., & Rohmah, R. A. N. (2024). *Family Support Empowerment sebagai Strategi Pencegahan dan Penatalaksanaan*

Hipertensi. Perawat Mengabdikan (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 3(2).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Hipertensi Penyakit Paling Banyak Didap Masyarakat. Diakses pada 13 Mei 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kemenkes RI.

Liawati, N., Purnairawan, Y., & Ihsan, R. N. (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Hipertensi pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan*, 16(1), 37–44.

Mills, K. T., Stefanescu, A., & He, J. (2020). The Global Epidemiology of Hypertension. *Nature Reviews Nephrology*, 16(4), 223–237.

Nuraini, B. (2019). Risk Factors of Hypertension. *Jurnal Majority*, 8(1), 10–19.

Nurhayati, N., & Suprpto, S. (2022). *Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Preventif dan Promotif*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 120–128.

Pradana, F. K., & Iqbal, M. (2025). *Pemberdayaan Kader Posbindu dalam Pencegahan Hipertensi melalui Program Hipertensi NO! (No Over Pressure) di Dusun Rowosari Desa Meteseh*. PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat), 3(1), 557–565.

Prasetyo, B., & Lestari, Y. (2021). Penerapan Model CIPP dalam Evaluasi Program Kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 101–109.

Rachman, A. (2021). *Manajemen dan Evaluasi Program Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Risnawati, K., & Sari, N. P. (2026). Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi: Telaah Issue dan Trend Intervensi Berbasis Komunitas di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1).

Sari, D. P., & Wibowo, A. (2023). *Pendekatan Evaluasi Formatif dan Sumatif pada Program Kesehatan Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Kesehatan Global*, 6(1), 44–52.

Sari, N. L. P. D. Y., Rekawati, E., & Widyatuti. (2022). *Implementasi Program Keperawatan Komunitas “Langkah Mandiri” untuk Lansia Hipertensi*. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 6(2), 325–331.

Siregar, S. P. (2025). Pengaruh Edukasi Keperawatan Berbasis Keluarga terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Komunitas. *Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer*, 6(1).

- Widodo, G. G., Setyoningrum, U., Wibowo, A., et al. (2025). Pendampingan Pencegahan Hipertensi pada Kader Posyandu dengan Optimalisasi Deteksi Dini Risiko Berbasis Digital. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 5(1).
- Widodo, W., Rochmayanti, & Wulansari, N. (2025). *Penyuluhan Pencegahan Hipertensi Berbasis Diagnosis Keperawatan pada Komunitas di Desa Cimandala*. Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(6), 555–560.
- World Health Organization Hypertension Report. (2023). *Hypertension Report*. Geneva: WHO.

PROFIL PENULIS



Sukmah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom., menyelesaikan Program studi Magister Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pengalaman kerja Penulis pernah bekerja sebagai staff bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Saat ini sebagai Dosen di Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukmafitriani@fk.unsri.ac.id.



Ns. Maulina, M.Kep., Sp.Kep.Kom, Lahir di Banda Aceh, 02 Februari 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala lulus tahun 2006 kemudian melanjutkan program profesi pada Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala lulus Tahun 2008, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 lulus tahun 2013 dan spesialis Keperawatan

Komunitas pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 menjadi tenaga pengajar non PNS di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Saat ini penulis bekerja di Universitas Syiah Kuala tepatnya di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala sebagai dosen tetap PNS dan mengampu mata kuliah Keperawatan Konsep dan Agregat Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku *Proses Keperawatan Dan Soal Uji Kompetensi Ners* (2020), *Keperawatan Agregat Komunitas* (2024), *Buku Ajar Keperawatan Komunitas* (2024), publikasi ilmiah jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada terakreditasi SINTA 4-6 dan Q3, selain itu penulis mengikuti seminar *Aceh International NursingConference 4* (2021) dan *Aceh International NursingConference 5* (2022). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulina@usk.ac.id

Motto: "Keep doing your best and never give up"

PROFIL PENULIS



Ns. Supriadi, S.Kep., M.KM., Lahir di Sulawesi Barat 05 Desember 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, dan Ners STIKES Bina Generasi tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mega Buana Palopo dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di RSUD Kabupaten dan Klinik Mifta yang berada di Akbupaten salah satu di Sulawesi Barat, **2009-2020**. Saat ini penulis bekerja di STIKES Marendeng Majene mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: supriadi.ufhy.lnn@gmail.com



Ardila Lailatul Barik, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Jember, 07 Agustus 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S-1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Berangkat dari rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pendidikan keperawatan, penulis melanjutkan studi magister di Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada Tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai tenaga freelance enumerator untuk beberapa penelitian baik penelitian dari Kementerian Kesehatan RI maupun lembaga penelitian independen. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D-III Keperawatan, Universitas Bondowoso mengampu mata kuliah komunitas dan keluarga serta mata kuliah keperawatan dasar lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku maupun publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ardilabarik@gmail.com

PROFIL PENULIS



Antok Nurwidi Antara, S.Kep. Ns. M.Kep. Lahir di Yogyakarta, 01 Januari 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) , Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010, sebagai dosen di Prodi Diploma 3 Keperawatan STIKES Wira Husada Yogyakarta sampai tahun 2012, kemudian magang dosen di Universitas Airlangga selama 5 bulan di tahun 2012, pernah menjabat sebagai ketua program studi S1 Keperawatan dan Ners STIKES Wira Husada Yogyakarta tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya menjadi dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan Ners STIKES Wira Husada Yogyakarta sampai sekarang tahun 2026. Saat ini penulis bekerja di STIKES Wira Husada Yogyakarta mengampu mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas, Agregat Keperawatan Komunitas, Keperawatan Gerontik, Kewirausahaan dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail antokantara1212@gmail.com
Motto: "Berusaha dan berdoa, agar hidup sukses, lancar, barokah semua"



Yourisna Pasambo, Ners, M.Kes, lahir di Toraja Utara, pada tanggal 06 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2002-2007. Penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Biomedik (Fisiologi) Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2012. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan pada Program Studi S3 Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran, menulis buku, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yourisna@poltekkes-manado.ac.id.

PROFIL PENULIS



Hartin Suidah, S.Kep., Ners., M.Kes., Penulis sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Akper dan Stikes Dian Husada Mojokerto. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Stikes Dian Husada, melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan di UNS Solo Jawa Tengah dan sekarang sedang menempuh S3 di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Penulis aktif dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Bidang keilmuan yang ditekuni adalah keperawatan komunitas, gerontic, jiwa dan keperawatan keluarga. Penulis aktif menyusun buku, modul praktikum, serta instrumen evaluasi kompetensi mahasiswa dan mempunyai peran dalam pengembangan metode pembelajaran inovatif. Pengalaman praktik dan pengabdian masyarakat yang dimiliki mencakup penanganan berbagai masalah Kesehatan dan keperawatan. Hal ini memperkuat pendekatan penulis dalam mengintegrasikan teori dan praktik keperawatan secara komprehensif, holistik, dan berbasis bukti. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang Kesehatan dan keperawatan.

Bunga rampai "Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi melalui Posbindu" membahas secara komprehensif peran strategis perawat komunitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis masyarakat. Hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius karena sering kali tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menimbulkan komplikasi berat apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan angka kejadian hipertensi.

Buku ini menguraikan konsep dasar keperawatan komunitas dan masalah hipertensi sebagai landasan dalam memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat. Pembahasan dilanjutkan dengan peran perawat komunitas dalam pencegahan hipertensi melalui Posbindu sebagai salah satu bentuk pelayanan berbasis komunitas yang berfungsi untuk melakukan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular. Melalui Posbindu, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining tekanan darah, pemantauan kesehatan, edukasi, serta arahan tindak lanjut secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Selain itu, bunga rampai ini membahas pengkajian komunitas dan skrining tekanan darah sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi risiko hipertensi di masyarakat. Edukasi kesehatan mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian stres, pembatasan konsumsi garam, serta penerapan gaya hidup sehat menjadi bagian penting yang ditekankan dalam buku ini. Perawat komunitas tidak hanya berperan sebagai pemberi pelayanan, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan penggerak masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat.

Buku ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan kader dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pencegahan hipertensi. Kader kesehatan sebagai mitra perawat komunitas memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan Posbindu, melakukan pemantauan sederhana, memberikan informasi kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatannya. Di samping itu, kolaborasi antara perawat komunitas, Puskesmas, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam tindak lanjut kasus hipertensi agar pelayanan yang diberikan lebih terpadu dan berkesinambungan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas sebagai upaya untuk menilai efektivitas kegiatan Posbindu dan intervensi keperawatan komunitas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan program, hambatan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan agar pencegahan hipertensi di masyarakat berjalan lebih optimal.

Bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, kader Posbindu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan pemahaman bahwa pencegahan hipertensi tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bunga rampai “Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi melalui Posbindu” membahas secara komprehensif peran strategis perawat komunitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis masyarakat. Hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius karena sering kali tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menimbulkan komplikasi berat apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan angka kejadian hipertensi.

Buku ini menguraikan konsep dasar keperawatan komunitas dan masalah hipertensi sebagai landasan dalam memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat. Pembahasan dilanjutkan dengan peran perawat komunitas dalam pencegahan hipertensi melalui Posbindu sebagai salah satu bentuk pelayanan berbasis komunitas yang berfungsi untuk melakukan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular. Melalui Posbindu, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining tekanan darah, pemantauan kesehatan, edukasi, serta arahan tindak lanjut secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Selain itu, bunga rampai ini membahas pengkajian komunitas dan skrining tekanan darah sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi risiko hipertensi di masyarakat. Edukasi kesehatan mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian stres, pembatasan konsumsi garam, serta penerapan gaya hidup sehat menjadi bagian penting yang ditekankan dalam buku ini. Perawat komunitas tidak hanya berperan sebagai pemberi pelayanan, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan penggerak masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat.

Buku ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan kader dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pencegahan hipertensi. Kader kesehatan sebagai mitra perawat komunitas memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan Posbindu, melakukan pemantauan sederhana, memberikan informasi kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatannya. Di samping itu, kolaborasi antara perawat komunitas, Puskesmas, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam tindak lanjut kasus hipertensi agar pelayanan yang diberikan lebih terpadu dan berkesinambungan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas sebagai upaya untuk menilai efektivitas kegiatan Posbindu dan intervensi keperawatan komunitas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan program, hambatan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan agar pencegahan hipertensi di masyarakat berjalan lebih optimal.

Bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, kader Posbindu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan pemahaman bahwa pencegahan hipertensi tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-57-2 (PDF)



9

786347

756572